

Bunga Rampai

PERAN KEPALA RUANGAN

**Dalam Supervisi Klinis Untuk Meningkatkan
Mutu Asuhan Keperawatan**

Ana Fadilah • Asih Purwandari Wahyoe Puspita • Novin Yetiani
Ari Sukma Nela • Nevi Kuspihana Lesmana • Armidayanti

Editor: Damon Wicaksi



BUNGA RAMPAI

PERAN KEPALA RUANGAN DALAM SUPERVISI KLINIS UNTUK MENINGKATKAN MUTU ASUHAN KEPERAWATAN

Penulis:

Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Novin Yetiani, S.Kep., M.Kep.

Ns. Ari Sukma Nela, S. Kep., M.Kep.

Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.

Armidayanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor:

Ns. Damon Wicaksi, SST, M.Kes.



Bunga Rampai Peran Kepala Ruangan dalam Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan

Penulis:

Ana Fadilah, S.Kep., Ns., M.Kep.

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Novin Yetiani, S.Kep., M.Kep.

Ns. Ari Sukma Nela, S. Kep., M.Kep.

Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.

Armidayanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor: Ns. Damon Wicaksi, SST., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-15-2

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul "Peran Kepala Ruangan dalam Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan." Buku ini disusun sebagai salah satu referensi akademik dan praktis dalam bidang manajemen keperawatan, khususnya terkait peran kepala ruangan dalam pelaksanaan supervisi klinis di pelayanan kesehatan. Supervisi klinis merupakan bagian penting dalam upaya menjaga mutu pelayanan, meningkatkan kompetensi perawat, memperkuat budaya keselamatan pasien, serta memastikan pelaksanaan asuhan keperawatan berjalan sesuai standar profesional dan etika keperawatan.

Buku ini membahas secara sistematis konsep dasar manajemen keperawatan dan supervisi klinis, termasuk strategi penguatan manajemen, implementasi supervisi klinis, hambatan yang sering dihadapi, hingga evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan. Selain itu, buku ini menguraikan peran kepala ruangan dalam perencanaan pelayanan keperawatan, penyusunan visi dan strategi ruangan, manajemen risiko, pengembangan mutu, serta kolaborasi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. Pembahasan mengenai standar mutu asuhan keperawatan dan indikator kinerja perawat juga disajikan sebagai dasar dalam menilai kualitas pelayanan serta keberhasilan implementasi supervisi klinis di ruang perawatan.

Pada bagian selanjutnya, buku ini mengulas hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap, dampaknya terhadap mutu pelayanan, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Pembaca juga akan memperoleh pemahaman mengenai strategi peningkatan kompetensi dan kepatuhan dokumentasi perawat sebagai bagian penting dalam peningkatan mutu asuhan keperawatan. Di bagian akhir, buku ini membahas evaluasi efektivitas supervisi klinik terhadap mutu asuhan keperawatan melalui berbagai indikator dan metode evaluasi yang relevan. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, kepala ruangan, manajer keperawatan, perawat klinis, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memperkuat praktik supervisi klinis dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di Indonesia.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

CHAPTER 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN KEPERAWATAN DAN SUPERVISI

KLINIS 1

Ana Fadilah, S. Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar Manajemen Keperawatan	3
C. Konsep dasar Supervisi Klinis	5
D. Strategi Penguatan Manajemen Keperawatan dan Supervisi Klinis.....	7
E. Intervensi dalam Implementasi Supervisi Klinis dan Manajemen Keperawatan	9
F. Program Implementasi Manajemen Keperawatan dan Supervisi Klinis	10
G. Hambatan dalam Implementasi Manajemen Keperawatan dan Supervisi Klinis.....	11
H. Evaluasi dan Tindak Lanjut Berkelanjutan.....	11
I. Simpulan.....	12
Referensi.....	13
Glosarium	14

CHAPTER 2 PERAN KEPALA RUANGAN DALAM PERENCANAAN PELAYANAN KEPERAWATAN 17

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.	17
A. Pendahuluan: Hakikat Perencanaan dalam Ekosistem Keperawatan.....	17
B. Filosofi Keperawatan sebagai Fondasi Perencanaan.....	17
C. Teori Kepemimpinan Modern dalam Perencanaan	18
D. Komponen Perencanaan Strategis oleh Kepala Ruangan	18
E. Hubungan antara Kepemimpinan dan Budaya Keselamatan	18
F. Tantangan Kontemporer dalam Perencanaan Kepemimpinan.....	19
G. Dampak Kepemimpinan yang Lemah dalam Perencanaan.....	19
H. Strategi Pengembangan Kompetensi Perencanaan.....	19
I. Peran Kepala Ruangan sebagai Analis Situasi.....	20
J. Penyusunan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Ruangan.....	22

K. Manajemen Risiko dan Perencanaan Keselamatan Pasien.....	24
L. Perencanaan Anggaran dan Kendali Biaya (Budgeting)	24
M. Pengembangan Program Mutu dan Akreditasi	25
N. Kolaborasi Interprofesional dalam Alur Pelayanan	25
O. Simpulan.....	26
P. Referensi.....	28
Q. Glosarium	28

CHAPTER 3 STANDAR MUTU ASUHAN KEPERAWATAN DAN INDIKATOR

KINERJA PERAWAT 31

Ns. Novin Yetiani, S.Kep., M.Kep.	31
A. Pendahuluan	31
B. Definisi dan Konsep Mutu Asuhan Keperawatan	32
C. Standar Mutu Asuhan Keperawatan	37
D. Indikator Kinerja Perawat	42
E. Upaya Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan dan Kinerja Perawat	47
F. Simpulan.....	51
G. Referensi.....	53

CHAPTER 4 HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SUPERVISI KLINIS DI

RUANG RAWAT INAP 83

Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep.	83
A. Pendahuluan	83
B. Supervisi Klinis dalam Praktik Keperawatan di Ruang Rawat Inap.....	84
C. Pelaksanaan Supervisi Klinis di Ruang Rawat Inap	89
D. Hambatan dalam Pelaksanaan Supervisi Klinis.....	92
E. Dampak Hambatan terhadap Pelayanan Keperawatan	99
F. Strategi Mengatasi Hambatan Supervisi Klinis	103
G. Simpulan.....	110
H. Referensi.....	111
I. Glosarium	111

CHAPTER 5 STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KEPATUHAN

DOKUMENTASI PERAWAT 113

Armidayanti, S.Kep., Ners., M.Kep.	113
A. Pendahuluan	113
B. Strategi Peningkatan Kompetensi	114
C. Strategi Kepatuhan Dokumentasi Perawat.....	118

D. Referensi.....	126
E. Glosarium.....	129

CHAPTER 6 EVALUASI EFEKTIVITAS SUPERVISI KLINIK TERHADAP MUTU ASUHAN KEPERAWATAN 131

Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.....	131
A. Pendahuluan	131
B. Indikator Mutu Asuhan Keperawatan.....	133
C. Metode Evaluasi Supervisi Klinik.....	137
D. Efektivitas Supervisi Klinik dalam Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan	143
E. Referensi.....	149
F. Glosarium	150

PROFIL PENULIS 155

CHAPTER 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN KEPERAWATAN DAN SUPERVISI KLINIS

Ana Fadilah, S. Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkontribusi secara langsung terhadap mutu pelayanan rumah sakit dan keselamatan pasien. Perawat merupakan tenaga kesehatan dengan jumlah terbesar di rumah sakit dan memiliki kontak paling lama dengan pasien selama 24 jam, sehingga kualitas pelayanan keperawatan sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan secara keseluruhan (World Health Organization [WHO], 2021). Mutu asuhan keperawatan yang optimal tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi individu perawat, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem manajemen keperawatan yang efektif serta pelaksanaan supervisi klinis yang berkesinambungan (Joseph & Huber, 2021).

Manajemen keperawatan merupakan suatu proses penggunaan sumber daya keperawatan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk memberikan pelayanan keperawatan yang efektif, efisien, dan bermutu (Marquis & Huston, 2021). Dalam praktiknya, manajemen keperawatan menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai standar, kebutuhan pasien terpenuhi, serta sumber daya manusia keperawatan dikelola secara optimal. Manajemen keperawatan yang baik terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, kepuasan kerja perawat, dan keselamatan pasien (Boamah et al., 2018).

Di sisi lain, supervisi klinis merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen keperawatan yang berfungsi sebagai proses pembinaan profesional untuk meningkatkan kompetensi klinis, menjamin keselamatan pasien, dan mempertahankan kualitas praktik keperawatan (Brunero & Stein-Parbury, 2008). Supervisi klinis tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai media edukasi, refleksi, dan dukungan profesional bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas (Snowdon et al., 2017). Pelaksanaan supervisi klinis yang efektif telah terbukti meningkatkan keterampilan

klinis, clinical judgment, kemampuan berpikir kritis, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (Specchia et al., 2021).

Secara global, mutu pelayanan keperawatan masih menjadi tantangan di berbagai negara. WHO melaporkan bahwa sekitar 1 dari 10 pasien di dunia mengalami kejadian tidak diharapkan (adverse events) selama menerima pelayanan kesehatan, dan sebagian besar kejadian tersebut berkaitan dengan kegagalan komunikasi, kesalahan pengobatan, serta lemahnya koordinasi pelayanan kesehatan (WHO, 2021). Selain itu, laporan dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menunjukkan bahwa sekitar 15% pengeluaran rumah sakit digunakan untuk menangani kesalahan pelayanan yang sebenarnya dapat dicegah melalui manajemen yang efektif dan sistem supervisi yang baik (OECD, 2017).

Di Indonesia, tantangan mutu pelayanan keperawatan juga masih cukup besar. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa insiden keselamatan pasien yang paling sering terjadi di rumah sakit meliputi pasien jatuh, kesalahan pemberian obat (medication error), kesalahan identifikasi pasien, serta infeksi terkait pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections/HAIs) (Kemenkes RI, 2022). Laporan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) menunjukkan bahwa insiden keselamatan pasien di Indonesia masih didominasi oleh kejadian nyaris cedera dan kejadian tidak diharapkan yang sebagian besar berkaitan dengan kurang optimalnya pengawasan dan supervisi pelayanan (Kemenkes RI, 2022). Selain itu, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) menekankan pentingnya fungsi manajemen keperawatan dan supervisi klinis sebagai indikator penting dalam pencapaian mutu rumah sakit (SNARS, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lemahnya fungsi manajemen keperawatan dan supervisi klinis dapat berdampak pada meningkatnya beban kerja perawat, rendahnya kepuasan kerja, burnout, tingginya angka turnover, serta menurunnya kualitas asuhan keperawatan (Wei et al., 2018). Sebaliknya, organisasi pelayanan kesehatan yang memiliki sistem manajemen keperawatan yang kuat dan supervisi klinis yang efektif cenderung memiliki tingkat kepuasan pasien yang lebih tinggi, angka insiden yang lebih rendah, serta kualitas pelayanan yang lebih baik (Boamah et al., 2018).

Kepala ruangan sebagai manajer lini pertama memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan fungsi manajemen keperawatan sekaligus menjalankan supervisi klinis di unit kerja. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam perencanaan pelayanan, pengaturan sumber daya manusia, koordinasi tim, pengawasan mutu pelayanan, serta pembinaan staf keperawatan secara langsung

(Joseph & Huber, 2021). Peran ini menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, meningkatkan motivasi staf, serta menjamin keselamatan pasien (Marquis & Huston, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman mengenai konsep dasar manajemen keperawatan dan supervisi klinis menjadi sangat penting bagi perawat, kepala ruangan, dan manajer keperawatan dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Oleh karena itu, bab ini akan membahas konsep dasar manajemen keperawatan, konsep supervisi klinis, strategi penguatan manajemen keperawatan dan supervisi klinis, intervensi implementasi di lapangan, evaluasi, serta tindak lanjut berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

B. Konsep Dasar Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan dalam mengelola sumber daya keperawatan secara efektif dan efisien untuk mencapai mutu pelayanan yang optimal. Manajemen keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan praktik klinis, pengembangan profesional perawat, serta pengendalian mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan (Joseph & Huber, 2021). Dalam konteks rumah sakit, manajemen keperawatan menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan diberikan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, manajemen keperawatan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip manajemen umum dalam praktik keperawatan yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (planning, organizing, actuating, controlling) (Marquis & Huston, 2021). Keempat fungsi ini saling berkaitan dan membentuk suatu siklus manajemen yang berkesinambungan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan.

Fungsi perencanaan (planning) merupakan tahap awal dalam manajemen keperawatan yang bertujuan untuk menetapkan tujuan pelayanan, menentukan prioritas, serta menyusun strategi dalam mencapai mutu pelayanan yang diharapkan. Perencanaan dalam keperawatan mencakup perencanaan kebutuhan tenaga, perencanaan asuhan keperawatan, perencanaan program peningkatan mutu, serta perencanaan pengembangan kompetensi staf (Joseph & Huber, 2021). Perencanaan yang baik akan memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pelayanan serta meminimalkan terjadinya kesalahan dalam praktik keperawatan.

Fungsi pengorganisasian (organizing) berkaitan dengan pengaturan sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem kerja yang mendukung pelayanan keperawatan. Dalam fungsi ini, kepala ruangan

bertanggung jawab untuk mengatur pembagian tugas, menetapkan struktur organisasi, serta memastikan adanya koordinasi yang efektif antar anggota tim keperawatan (Marquis & Huston, 2021). Pengorganisasian yang baik akan menciptakan alur kerja yang efisien dan meningkatkan kolaborasi antar tenaga kesehatan.

Fungsi pengarahan (*actuating/directing*) merupakan proses memotivasi, membimbing, dan mengarahkan staf keperawatan agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengarahan tidak hanya dilakukan melalui instruksi, tetapi juga melalui komunikasi efektif, kepemimpinan yang inspiratif, serta pemberian umpan balik yang konstruktif (Boamah et al., 2018). Dalam fungsi ini, peran kepala ruangan sangat penting sebagai pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung kinerja staf.

Fungsi pengendalian (*controlling*) merupakan tahap evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui kegiatan monitoring, audit, evaluasi kinerja, serta pengukuran indikator mutu pelayanan (Joseph & Huber, 2021). Hasil pengendalian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan.

Selain keempat fungsi tersebut, manajemen keperawatan juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia keperawatan yang meliputi rekrutmen, penempatan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta retensi tenaga keperawatan (Wei et al., 2018). Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif akan meningkatkan kepuasan kerja perawat, menurunkan tingkat *burnout*, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien (Boamah et al., 2018).

Dalam praktiknya, manajemen keperawatan juga harus berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Penerapan standar pelayanan, kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta penguatan budaya keselamatan pasien menjadi bagian penting dalam manajemen keperawatan modern (WHO, 2021). Hal ini sejalan dengan tuntutan akreditasi rumah sakit seperti yang diatur dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang menekankan pentingnya peran manajemen keperawatan dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Lebih lanjut, perkembangan sistem pelayanan kesehatan menuntut manajemen keperawatan untuk mengadopsi pendekatan berbasis bukti (*evidence-based management*) dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan penggunaan data, hasil penelitian, serta indikator mutu sebagai dasar dalam merencanakan dan mengevaluasi pelayanan keperawatan (Snowdon et al., 2020).

Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya bersifat intuitif, tetapi juga didukung oleh bukti ilmiah yang kuat.

Peran kepala ruangan sebagai manajer lini pertama menjadi sangat krusial dalam implementasi manajemen keperawatan di unit pelayanan. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen ke dalam praktik sehari-hari, memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, serta melakukan pembinaan dan supervisi terhadap staf keperawatan (Marquis & Huston, 2021). Keberhasilan manajemen keperawatan di tingkat unit sangat bergantung pada kompetensi dan kepemimpinan kepala ruangan dalam mengelola sumber daya dan mengarahkan tim.

Dengan demikian, konsep dasar manajemen keperawatan tidak hanya mencakup pemahaman tentang fungsi-fungsi manajemen, tetapi juga mencakup kemampuan dalam mengelola sumber daya, membangun kepemimpinan yang efektif, serta menciptakan sistem pelayanan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Pemahaman yang komprehensif terhadap manajemen keperawatan menjadi landasan penting dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi pelayanan kesehatan.

C. Konsep dasar Supervisi Klinis

Supervisi klinis merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen keperawatan yang berperan dalam menjamin mutu pelayanan, meningkatkan kompetensi perawat, serta memastikan keselamatan pasien. Dalam praktik keperawatan modern, supervisi klinis tidak lagi dipahami sebagai kegiatan pengawasan semata, tetapi sebagai proses pembinaan profesional yang berkelanjutan, sistematis, dan berorientasi pada pengembangan kemampuan klinis perawat (Brunero & Stein-Parbury, 2008). Supervisi klinis menjadi sarana penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik serta membantu perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan sesuai standar.

Secara konseptual, supervisi klinis dapat didefinisikan sebagai suatu proses formal yang melibatkan interaksi antara supervisor dan perawat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional melalui refleksi praktik, pemberian umpan balik, serta dukungan dalam pengambilan keputusan klinis (Snowdon et al., 2017). Supervisi klinis bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kinerja individu, tetapi juga untuk memperkuat sistem pelayanan keperawatan secara keseluruhan.

Tujuan utama supervisi klinis adalah meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, menjamin keselamatan pasien, serta mendukung pengembangan

profesional perawat. Supervisi klinis yang efektif terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), *clinical judgment*, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (Specchia et al., 2021). Selain itu, supervisi klinis juga berperan dalam meningkatkan kepuasan kerja perawat, mengurangi tingkat stres kerja, serta menurunkan risiko burnout akibat beban kerja yang tinggi (Boamah et al., 2018).

Dalam pelaksanaannya, supervisi klinis memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi edukatif, suportif, dan manajerial. Fungsi edukatif berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan klinis perawat melalui pembelajaran, diskusi kasus, serta refleksi praktik. Fungsi suportif bertujuan memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada perawat dalam menghadapi tekanan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja. Sementara itu, fungsi manajerial berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan praktik keperawatan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Joseph & Huber, 2021).

Model supervisi klinis yang banyak digunakan dalam praktik keperawatan antara lain model reflektif, model perkembangan profesional, dan model berbasis kompetensi. Model reflektif menekankan pada proses evaluasi diri dan pembelajaran dari pengalaman klinis yang telah dilakukan. Dalam model ini, perawat didorong untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktiknya serta merencanakan perbaikan secara berkelanjutan (Brunero & Stein-Parbury, 2008). Model ini sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis.

Model perkembangan profesional berfokus pada tahapan perkembangan kompetensi perawat dari tingkat pemula hingga ahli. Supervisi klinis dalam model ini disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan kebutuhan individu perawat, sehingga proses pembinaan menjadi lebih efektif dan terarah (Snowdon et al., 2017). Sementara itu, model berbasis kompetensi menekankan pada pencapaian standar kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan (Specchia et al., 2021).

Metode pelaksanaan supervisi klinis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti bedside supervision, diskusi kasus, konferensi klinik, audit praktik, serta reflective journaling. Bedside supervision dilakukan secara langsung di samping pasien untuk memberikan umpan balik terhadap praktik klinis yang dilakukan perawat. Diskusi kasus dan konferensi klinik digunakan untuk membahas permasalahan klinis secara bersama-sama dan mencari solusi yang tepat berdasarkan bukti ilmiah. Sementara itu, reflective journaling membantu perawat

dalam melakukan refleksi terhadap pengalaman praktiknya secara mandiri (Brunero & Stein-Parbury, 2008).

Pelaksanaan supervisi klinis yang efektif memerlukan peran supervisor yang kompeten dan memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, komunikasi efektif, serta umpan balik yang konstruktif. Dalam konteks pelayanan keperawatan, kepala ruangan seringkali berperan sebagai supervisor klinis yang bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi praktik keperawatan di unit kerja (Marquis & Huston, 2021). Supervisor harus mampu menciptakan hubungan yang saling percaya dengan perawat, sehingga proses supervisi dapat berjalan secara terbuka dan efektif.

Namun demikian, pelaksanaan supervisi klinis di berbagai rumah sakit masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang sering ditemukan antara lain keterbatasan waktu, beban kerja yang tinggi, kurangnya jumlah tenaga supervisor, serta belum optimalnya kompetensi kepala ruangan dalam melakukan supervisi klinis (Boamah et al., 2018). Kondisi ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pembinaan terhadap perawat serta meningkatnya risiko kesalahan dalam praktik keperawatan.

Dalam konteks kebijakan nasional, supervisi klinis menjadi bagian penting dalam standar mutu pelayanan rumah sakit. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan. Selain itu, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) juga mengatur bahwa rumah sakit harus memiliki sistem supervisi yang efektif untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien.

Dengan demikian, konsep dasar supervisi klinis tidak hanya mencakup pengawasan terhadap praktik keperawatan, tetapi juga mencakup proses pembelajaran, refleksi, dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Supervisi klinis yang efektif akan mendukung peningkatan kompetensi perawat, memperkuat budaya keselamatan pasien, serta meningkatkan mutu asuhan keperawatan secara keseluruhan.

D. Strategi Penguatan Manajemen Keperawatan dan Supervisi Klinis

Penguatan manajemen keperawatan dan supervisi klinis merupakan langkah strategis yang dirancang untuk memastikan mutu asuhan keperawatan dan keselamatan pasien dapat tercapai secara optimal. Strategi dalam konteks ini dipahami sebagai arah kebijakan dan pendekatan konseptual yang menjadi landasan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan di tingkat organisasi maupun unit pelayanan. Strategi yang dirancang secara tepat akan mempermudah proses

implementasi intervensi serta mendukung terciptanya pelayanan keperawatan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Joseph & Huber, 2021).

Salah satu strategi utama dalam penguatan manajemen keperawatan adalah pengembangan kepemimpinan keperawatan yang efektif. Kepala ruangan sebagai manajer lini pertama memiliki peran penting dalam mengintegrasikan fungsi manajemen keperawatan dan pelaksanaan supervisi klinis. Kepemimpinan transformasional menjadi pendekatan yang relevan dalam meningkatkan motivasi kerja, membangun budaya kerja yang positif, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan keperawatan (Specchia et al., 2021). Kepala ruangan yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kinerja staf, serta memastikan pelayanan berjalan sesuai standar (Marquis & Huston, 2021).

Strategi berikutnya adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia keperawatan. Perawat sebagai tenaga profesional dituntut untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan sistem pembelajaran berkelanjutan yang mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional perawat (Wei et al., 2018). Kompetensi yang memadai akan meningkatkan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.

Penguatan budaya keselamatan pasien juga merupakan strategi yang sangat penting dalam manajemen keperawatan. Budaya keselamatan pasien mencerminkan komitmen organisasi dalam melindungi pasien dari risiko cedera akibat pelayanan kesehatan. Organisasi yang memiliki budaya keselamatan yang kuat akan mendorong keterbukaan dalam pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, serta perbaikan sistem secara berkelanjutan (WHO, 2021). Sebaliknya, budaya yang masih berorientasi pada menyalahkan individu (*blaming culture*) dapat menghambat upaya peningkatan mutu pelayanan (Kemenkes RI, 2022).

Optimalisasi sistem supervisi klinis menjadi strategi penting lainnya dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Supervisi klinis harus dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kompetensi perawat serta memastikan praktik keperawatan sesuai dengan standar yang berlaku (Brunero & Stein-Parbury, 2008). Sistem supervisi yang baik juga harus dilengkapi dengan mekanisme umpan balik yang konstruktif untuk mendukung proses pembelajaran profesional.

Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan keperawatan menjadi bagian penting dari strategi manajemen. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi

digunakan untuk menilai efektivitas pelayanan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan (Joseph & Huber, 2021). Sistem ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti ilmiah.

Strategi lainnya adalah penguatan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi risiko serta melakukan tindakan pencegahan secara dini. Pendekatan non-punitive perlu diterapkan agar tenaga kesehatan merasa aman dalam melaporkan insiden yang terjadi (WHO, 2021). Hal ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Seluruh strategi tersebut harus diselaraskan dengan standar mutu nasional seperti Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang menekankan pentingnya manajemen keperawatan, supervisi klinis, serta sistem peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dengan strategi yang terarah dan terintegrasi, organisasi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

E. Intervensi dalam Implementasi Supervisi Klinis dan Manajemen Keperawatan

Intervensi merupakan langkah operasional yang dilakukan untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan dalam manajemen keperawatan dan supervisi klinis. Intervensi bersifat praktis dan langsung diterapkan di lapangan, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi perawat, memperbaiki kualitas pelayanan, serta memastikan kesesuaian praktik dengan standar yang berlaku (Marquis & Huston, 2021). Intervensi yang efektif harus berbasis kebutuhan, terukur, dan berkelanjutan.

Salah satu intervensi yang penting adalah pelatihan kepemimpinan bagi kepala ruangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam komunikasi efektif, pengambilan keputusan, manajemen konflik, serta supervisi klinis. Kepala ruangan yang memiliki kompetensi kepemimpinan yang baik akan lebih mampu mengelola tim secara efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan (Wei et al., 2018).

Intervensi berikutnya adalah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi perawat. Program ini mencakup peningkatan keterampilan klinis, keselamatan pasien, komunikasi SBAR, serta dokumentasi keperawatan. Pelatihan yang berkelanjutan memungkinkan perawat untuk terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (Snowdon et al., 2017).

Mentoring dan coaching juga merupakan intervensi penting dalam pengembangan sumber daya manusia keperawatan. Mentoring membantu

perawat baru dalam proses adaptasi dan pembentukan profesionalisme, sedangkan coaching berfokus pada peningkatan keterampilan tertentu dalam praktik klinis (Boamah et al., 2018). Intervensi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja perawat dan mengurangi kesalahan dalam pelayanan.

Supervisi klinis berbasis reflektif menjadi intervensi yang sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini dilakukan melalui diskusi kasus, bedside supervision, serta refleksi pengalaman praktik yang memungkinkan perawat belajar dari pengalaman yang telah dilakukan (Brunero & Stein-Parbury, 2008).

Intervensi lainnya adalah pelaksanaan audit keperawatan secara berkala. Audit dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap standar pelayanan serta kualitas dokumentasi keperawatan. Hasil audit digunakan sebagai dasar dalam perbaikan mutu pelayanan (Joseph & Huber, 2021).

Penguatan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien juga menjadi intervensi penting dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan. Sistem pelaporan yang efektif akan membantu organisasi dalam mengidentifikasi masalah dan melakukan tindakan korektif secara tepat (WHO, 2021).

Selain itu, pelaksanaan root cause analysis (RCA) dalam menangani insiden keselamatan pasien serta debriefing untuk memberikan dukungan psikologis kepada perawat juga merupakan bagian dari intervensi penting dalam manajemen keperawatan (Specchia et al., 2021).

F. Program Implementasi Manajemen Keperawatan dan Supervisi Klinis

Program implementasi merupakan bentuk terstruktur dari intervensi yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan manajemen keperawatan dan supervisi klinis berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Program disusun secara sistematis dengan tujuan yang jelas, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang terstandar (Joseph & Huber, 2021).

Program pelatihan kepemimpinan kepala ruangan menjadi salah satu program utama dalam meningkatkan kualitas manajemen keperawatan. Program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan manajerial dan supervisi klinis kepala ruangan sehingga mampu menjalankan perannya secara optimal (Specchia et al., 2021).

Program supervisi klinis terjadwal juga merupakan komponen penting dalam implementasi manajemen keperawatan. Program ini meliputi kegiatan supervisi rutin seperti bedside teaching, diskusi kasus, dan evaluasi praktik klinis yang dilakukan secara berkala (Brunero & Stein-Parbury, 2008).

Selain itu, program audit mutu keperawatan perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program ini mencakup evaluasi dokumentasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta hasil pelayanan keperawatan (Joseph & Huber, 2021).

Program keselamatan pasien juga menjadi bagian penting dalam manajemen keperawatan. Program ini mencakup pelaporan insiden, analisis akar masalah, serta penguatan budaya keselamatan pasien yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Program pengembangan kompetensi perawat melalui pendidikan berkelanjutan juga menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan (Wei et al., 2018).

G. Hambatan dalam Implementasi Manajemen Keperawatan dan Supervisi Klinis

Pelaksanaan manajemen keperawatan dan supervisi klinis di lapangan tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi. Hambatan ini perlu diidentifikasi agar dapat dilakukan upaya perbaikan secara tepat.

Keterbatasan jumlah perawat menjadi salah satu hambatan utama dalam pelayanan keperawatan. Beban kerja yang tinggi menyebabkan perawat kesulitan dalam melaksanakan tugas secara optimal, termasuk dalam mengikuti kegiatan supervisi klinis (Boamah et al., 2018).

Selain itu, keterbatasan waktu kepala ruangan dalam melakukan supervisi klinis juga menjadi kendala yang signifikan. Tugas administratif yang tinggi seringkali mengurangi waktu yang tersedia untuk pembinaan staf (Wei et al., 2018).

Kurangnya kompetensi dalam supervisi klinis juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Tidak semua kepala ruangan memiliki pelatihan khusus dalam supervisi klinis, sehingga pelaksanaan supervisi belum optimal.

Budaya organisasi yang masih berorientasi pada menyalahkan individu (blaming culture) juga menghambat pelaporan insiden keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2022). Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan sistem informasi juga menjadi hambatan dalam implementasi manajemen keperawatan.

H. Evaluasi dan Tindak Lanjut Berkelanjutan

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan (Joseph & Huber, 2021).

Evaluasi dapat dilakukan melalui audit pelayanan, pengukuran indikator mutu, serta survei kepuasan pasien. Indikator yang digunakan mencakup keselamatan pasien, kualitas dokumentasi, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan (WHO, 2021).

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan melalui revisi prosedur, peningkatan pelatihan, serta penguatan sistem supervisi klinis (Snowdon et al., 2017). Pendekatan continuous quality improvement menjadi penting dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan terus berkembang.

Evaluasi juga menjadi bagian penting dalam proses akreditasi rumah sakit sesuai standar Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS).

I. Simpulan

Manajemen keperawatan dan supervisi klinis merupakan dua komponen yang saling terkait dan berperan penting dalam menjamin mutu asuhan keperawatan serta keselamatan pasien. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dasar manajemen keperawatan, termasuk fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, menjadi landasan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan yang efektif. Di sisi lain, supervisi klinis berfungsi sebagai mekanisme pembinaan profesional yang mendukung peningkatan kompetensi perawat serta memastikan praktik keperawatan berjalan sesuai standar.

Penguatan manajemen keperawatan dan supervisi klinis memerlukan strategi yang terarah, mencakup pengembangan kepemimpinan keperawatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan budaya keselamatan pasien, serta optimalisasi sistem supervisi dan monitoring pelayanan. Strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai intervensi operasional seperti pelatihan, mentoring, supervisi reflektif, audit keperawatan, serta penguatan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien.

Dalam praktiknya, implementasi strategi dan intervensi tersebut diwujudkan dalam bentuk program yang terstruktur dan berkelanjutan, seperti program pelatihan kepemimpinan, supervisi klinis terjadwal, audit mutu keperawatan, serta program keselamatan pasien. Namun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, keterbatasan kompetensi supervisi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Oleh karena itu, diperlukan proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas program serta mengidentifikasi area yang memerlukan

perbaikan. Evaluasi yang didukung oleh indikator mutu dan pendekatan continuous quality improvement akan memastikan bahwa manajemen keperawatan dan supervisi klinis terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi antara strategi, intervensi, program, pengelolaan hambatan, serta evaluasi berkelanjutan, manajemen keperawatan dan supervisi klinis diharapkan mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, memperkuat budaya keselamatan pasien, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Referensi

- Boamah, S. A., Spence Laschinger, H. K., Wong, C. A., & Clarke, S. P. (2018). Effect of transformational leadership on job satisfaction and patient safety outcomes. *Nursing Outlook*, 66(2), 180–189. <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2017.10.004>
- Brunero, S., & Stein-Parbury, J. (2008). The effectiveness of clinical supervision in nursing: An evidence based literature review. *Australian Journal of Advanced Nursing*, 25(3), 86–94.
- Joseph, M. L., & Huber, D. L. (2021). Leadership and nursing care management (7th ed.). *Elsevier*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan nasional keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. *Kemenkes RI*.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application (10th ed.). *Wolters Kluwer*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). The economics of patient safety: Strengthening a value-based approach to reducing patient harm at national level. *OECD Publishing*. <https://doi.org/10.1787/5a9858cd-en>
- Snowdon, D. A., Leggat, S. G., & Taylor, N. F. (2017). Does clinical supervision of healthcare professionals improve effectiveness of care and patient experience? A systematic review. *BMC Health Services Research*, 17(1), 786. <https://doi.org/10.1186/s12913-017-2739-5>
- Specchia, M. L., Cozzolino, M. R., Carini, E., Di Pilla, A., Galletti, C., Ricciardi, W., & Damiani, G. (2021). Leadership styles and nurses' job satisfaction: Results of a systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 1552. <https://doi.org/10.3390/ijerph18041552>.
- Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit. (2022). SNARS edisi 1.1: Standar akreditasi rumah sakit. *Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)*.
- Wei, H., Sewell, K. A., Woody, G., & Rose, M. A. (2018). The state of the science of nurse work environments in the United States: A systematic review. *International Journal*

World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care. *WHO*.

Glosarium

- **Audit Keperawatan**

Proses evaluasi sistematis terhadap dokumentasi, proses, dan hasil asuhan keperawatan untuk menilai kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area perbaikan mutu pelayanan.

- **Budaya Keselamatan Pasien**

Nilai, sikap, dan perilaku dalam organisasi pelayanan kesehatan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama, termasuk keterbukaan dalam pelaporan insiden dan pembelajaran dari kesalahan.

- **Continuous Quality Improvement (CQI)**

Pendekatan perbaikan mutu secara berkelanjutan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

- **Documentasi Keperawatan**

Pencatatan sistematis seluruh tindakan, observasi, dan evaluasi asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien sebagai bagian dari proses pelayanan dan aspek legal.

- **Kepala Ruangan**

Perawat yang diberi tanggung jawab sebagai manajer lini pertama di unit pelayanan keperawatan untuk mengelola sumber daya, mengawasi praktik keperawatan, dan memastikan mutu pelayanan.

- **Manajemen Keperawatan**

Proses pengelolaan sumber daya keperawatan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai pelayanan keperawatan yang efektif, efisien, dan bermutu.

- **Mutu Asuhan Keperawatan**

Tingkat kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar profesi, keselamatan pasien, efektivitas, dan kepuasan pasien.

- **Root Cause Analysis (RCA)**

Metode analisis sistematis untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya insiden keselamatan pasien guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

- **Supervisi Klinis**

Proses pembinaan profesional yang terstruktur antara supervisor (biasanya kepala ruangan atau perawat senior) dan perawat untuk meningkatkan kompetensi, refleksi praktik, dan mutu asuhan keperawatan.

- **Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS)**

Standar yang digunakan di Indonesia untuk menilai mutu dan keselamatan pelayanan rumah sakit, termasuk aspek manajemen keperawatan dan supervisi klinis.

- **Supervisi Reflektif**

Pendekatan supervisi klinis yang menekankan pada refleksi pengalaman praktik keperawatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinis.

- **Tim Keperawatan**

Kelompok perawat yang bekerja secara kolaboratif dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien di suatu unit pelayanan.

- **Umpan Balik (Feedback)**

Informasi yang diberikan oleh supervisor kepada perawat terkait kinerja atau praktik klinis sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan profesional.

- **Keselamatan Pasien (Patient Safety)**

Upaya sistematis untuk mencegah terjadinya cedera atau kejadian tidak diharapkan pada pasien selama proses pelayanan kesehatan.

CHAPTER 2

PERAN KEPALA RUANGAN DALAM PERENCANAAN PELAYANAN KEPERAWATAN

Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan: Hakikat Perencanaan dalam Ekosistem Keperawatan

Perencanaan pelayanan keperawatan merupakan fungsi manajemen fundamental yang menentukan arah, tujuan, dan alokasi sumber daya dalam sebuah unit rawat inap. Kepala ruangan, sebagai manajer lini pertama (first-line manager), memegang peranan sentral dalam menjembatani visi strategis organisasi dengan realitas klinis di tempat tidur pasien. Menurut Marquis dan Huston (2021), perencanaan bukan sekadar aktivitas administratif statis, melainkan sebuah proses intelektual yang memerlukan kemampuan antisipasi terhadap perubahan masa depan yang tidak pasti. Tanpa filosofi yang kuat, perencanaan hanya akan menjadi kumpulan dokumen tanpa jiwa yang gagal menginspirasi staf untuk mencapai keunggulan klinis.

B. Filosofi Keperawatan sebagai Fondasi Perencanaan

Filosofi dalam konteks kepemimpinan kepala ruangan adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan prinsip yang mendasari setiap keputusan manajerial. Filosofi ini harus berfokus pada humanisme, holisme, dan integritas profesional. Huber (2022) menegaskan bahwa kepala ruangan yang efektif memulai proses perencanaan dengan menjawab pertanyaan mendasar: "Mengapa unit ini ada?" dan "Apa standar kualitas tertinggi yang ingin kita berikan?". Dalam perencanaan, filosofi ini diterjemahkan ke dalam prioritas kerja. Misalnya, jika filosofi ruangan menekankan pada Patient-Centered Care, maka perencanaan jadwal perawat, tata letak logistik, dan alur pendaftaran harus dirancang untuk meminimalkan waktu tunggu pasien dan memaksimalkan interaksi perawat-pasien (Nursalam, 2024). Filosofi juga berfungsi sebagai kompas moral saat kepala ruangan dihadapkan pada dilema keterbatasan sumber daya versus kebutuhan pasien yang mendesak.\

C. Teori Kepemimpinan Modern dalam Perencanaan

Kepala ruangan tidak lagi dapat mengandalkan gaya kepemimpinan otokratis yang kaku. Lingkungan kesehatan modern yang kompleks menuntut gaya kepemimpinan yang adaptif dan inklusif.

1. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional diakui sebagai standar emas dalam manajemen keperawatan (Kelly & Quesnelle, 2023). Dalam konteks perencanaan, pemimpin transformasional tidak hanya memerintah, tetapi menginspirasi staf untuk melihat melampaui kepentingan pribadi demi mencapai tujuan unit. Mereka melibatkan perawat pelaksana dalam penyusunan rencana tahunan, sehingga muncul rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap rencana tersebut. Sullivan (2024) mencatat bahwa perawat yang dilibatkan dalam proses perencanaan cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dan tingkat retensi yang lebih baik.

2. Kepemimpinan Pelayan (*Servant Leadership*)

Filosofi kepemimpinan pelayan menempatkan kebutuhan staf dan pasien di atas segalanya. Kepala ruangan yang menerapkan model ini memandang peran perencanaan sebagai cara untuk memfasilitasi staf agar dapat bekerja dengan hambatan minimal. Hal ini mencakup perencanaan ketersediaan alat kesehatan yang memadai dan lingkungan kerja yang aman secara psikologis (Yoder-Wise, 2023).

D. Komponen Perencanaan Strategis oleh Kepala Ruangan

Perencanaan yang dilakukan oleh kepala ruangan mencakup beberapa dimensi waktu dan cakupan:

- 1. Perencanaan Jangka Pendek (*Operasional*):** Mencakup penyusunan jadwal harian, manajemen logistik mingguan, dan penanganan fluktuasi harian dalam jumlah pasien.
- 2. Perencanaan Jangka Menengah:** Mencakup evaluasi kinerja bulanan, pengembangan program pelatihan staf, dan pemeliharaan alat rutin.
- 3. Perencanaan Jangka Panjang:** Mencakup pengembangan visi ruangan untuk 3-5 tahun ke depan, antisipasi terhadap perubahan tren penyakit, dan adaptasi terhadap teknologi medis baru (Marquis & Huston, 2021).

E. Hubungan antara Kepemimpinan dan Budaya Keselamatan

Salah satu peran terpenting kepala ruangan dalam perencanaan adalah menciptakan budaya keselamatan (*safety culture*). Kepemimpinan yang kuat harus mampu merencanakan sistem yang meminimalkan kesalahan manusia melalui

pendekatan sistem (system approach). Whitehead et al. (2022) berargumen bahwa perencanaan keselamatan pasien bukan hanya tentang mengikuti SOP, melainkan tentang bagaimana kepala ruangan mengalokasikan waktu untuk diskusi keselamatan (safety huddles) dan mendorong pelaporan insiden tanpa rasa takut akan sanksi.

F. Tantangan Kontemporer dalam Perencanaan Kepemimpinan

Dunia kesehatan saat ini berada dalam era volatilitas tinggi. Kepala ruangan harus mampu merencanakan pelayanan di tengah kekurangan tenaga perawat global dan peningkatan biaya kesehatan. Perencanaan harus bersifat fleksibel (agile). Menurut Hebda et al. (2025), integrasi teknologi informasi dalam perencanaan—seperti penggunaan perangkat lunak prediksi beban kerja berbasis AI—akan menjadi kompetensi wajib bagi kepala ruangan di masa depan. Pemimpin harus mampu merencanakan transisi dari pendokumentasian manual ke sistem digital dengan meminimalkan resistensi staf.

G. Dampak Kepemimpinan yang Lemah dalam Perencanaan

1. Kegagalan kepala ruangan dalam menjalankan fungsi perencanaan dapat berakibat fatal. Tanpa perencanaan yang matang, unit keperawatan akan mengalami:
2. Fragmentasi Pelayanan: Tidak adanya kesinambungan asuhan antar shift.
3. Pemborosan Sumber Daya: Penggunaan alat medis yang tidak terkontrol dan biaya lembur yang membengkak karena distribusi beban kerja yang tidak merata (Nursalam, 2024).
4. Penurunan Moral Staf: Staf merasa lelah karena sering menghadapi situasi "pemadam kebakaran" (reaktif terhadap masalah) daripada bekerja dalam sistem yang terencana dengan baik.

H. Strategi Pengembangan Kompetensi Perencanaan

Kepala ruangan memerlukan pelatihan berkelanjutan. Ini bukan sekadar tentang keterampilan teknis manajemen, tetapi juga pengembangan kecerdasan emosional. Hubungan antara kecerdasan emosional dan efektivitas perencanaan terletak pada kemampuan pemimpin untuk membaca dinamika tim dan merencanakan intervensi yang tepat untuk menjaga harmoni kerja (Sullivan, 2024). **Analisis Situasi dan Lingkungan Internal-Eksternal (SWOT)**

Sebelum menyusun rencana, kepala ruangan wajib melakukan analisis situasi menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Analisis ini memungkinkan identifikasi masalah kronis seperti rasio perawat-pasien

yang tidak seimbang atau peluang penggunaan teknologi telehealth (Whitehead et al., 2022).

Pengumpulan data harus mencakup indikator klinis, angka infeksi nosokomial, serta tingkat absensi staf. Data tersebut menjadi fondasi dasar dalam menentukan prioritas masalah yang akan diselesaikan dalam siklus perencanaan satu tahun (Yoder-Wise, 2023).

I. Peran Kepala Ruangan sebagai Analis Situasi

Kepala ruangan harus memiliki kemampuan analitis untuk melihat pola di balik data. Perencanaan yang bermutu lahir dari kemampuan mengidentifikasi masalah "akar penyebab" (root cause) dan bukan sekadar menangani gejala. Sebagai pemimpin, ia juga harus mampu mengomunikasikan hasil analisis SWOT kepada atasan (bidang keperawatan) untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan kepada bawahan agar mereka memahami urgensi dari setiap perubahan rencana (Huber, 2022).

1. Konsep Dasar Analisis Situasi dalam Manajemen Lini Depan

Analisis situasi adalah langkah awal yang krusial dalam siklus manajemen keperawatan. Sebelum seorang kepala ruangan menetapkan rencana strategis, ia harus memiliki pemahaman yang jernih dan berbasis data mengenai posisi unitnya saat ini. Menurut Marquis dan Huston (2021), kegagalan dalam perencanaan sering kali bukan disebabkan oleh kurangnya visi, melainkan oleh ketidaktahuan manajer terhadap realitas operasional di lapangan. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengevaluasi faktor internal yang dapat dikendalikan dan faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung unit namun berdampak signifikan pada pelayanan (Huber, 2022).

2. Komponen Internal: Strengths (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan)

Faktor internal mencakup segala sumber daya dan kapabilitas yang ada di dalam unit rawat inap. Kepala ruangan harus melakukan audit mendalam terhadap aspek-aspek berikut:

a. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Kekuatan sebuah ruangan sering kali terletak pada kompetensi stafnya. Misalnya, memiliki perawat dengan sertifikasi spesialis (seperti BTCLS, ACLS, atau sertifikasi ICU) adalah aset besar (Nursalam, 2024). Sebaliknya, kelemahan internal dapat berupa tingginya angka turnover perawat, rendahnya motivasi kerja, atau rasio perawat-pasien yang tidak ideal yang menyebabkan beban kerja berlebih (Sullivan, 2024).

b. Sarana, Prasarana, dan Teknologi

Ketersediaan alat kesehatan yang modern dan laik pakai merupakan kekuatan operasional. Namun, banyak unit menghadapi kelemahan berupa alat medis yang sering rusak atau ketiadaan sistem pendokumentasian digital yang menyebabkan inefisiensi waktu. Hebda et al. (2025) menekankan bahwa unit yang masih menggunakan sistem manual di era digital akan memiliki skor "Weakness" yang tinggi dalam aspek manajemen informasi.

3. Komponen Eksternal: Opportunities (Peluang) dan Threats (Ancaman)

Faktor eksternal adalah dinamika yang terjadi di luar unit, baik di tingkat rumah sakit maupun tingkat nasional/global.

a. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang dapat muncul dari kebijakan pemerintah mengenai jaminan kesehatan universal (JKN), kerja sama dengan institusi pendidikan untuk riset, atau adanya tren teknologi telehealth yang dapat diadaptasi oleh unit (Whitehead et al., 2022). Kepala ruangan yang jeli akan melihat peluang untuk mengajukan pelatihan bagi stafnya guna menjawab tantangan penyakit baru.

b. Ancaman terhadap Kontinuitas Pelayanan

Ancaman meliputi aspek-aspek seperti munculnya kompetitor (rumah sakit baru di sekitar), perubahan regulasi akreditasi yang semakin ketat, hingga situasi epidemiologis (seperti pandemi) yang dapat melumpuhkan sumber daya unit. Yoder-Wise (2023) mencatat bahwa tuntutan hukum dari pasien (malpraktik) merupakan ancaman eksternal serius yang harus dimitigasi melalui perencanaan manajemen risiko yang ketat.

4. Metodologi Pengumpulan Data untuk Analisis SWOT

Analisis SWOT tidak boleh didasarkan pada asumsi subjektif kepala ruangan semata. Data harus dikumpulkan melalui:

- a. Audit Klinis: Meninjau angka infeksi nosokomial (HAIs), angka jatuh, dan kejadian tidak diharapkan (KTD).
- b. Kuesioner Kepuasan: Mengukur tingkat kepuasan pasien dan kepuasan kerja perawat (Nursalam, 2024).
- c. Observasi Langsung: Menilai alur kerja perawat dan kepatuhan terhadap SOP.
- d. Laporan Finansial: Menganalisis efisiensi penggunaan bahan habis pakai (BHP) di ruangan (Sullivan, 2024).

5. Matriks SWOT dan Strategi Perencanaan

Setelah data teridentifikasi, kepala ruangan harus menyusun Matriks SWOT untuk merumuskan strategi:

Tabel 2.1: Matriks SWOT dan Strategi Perencanaan

Faktor	Opportunities (O)	Threats (T)
Strengths (S)	Strategi SO: Gunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang (misal: gunakan staf ahli untuk membuka layanan baru).	Strategi ST: Gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman.
Weaknesses (W)	Strategi WO: Perbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang eksternal (misal: ajukan pelatihan staf ke manajemen).	Strategi WT: Rencana defensif untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

J. Penyusunan Visi, Misi, dan Rencana Strategis Ruangan

Visi ruangan harus selaras dengan visi rumah sakit namun tetap spesifik terhadap karakteristik pelayanan unit, misalnya unit intensif atau pediatrik. Perencanaan strategis melibatkan penetapan indikator kinerja utama (KPI) yang dapat diukur (Marquis & Huston, 2021).

Partisipasi staf dalam penyusunan visi sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki (sense of belonging). Ketika staf memahami tujuan akhir dari pelayanan, kualitas asuhan meningkat secara signifikan (Huber, 2022).

1. Hierarki Perencanaan: Dari Rumah Sakit ke Unit Kerja

Perencanaan strategis di tingkat ruangan adalah proses penerjemahan visi besar rumah sakit ke dalam rencana operasional yang konkret dan dapat dilaksanakan. Kepala ruangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada diskoneksi antara apa yang dicita-citakan oleh jajaran direksi dengan apa yang dilakukan oleh perawat di samping tempat tidur pasien. Menurut Marquis dan Huston (2021), visi dan misi unit memberikan kerangka kerja bagi pengambilan keputusan harian dan menetapkan prioritas bagi alokasi sumber daya yang terbatas. Tanpa arahan strategis, sebuah unit cenderung bekerja secara mekanis tanpa adanya dorongan untuk melakukan inovasi atau peningkatan mutu berkelanjutan.

2. Merumuskan Visi dan Misi Ruang yang Inspiratif

Visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh unit (misalnya: "Menjadi unit perawatan intensif jantung terbaik di wilayah regional pada tahun 2028"). Sementara itu, misi menjelaskan alasan keberadaan unit dan apa yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Huber (2022) menekankan bahwa misi harus mencakup elemen-elemen kunci seperti populasi pasien yang dilayani, jenis layanan yang diberikan, dan nilai-nilai profesional yang dianut.

Kepala ruangan tidak boleh merumuskan visi dan misi secara isolasi. Proses ini harus melibatkan seluruh staf melalui diskusi kelompok atau curah pendapat (brainstorming). Ketika staf merasa suara mereka didengar dalam menentukan tujuan unit, komitmen mereka terhadap pencapaian target tersebut akan meningkat secara signifikan (Sullivan, 2024).

3. Langkah-Langkah Perencanaan Strategis di Tingkat Lini

Proses perencanaan strategis yang dipimpin oleh kepala ruangan biasanya mengikuti siklus yang sistematis:

Penetapan Tujuan (Goal Setting): Menentukan hasil spesifik yang ingin dicapai dalam satu hingga tiga tahun ke depan, seperti menurunkan angka infeksi daerah operasi sebesar 20%.

Identifikasi Sasaran (Objectives): Sasaran harus memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Contohnya: "Meningkatkan kepatuhan cuci tangan staf hingga 100% dalam waktu enam bulan" (Nursalam, 2024).

Pemilihan Strategi: Menentukan "bagaimana" cara mencapai sasaran tersebut, misalnya melalui pengadaan fasilitas hand-rub di setiap bed atau program edukasi berkelanjutan (Whitehead et al., 2022).

4. Penjabaran Rencana Strategis ke Rencana Operasional (Action Plan)

Rencana strategis yang abstrak harus dipecah menjadi rencana aksi yang sangat detail. Dalam dokumen ini, kepala ruangan harus menetapkan:

Siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas (delegasi).

Kapan tugas tersebut harus diselesaikan (lini masa).

Sumber daya apa yang dibutuhkan (anggaran atau alat).

Indikator Keberhasilan yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil (Kelly & Quesnelle, 2023).

5. Penyelarasan Nilai Profesional dan Budaya Kerja

Rencana strategis unit juga harus mencakup pengembangan budaya kerja yang selaras dengan nilai-nilai keperawatan profesional seperti kasih sayang (compassion), akuntabilitas, dan integritas. Yoder-Wise (2023) mencatat bahwa strategi secanggih apa pun akan gagal jika budaya ruangan tidak mendukung. Oleh karena itu, kepala ruangan harus merencanakan intervensi untuk memperkuat kerja sama tim dan komunikasi terbuka sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjang unit.

6. Evaluasi dan Revisi Rencana Strategis

Dunia kesehatan sangat dinamis, sehingga rencana strategis tidak boleh bersifat kaku. Kepala ruangan harus melakukan tinjauan berkala (triwulanan atau semesteran) untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang dibuat saat menyusun rencana masih relevan. Jika terjadi perubahan besar, seperti perubahan kebijakan asuransi kesehatan atau munculnya teknologi medis baru, kepala ruangan harus cukup fleksibel untuk melakukan revisi tanpa kehilangan arah pada visi utama (Hebda et al., 2025).

Penyusunan visi, misi, dan rencana strategis adalah bukti nyata dari peran kepala ruangan sebagai pemimpin visioner. Dengan menetapkan arah yang jelas, kepala ruangan memberikan makna pada pekerjaan rutin stafnya, mengubah rutinitas klinis menjadi langkah-langkah menuju keunggulan pelayanan. Perencanaan strategis yang kuat adalah fondasi bagi keberlanjutan mutu di tengah persaingan layanan kesehatan yang semakin ketat (Marquis & Huston, 2021).

K. Manajemen Risiko dan Perencanaan Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah inti dari perencanaan keperawatan. Kepala ruangan harus merencanakan mitigasi risiko terhadap kejadian tidak diharapkan (KTD) melalui sistem pelaporan yang non-punitif (Kelly & Quesnelle, 2023).

Perencanaan ini mencakup penerapan enam sasaran keselamatan pasien secara konsisten, mulai dari identifikasi yang benar hingga pengurangan risiko jatuh. Evaluasi rutin melalui Incident Report menjadi bagian dari perencanaan perbaikan (Yoder-Wise, 2023).

L. Perencanaan Anggaran dan Kendali Biaya (Budgeting)

Kepala ruangan masa kini dituntut memiliki literasi finansial. Mereka harus mampu menyusun anggaran operasional, anggaran modal, dan memantau varians anggaran setiap bulan (Sullivan, 2024).

Efisiensi biaya dilakukan tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, melalui perencanaan penggunaan bahan habis pakai yang tepat guna dan pengurangan pemborosan waktu dalam alur kerja perawat (Nursalam, 2024).

M. Pengembangan Program Mutu dan Akreditasi

Perencanaan mutu melibatkan penetapan standar asuhan berdasarkan bukti ilmiah (Evidence-Based Practice). Kepala ruangan merencanakan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP (Whitehead et al., 2022).

Persiapan akreditasi rumah sakit menjadi agenda tetap dalam perencanaan. Hal ini mencakup pembaruan protokol klinis dan peningkatan kompetensi staf dalam menangani kasus-kasus kompleks (Huber, 2022).

Peran Kepala Ruangan sebagai Katalisator

Akreditasi (seperti KARS di Indonesia atau JCI secara internasional) adalah proses penilaian eksternal terhadap standar pelayanan. Kepala ruangan memiliki peran vital dalam merencanakan "kesiapan akreditasi setiap saat" (continuous readiness). Ini mencakup (Yoder-Wise, 2023):

- a. Edukasi Staf: Merencanakan sosialisasi reguler mengenai standar keselamatan pasien dan kebijakan rumah sakit.
- b. Audit Kepatuhan: Melakukan self-assessment berkala terhadap rekam medis dan lingkungan fisik ruangan.
- c. Manajemen Dokumen: Memastikan semua kebijakan, prosedur, dan bukti implementasi (logbook, hasil rapat) tersusun rapi dan mudah diakses.

Kelly dan Quesnelle (2023) mencatat bahwa kepala ruangan yang sukses memandang akreditasi bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai sarana untuk meningkatkan keselamatan pasien dan legitimasi profesional unit.

N. Kolaborasi Interprofesional dalam Alur Pelayanan

Pelayanan pasien bersifat multidisiplin. Kepala ruangan harus merencanakan koordinasi yang efektif antara perawat, dokter, ahli gizi, dan farmasi (Hebda et al., 2025).

Hambatan komunikasi sering menjadi penyebab kegagalan pelayanan. Oleh karena itu, perencanaan harus mencakup penggunaan alat komunikasi standar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dalam setiap serah terima (Marquis & Huston, 2021).

O. Simpulan

Kepala ruangan bukan sekadar perawat senior, melainkan manajer tingkat lini yang menentukan keberhasilan perencanaan asuhan. Perencanaan yang komprehensif mencakup aspek SDM, logistik, anggaran, dan mutu. Rekomendasi masa depan menekankan pada adaptasi teknologi AI dalam penjadwalan perawat dan penggunaan data besar (big data) untuk memprediksi kebutuhan pasien di masa mendatang (Nursalam, 2024; Sullivan, 2024).

1. Sintesis Peran Strategis Kepala Ruangan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepala ruangan bukan sekadar perawat senior yang menjalankan tugas administratif, melainkan seorang manajer strategis di lini depan. Peran mereka dalam perencanaan mencakup spektrum yang luas, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia dan material hingga penjaminan mutu dan keselamatan pasien. Menurut Marquis dan Huston (2021), keberhasilan sebuah unit keperawatan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala ruangan dalam menyelaraskan visi organisasi dengan realitas operasional melalui perencanaan yang berbasis data dan partisipatif. Perencanaan yang matang terbukti menurunkan tingkat kesalahan klinis, meningkatkan kepuasan kerja staf, dan mengoptimalkan efisiensi biaya rumah sakit (Nursalam, 2024).

2. Esensi Kepemimpinan dalam Keberlanjutan Perencanaan

Filosofi kepemimpinan yang adaptif, terutama model transformasional dan pelayan (servant leadership), menjadi fondasi utama bagi efektivitas perencanaan. Kepala ruangan harus mampu menginspirasi staf untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga rencana yang disusun menjadi tanggung jawab bersama. Sullivan (2024) menegaskan bahwa tantangan keperawatan di masa depan menuntut kepala ruangan yang memiliki kecerdasan emosional tinggi untuk mengelola konflik interprofesional dan memotivasi tim di tengah tekanan beban kerja yang dinamis.

3. Rekomendasi Masa Depan: Adaptasi terhadap Disrupsi Teknologi

Menghadapi era kesehatan 4.0 dan menuju 5.0, perencanaan keperawatan harus bertransformasi dari cara-cara konvensional menuju pendekatan berbasis teknologi digital. Berikut adalah rekomendasi strategis bagi kepala ruangan di masa depan:

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Manpower Planning: Kepala ruangan harus mulai merencanakan penggunaan algoritma prediksi untuk menentukan jumlah staf berdasarkan tren musiman penyakit dan tingkat keparahan pasien secara real-time (Hebda et al., 2025).

Literasi Data dan Big Data: Perencanaan mutu harus didasarkan pada analisis data besar yang dihasilkan oleh rekam medis elektronik. Kepala ruangan masa depan wajib memiliki kemampuan untuk membaca dasbor analitik guna mendeteksi penurunan kualitas sebelum menjadi insiden keselamatan (Huber, 2022).

Fokus pada Kesejahteraan Staf (Nurse Well-being): Mengingat isu kekurangan perawat global, perencanaan harus lebih banyak mencakup strategi retensi, seperti jadwal kerja yang fleksibel dan program dukungan kesehatan mental bagi staf (Kelly & Quesnelle, 2023).

4. Rekomendasi untuk Kebijakan dan Pendidikan Keperawatan

Dunia pendidikan dan manajemen rumah sakit perlu memberikan perhatian lebih pada pengembangan kompetensi manajerial bagi calon kepala ruangan. Pelatihan tidak boleh hanya fokus pada aspek klinis, tetapi juga pada manajemen risiko, literasi finansial, dan komunikasi kolaboratif (Yoder-Wise, 2023). Whitehead et al. (2022) menyarankan adanya program pendampingan (mentorship) berkelanjutan bagi kepala ruangan baru guna memastikan transisi peran yang mulus dari praktisi klinis menjadi pemimpin manajerial.

5. Penutup

Perencanaan pelayanan keperawatan adalah sebuah seni manajemen yang terus berkembang. Kepala ruangan yang visioner adalah mereka yang mampu belajar dari masa lalu, mengelola masa kini dengan integritas, dan merencanakan masa depan dengan keberanian untuk berinovasi. Dengan menjadikan keselamatan pasien sebagai kompas moral dan efisiensi sebagai pilar operasional, kepala ruangan akan tetap menjadi penggerak utama dalam transformasi pelayanan kesehatan yang lebih baik (Marquis & Huston, 2021; Nursalam, 2024).

P. Referensi

- Hebda, T., Hunter, K., & Czar, P. (2025). *Handbook of informatics for nurses and healthcare professionals* (7th ed.). Pearson.
- Huber, D. L. (2022). *Leadership and nursing care management* (7th ed.). Elsevier.
- Kelly, P., & Quesnelle, S. (2023). *Nursing leadership and management* (4th ed.). Cengage Learning.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Nursalam. (2024). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (Edisi 7). Salemba Medika.
- Sullivan, E. J. (2024). *Effective leadership and management in nursing* (10th ed.). Pearson.
- Whitehead, D. K., Weiss, S. A., & Tappen, R. M. (2022). *Essentials of nursing leadership and management* (7th ed.). F.A. Davis Company.
- Yoder-Wise, P. S. (2023). *Leading and managing in nursing* (8th ed.). Elsevier.

Q. Glosarium

A - E

- Action Plan (Rencana Aksi): Penjabaran detail dari rencana strategis yang mencakup delegasi tugas, lini masa, sumber daya, dan indikator keberhasilan.
- Agile (Fleksibel): Kemampuan perencanaan untuk bersifat adaptif dan cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kesehatan yang sangat dinamis.
- Analisis SWOT: Instrumen perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats).
- Big Data: Kumpulan data dalam jumlah sangat besar dari rekam medis elektronik yang dianalisis untuk memprediksi kebutuhan pasien dan tren kualitas pelayanan.
- Brainstorming: Metode diskusi kelompok untuk mengumpulkan ide atau solusi kreatif dari staf dalam penyusunan visi atau pemecahan masalah.
- Budaya Keselamatan (Safety Culture): Suasana organisasi yang mengutamakan keselamatan pasien di atas segalanya, di mana staf merasa aman untuk melaporkan kesalahan tanpa takut dihukum.
- Case Conference: Pertemuan multidisiplin antar profesi kesehatan (dokter, perawat, ahli gizi, dll.) untuk membahas rencana asuhan pasien dengan kasus kompleks.
- Evidence-Based Practice (Praktik Berbasis Bukti): Pemberian asuhan keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru dan hasil penelitian yang valid.

F - K

First-line Manager (Manajer Lini Pertama): Tingkatan manajemen yang langsung membawahi staf pelaksana; dalam konteks ini adalah Kepala Ruangan.

Fragmentasi Pelayanan: Kondisi di mana asuhan keperawatan terputus-putus atau tidak berkesinambungan, biasanya akibat perencanaan yang buruk antar shift.

Holisme: Filosofi asuhan yang memandang pasien sebagai satu kesatuan utuh (biologis, psikologis, sosial, dan spiritual).

Humanisme: Pendekatan yang memanusiakan pasien dan staf, menekankan pada nilai, martabat, dan hak asasi manusia.

Incident Report (Laporan Insiden): Dokumentasi resmi mengenai kejadian yang tidak diharapkan atau nyaris cedera sebagai bahan evaluasi perbaikan sistem.

Kecerdasan Emosional: Kemampuan pemimpin untuk memahami dan mengelola emosi diri sendiri serta dinamika tim guna menjaga harmoni kerja.

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD): Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.

Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership): Gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan staf dan pasien guna memfasilitasi lingkungan kerja yang optimal.

Kepemimpinan Transformasional: Gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi staf untuk mencapai visi bersama dan melampaui kepentingan pribadi.

KPI (Key Performance Indicator): Indikator kinerja utama yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan pencapaian target unit.

L - S

Literasi Finansial: Kemampuan kepala ruangan untuk memahami dan mengelola anggaran, biaya operasional, serta efisiensi unit.

Manpower Planning: Proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja (perawat) berdasarkan beban kerja dan tingkat ketergantungan pasien.

Matriks SWOT: Tabel analisis yang memadukan faktor internal dan eksternal untuk merumuskan strategi spesifik (Strategi SO, ST, WO, WT).

Mentorship: Program pendampingan bagi kepala ruangan baru oleh senior untuk memastikan transisi peran yang efektif.

Non-punitif: Pendekatan sistem pelaporan yang tidak berfokus pada pemberian sanksi atau hukuman kepada individu, melainkan pada perbaikan sistem.

Patient-Centered Care: Model pelayanan yang menempatkan pasien sebagai pusat dari setiap keputusan dan tindakan medis/keperawatan.

Root Cause (Akar Penyebab): Faktor terdalam yang memicu terjadinya suatu masalah atau insiden klinis.

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation): Kerangka komunikasi standar antar tenaga kesehatan untuk memastikan informasi pasien tersampaikan secara akurat dan efisien.

Sense of Ownership (Rasa Kepemilikan): Kondisi psikologis di mana staf merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap keberhasilan rencana dan tujuan unit.

SMART: Kriteria dalam menetapkan sasaran yang harus Spesifik (Specific), Terukur (Measurable), Dapat dicapai (Achievable), Relevan (Relevant), dan Berbatas waktu (Time-bound).

SOP (Standard Operating Procedure): Pedoman standar langkah-langkah kerja yang harus diikuti untuk menjamin mutu dan keselamatan.

T - V

Telehealth: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh.

Turnover: Tingkat keluar-masuknya perawat dalam satu unit dalam periode tertentu.

Varians Anggaran: Selisih atau perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran aktual di lapangan.

Visi: Gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai oleh unit ruangan dalam jangka panjang.

Volatilitas: Keadaan lingkungan kesehatan yang sangat mudah berubah, tidak pasti, dan bergejolak.

CHAPTER 3

STANDAR MUTU ASUHAN KEPERAWATAN DAN INDIKATOR KINERJA PERAWAT

Ns. Novin Yetiani, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Mutu pelayanan keperawatan merupakan barometer utama dalam penilaian kualitas rumah sakit. Profesionalisme perawat dituntut dapat mengintegrasikan standar praktik pada setiap tindakan asuhan (Anto et al., 2022). Penerapan standar praktik memiliki peran penting sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja aktual perawat dengan level performa yang diharapkan oleh profesi (Supratti & Ashriady, 2018).

Efektivitas penerapan standar sangat bergantung pada kedalaman pengetahuan praktisi mengenai konsep dasar proses keperawatan, yang secara langsung berpengaruh pada kompetensi klinis di lapangan (Nasution, 2019; Tampubolon, 2019). Pencapaian standar tersebut mencakup implementasi tahapan proses keperawatan yang sistematis, mulai dari pengkajian hingga evaluasi, sebagai bentuk penjaminan mutu layanan yang komprehensif (Dewi et al., 2021). Pencapaian standar praktik yang tinggi tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam memberikan intervensi yang aman, tetapi juga berperan sebagai pendukung utama institusi dalam melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat.

Kinerja perawat yang optimal tercermin melalui konsistensi dokumentasi dan penerapan metodologi keperawatan secara sistematis sebagai variabel utama dalam mengukur keberhasilan mutu asuhan (Harismayanti et al., 2025; Napitu, 2020; Syofian, 2020). Kinerja perawat dapat diukur melalui delapan elemen standar profesional, meliputi jaminan mutu, pendidikan, penilaian kinerja, kesejawatan, kolaborasi, etik, riset, serta pemanfaatan sumber daya yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Zulkarnain, 2019). Penilaian kinerja keperawatan menggunakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang didasarkan pada audit dokumentasi asuhan sebagai bukti objektif kepatuhan terhadap Standar Asuhan Keperawatan (Sitorus, 2020). Indikator tersebut mencakup variabel kritis seperti angka kejadian infeksi nosokomial, tingkat kepuasan pasien, serta efisiensi waktu dalam pelaporan tindakan klinis (Tampubolon, 2020). Keterlibatan aktif perawat dalam evaluasi berkelanjutan merupakan kewajiban untuk memastikan

seluruh intervensi klinis tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi pelayanan kesehatan.

Penguatan kompetensi klinis melalui pendidikan berkelanjutan perlu diintegrasikan agar perawat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi medis dan kebutuhan pasien yang komprehensif. Faktor psikologis dan motivasi perawat memegang peranan krusial dalam mempertahankan kinerja profesional di tengah tuntutan beban kerja yang dinamis (Jainurakhma, 2022). Oleh karena itu, sistem manajemen sumber daya manusia yang terstruktur perlu diimplementasikan untuk menjaga stabilitas performa klinis serta mendukung proses profesionalisasi perawat dalam menghadapi tuntutan otonomi pelayanan kesehatan (M. P. Drs. I. G. Rani, 2019; M. Y. Rani, 2019). Integrasi antara standar praktik dan komitmen organisasi terbukti menjadi katalisator dalam membentuk perilaku profesional yang berkelanjutan pada tenaga keperawatan (Miladiyah et al., 2015). Selain itu, pembentukan budaya kerja yang suportif dan kolaboratif terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja individu dalam memberikan pelayanan yang bermutu (Wuryanti, 2025).

B. Definisi dan Konsep Mutu Asuhan Keperawatan

Pengelolaan sumber daya manusia yang strategis menjadi determinan utama dalam keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi, terutama dalam memitigasi hambatan operasional saat memberikan asuhan holistik kepada pasien (Zendrato & Hariyati, 2018). Pengelolaan beban kerja yang proporsional serta dukungan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis perawat merupakan aspek krusial yang secara langsung memengaruhi konsistensi kualitas pelayanan di lapangan (Wahdah et al., 2025), (Silitonga et al., 2020). Kepuasan kerja perawat berkorelasi positif dengan efektivitas tindakan klinis yang diberikan kepada pasien (Suratman & Sunartini, 2003). Efisiensi dalam pengelolaan tenaga keperawatan harus didukung oleh pembagian tugas yang terstruktur untuk menghindari tumpang tindih peran dalam memberikan asuhan.

1. Mutu Asuhan Keperawatan

Mutu asuhan keperawatan didefinisikan sebagai tingkat efektivitas pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan dalam memenuhi kebutuhan klien (Tampubolon, 2019). Pencapaian kualitas mutu asuhan harus didasarkan pada kerangka kerja sistemis yang mengintegrasikan standar praktik, proses keperawatan, pendidikan berkelanjutan, serta penerapan Metode Asuhan Keperawatan Profesional secara utuh (Naryati et al., 2025). Pemberdayaan perawat melalui peningkatan kapasitas dan dukungan pelatihan

klinis menjadi prasyarat mutlak untuk memastikan keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas layanan kesehatan.

Kriteria keberhasilan mutu ini ditetapkan melalui pemenuhan standar profesi yang konsisten, berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk menilai efektivitas serta efisiensi praktik keperawatan di tatanan klinis (Kurniati, 2019; munthe, 2019). Sejalan dengan hal tersebut, kualitas pelayanan yang optimal tidak hanya berfokus pada hasil klinis, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan objektif klien yang dilakukan secara humanistik dan komprehensif (Gea, 2020). Pendekatan ini menuntut perawat untuk menjalankan peran otonom dalam mengelola asuhan keperawatan yang terstruktur, guna memastikan keselamatan pasien serta efektivitas pelayanan secara menyeluruh (L.Tobing, 2020). Mutu asuhan keperawatan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelayanan yang memenuhi atau melampaui harapan pasien melalui integrasi proses, lingkungan, dan kompetensi tenaga profesional.

Dalam konteks ini, ketersediaan sumber daya perawat yang memadai secara kuantitas dan kualitas menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas komunikasi serta koordinasi antardisiplin dalam pemberian asuhan yang berpusat pada pasien (Yusnaini et al., 2021). Pengelolaan sumber daya keperawatan yang efektif melalui sistem manajerial yang tepat sangat krusial untuk mengarahkan seluruh potensi perawat dalam menghasilkan pelayanan yang prima (Elvahra, 2020). Pengukuran produktivitas melalui penilaian kinerja secara berkala berperan sebagai instrumen vital dalam mengontrol sumber daya manusia agar tetap selaras dengan target klinis yang ditetapkan (Prayogi, 2018). Pemberian umpan balik mengenai capaian indikator kinerja kepada staf klinis merupakan langkah strategis untuk memperkuat rasa kepemilikan terhadap mutu asuhan yang diberikan.

Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan perlu dilakukan. Hal ini dapat membantu manajemen rumah sakit mengidentifikasi kesenjangan kinerja serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara signifikan. Adanya penilaian kinerja terstruktur memungkinkan rumah sakit untuk melakukan pemetaan kompetensi serta memastikan bahwa setiap staf keperawatan memenuhi uraian tugas dan tanggung jawab dalam mencapai target indikator mutu yang telah ditetapkan di unit kerjanya (Ellina et al., 2023). Penilaian kinerja tersebut harus mengintegrasikan dimensi keselamatan pasien sebagai prioritas utama, mengingat keterlibatan perawat dalam manajemen risiko berperan krusial dalam menekan angka insiden klinis (Ellina et al., 2023; Tamaela, 2021). Sasaran keselamatan pasien ini mencakup berbagai komponen kritis, seperti identifikasi

pasien yang akurat, komunikasi efektif, kewaspadaan tinggi dalam pemberian obat, serta pengurangan risiko infeksi dan cedera akibat jatuh (Zebua, 2020).

Manajer perawat memiliki peran penting dalam mengoptimalkan proses operasional untuk merancang pengembangan karier, memberikan pelatihan yang relevan, serta mengapresiasi perawat yang menunjukkan kompetensi tinggi dalam menerapkan keselamatan pasien (Iqbal et al., 2020). Pengintegrasian mekanisme evaluasi kinerja secara komprehensif, seperti penggunaan umpan balik multi-sumber dan penilaian berbasis respons pasien, terbukti krusial dalam memetakan efektivitas perawat di lapangan (Rismayanti et al., 2025). Dengan demikian, standardisasi penilaian kinerja berfungsi sebagai data dasar manajemen untuk melakukan supervisi klinis secara terarah serta merancang intervensi perbaikan yang berkesinambungan.

2. Prinsip-prinsip Mutu Asuhan Keperawatan

Prinsip utama dalam mutu asuhan keperawatan berlandaskan pada komitmen terhadap keselamatan pasien yang menjadi aspek paling kritis dalam manajemen kualitas layanan kesehatan. Prinsip ini menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dan komponen dasar dalam setiap pemberian layanan kesehatan guna meminimalkan risiko klinis serta meningkatkan kepuasan pasien (Ginting, 2019; Hrp, 2019). Selain itu, pengembangan budaya keselamatan melalui kolaborasi interprofesional dan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi sangat penting untuk mendukung pemberian asuhan yang aman serta berfokus pada individu ((T'ien), 2026). Perawat harus mampu memahami seluruh komponen penerapan sistem keselamatan pasien, mulai dari asesmen risiko hingga pelaporan dan analisis insiden, guna meminimalisir kesalahan dalam pemberian asuhan (harahap, 2019). Implementasi prinsip tersebut merupakan tanggung jawab seluruh tim medis untuk aktif mengedukasi pasien agar terlibat dalam proses pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan.

Integrasi manajemen risiko yang sistematis menjadi langkah krusial bagi manajer keperawatan dalam melaksanakan prevensi terhadap kejadian yang tidak diharapkan, sekaligus menjamin kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pasien yang berlaku (Haryati et al., 2019). Efektivitas penerapan sistem ini juga berkorelasi positif dengan efisiensi biaya perawatan serta penurunan angka infeksi nosokomial, sehingga meningkatkan nilai institusi di mata pengguna layanan (Rahmi, 2019), (titania, 2019). Optimalisasi peran perawat dalam setiap sasaran keselamatan pasien secara konsisten merupakan garda terdepan dalam

mencegah insiden yang dapat merugikan klien serta memastikan setiap intervensi klinis memenuhi standar profesional yang telah ditetapkan.

Sistem pelaporan insiden yang transparan dan tidak menyalahkan (non-punitive culture) perlu dikembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran organisasi dari kesalahan yang terjadi di lapangan (Sharfina, 2019; Sianipar, 2020). Penerapan metode refleksi kritis pasca-insiden diharapkan mampu mendorong transformasi budaya kerja dari sistem yang menghukum menjadi sistem yang berfokus pada pembelajaran berkelanjutan (Metilda et al., 2025; Tambunan, 2019). Pemanfaatan data sistem pelaporan memungkinkan manajemen melakukan perbaikan berkelanjutan dan memperkuat keterlibatan staf dalam membangun lingkungan kerja yang proaktif terhadap pencegahan risiko (Hasibuan, 2020; Rani, 2019). Penguatan kompetensi perawat dalam asesmen risiko dan identifikasi bahaya harus dipantau dan memastikan langkah-langkah menuju keselamatan pasien dapat diimplementasikan secara akurat dan konsisten (Lubis, 2020; Ramadani, 2019). Disiplin dalam penerapan pelatihan berkelanjutan dan supervisi manajerial secara intensif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap perawat memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola risiko klinis secara preventif.

Kepatuhan perawat terhadap seluruh prosedur keselamatan pasien tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan regulasi, tetapi juga sebagai mekanisme fundamental dalam meminimalisir risiko cedera atau kesalahan medis yang dapat berdampak fatal bagi kondisi kesehatan pasien (hafaz, 2019; Nubuwah, 2019). Keberhasilan penerapan standar ini sangat bergantung pada dukungan infrastruktur teknologi, seperti rekam medis elektronik, yang memfasilitasi integrasi data klinis secara akurat guna mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (Binta, 2025). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi serta sistem umpan balik yang terstruktur terbukti mampu mengoptimalkan efisiensi beban kerja perawat, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tindakan klinis yang krusial (Hardono & Bunga, 2025). Pemenuhan standar memerlukan evaluasi berkala terhadap sasaran keselamatan pasien dan implementasi manajemen rumah sakit yang akreditabel guna memastikan setiap prosedur klinis terlaksana dengan akurat.

3. Dimensi Mutu Asuhan Keperawatan

Mutu pelayanan keperawatan yang komprehensif diukur melalui lima dimensi utama, yaitu tangibles (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati) (Habibi et al., 2019). Penerapan dimensi reliability menekankan pada

kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan yang konsisten sesuai standar profesi guna menjamin keamanan serta efektivitas intervensi klinis. Dimensi responsiveness menuntut perawat untuk menunjukkan daya tanggap yang cepat terhadap kebutuhan pasien guna meningkatkan rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi kesehatan. Dimensi assurance mencakup pengetahuan, kompetensi, dan kesopanan staf yang krusial dalam membangun kredibilitas profesional serta memberikan rasa aman kepada pasien. Aspek empathy menuntut perawat untuk memberikan perhatian individual yang tulus, sehingga tercipta hubungan terapeutik yang efektif dalam meningkatkan kepuasan serta pengalaman positif pasien selama menerima perawatan. Kelima dimensi tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja evaluatif untuk memastikan asuhan profesional mampu memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pasien secara terstandar.

Integrasi dimensi-dimensi tersebut dalam praktik klinis terbukti secara signifikan memengaruhi tingkat kepuasan pasien, yang merupakan indikator krusial dalam evaluasi keseluruhan mutu pelayanan rumah sakit. Standar mutu berperan sebagai determinan utama bagi pasien dalam menentukan loyalitas kunjungan serta keberlangsungan operasional rumah sakit. Kepuasan pasien merupakan hasil akhir yang mencerminkan keberhasilan pendekatan sistem dalam mengelola input dan proses asuhan di fasilitas kesehatan.

Dimensi mutu asuhan keperawatan secara komprehensif mencakup aspek efektivitas, efisiensi, dan orientasi pada kebutuhan pasien yang menuntut keterlibatan kognitif serta afektif perawat secara penuh (Tambunan, 2020). Aspek keselamatan pasien diintegrasikan sebagai dimensi fundamental untuk menjamin keamanan setiap intervensi medis melalui sistem asesmen risiko, pelaporan insiden yang transparan, dan tindak lanjut evaluatif guna meminimalkan terjadinya cedera pada pasien (Purba, 2019; Sitanggang, 2019). Selain itu, peningkatan kepatuhan perawat terhadap Standar Operasional Prosedur menjadi elemen krusial dalam menjaga konsistensi pemberian asuhan yang aman bagi pasien.

Dokumentasi yang presisi berfungsi sebagai bukti otentik akuntabilitas profesional, sekaligus memfasilitasi pengambilan keputusan klinis yang tepat berdasarkan kebutuhan spesifik pasien (L.Tobing, 2020; Rambe, 2020). Penerapan sistem dokumentasi berbasis komputerisasi saat ini menjadi strategi esensial untuk memfasilitasi manajemen data keperawatan yang lebih efisien, sekaligus meningkatkan aksesibilitas informasi guna mendukung praktik pemberian asuhan yang berkelanjutan (Ginting, 2020). Kompetensi perawat dalam menyusun catatan proses keperawatan yang memenuhi standar teknis

merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan kelengkapan data medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Atmanto et al., 2020; Saputri, 2019). Ketidaklengkapan berkontribusi pada penurunan kualitas pelayanan, sehingga peningkatan pengetahuan, motivasi kerja, dan supervisi klinis yang ketat menjadi urgensi bagi manajer keperawatan untuk memitigasi risiko hukum dan klinis (Suciani et al., 2024; Yuliastanti & Wulandari, 2025).

Pencapaian standar dokumentasi yang optimal memerlukan pendekatan multidimensi, termasuk penyederhanaan formulir, pelatihan berkelanjutan, dan pemberian umpan balik berkala guna mengatasi hambatan administratif (Panjaitan et al., 2025). Selain itu, kualitas dokumentasi yang memenuhi kriteria akurat, komprehensif, dan berbasis fakta menjadi tolok ukur utama profesionalisme perawat sekaligus instrumen perlindungan hukum yang krusial (Sudaryati et al., 2022). Kesesuaian pendokumentasian dengan Standar Diagnosis, Luaran, dan Intervensi Keperawatan Indonesia menjadi parameter wajib untuk menjamin kesinambungan serta keamanan asuhan yang diberikan kepada pasien.

Efektivitas dokumentasi sebagai alat komunikasi antarprofesional kesehatan krusial dalam meminimalisir risiko kesalahan medis serta menjamin kesinambungan pelayanan yang aman. Indikator kinerja perawat dalam aspek dokumentasi tidak hanya mencakup kelengkapan administratif, tetapi juga harus mencerminkan kemampuan klinis dalam merumuskan proses keperawatan sistematis dan berbasis bukti (Megawati, 2020; Rangkuti, 2020). Dalam konteks akreditasi rumah sakit, tingkat kepatuhan terhadap standar pendokumentasian ini berfungsi sebagai parameter utama dalam menilai profesionalitas serta tanggung gugat perawat terhadap tindakan yang telah dilakukan (Saroh, 2019), (Furroidah et al., 2023).

C. Standar Mutu Asuhan Keperawatan

Standar mutu asuhan keperawatan merupakan tolok ukur esensial yang ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan konsisten dengan prinsip profesionalisme, keselamatan, dan efektivitas klinis (Asyla, 2020). Instrumen studi dokumentasi dari Departemen Kesehatan, yang meliputi enam standar operasional, menjadi acuan utama dalam mengevaluasi kepatuhan perawat terhadap penerapan proses keperawatan di lingkungan rumah sakit (ISWARA, 2020). Standar tersebut mencakup implementasi proses keperawatan yang sistematis meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sebagai metode ilmiah utama dalam penyelesaian masalah kesehatan pasien.

Penerapan standar mutu bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh tindakan keperawatan memiliki landasan teoritis yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara legal maupun profesional (Imanda, 2020), (Yeniria, 2020). Keterkaitan logis antara diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan menjadi penekanan penting agar asuhan yang diberikan benar-benar mencerminkan kebutuhan spesifik pasien secara koheren (Koerniawan et al., 2020). Terkait dengan capaian kinerja, instansi kesehatan telah menetapkan target kepatuhan standar asuhan keperawatan sebesar 90% sebagai indikator utama efektivitas pelayanan (Zebua, 2020). Kinerja perawat yang optimal tercermin dari keberhasilan dalam mengintegrasikan keenam indikator standar asuhan keperawatan ke dalam praktik klinis sehari-hari

Pencapaian target tersebut secara langsung berkorelasi dengan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, sekaligus berfungsi sebagai bukti tanggung jawab dan tanggung gugat perawat dalam praktik klinis (Halawa, 2020), (Anto et al., 2022). Hal ini sejalan dengan peran pendokumentasian sebagai metode sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan klien, merencanakan strategi pemecahan masalah, serta mengevaluasi efektivitas tindakan secara objektif (rambe, 2019). Selain itu, dokumentasi yang berkualitas tinggi meminimalisir risiko kelalaian hukum sekaligus memperkuat posisi perawat dalam menghadapi tuntutan tanggung gugat atas setiap intervensi yang diberikan (Angeline, 2020). Dengan demikian, dokumentasi asuhan keperawatan yang komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, melainkan menjadi bukti otentik atas pelaksanaan proses keperawatan yang akurat bagi kepentingan klien maupun tim kesehatan lainnya.

Kepatuhan terhadap standar ini mencerminkan kompetensi profesional dalam mengidentifikasi respon individu atau komunitas terhadap proses kesehatan, sehingga setiap tindakan yang terdokumentasi dapat menjadi dasar penilaian klinis yang objektif (Nisfu, 2020). Implementasi asuhan keperawatan yang simultan tersebut pada akhirnya akan memberikan implikasi langsung terhadap tingkat kepuasan klien atas pelayanan yang diterima (Supratti & Ashriady, 2018). Integritas dokumentasi yang konsisten juga menjadi acuan fundamental dalam proses audit medis serta evaluasi mutu pelayanan bagi institusi kesehatan secara menyeluruh (Barus, 2020). Pengintegrasian indikator kinerja ini ke dalam sistem manajemen mutu rumah sakit memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap standar akreditasi serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga keperawatan (ardiansyah, 2020), (Putri, 2020). Optimalisasi sistem pendokumentasian berperan sebagai sarana komunikasi antardisiplin yang menjamin kontinuitas perawatan bagi pasien.

1. Pengertian Standar Asuhan Keperawatan

Standar asuhan keperawatan didefinisikan sebagai acuan atau pedoman tertulis yang menetapkan kriteria performa klinis perawat dalam memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan profesional (friska, 2019; Sagala, 2020). Pedoman ini berfungsi sebagai kerangka kerja sistematis yang memastikan seluruh tindakan klinis dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan objektif pasien serta standar etika profesi yang berlaku (Tarigan, 2020). Dengan mematuhi standar ini, perawat mampu memberikan informasi klien yang komprehensif serta mendefinisikan fokus intervensi keperawatan dengan tepat bagi individu maupun kelompok (Bismar, 2020; Rahma & Simamora, 2020). Standar asuhan keperawatan berfungsi sebagai level kinerja yang dapat dicapai untuk membandingkan performa aktual perawat dalam menjalankan tanggung jawab klinisnya setiap waktu.

Penetapan standar asuhan keperawatan bertujuan untuk memberikan pernyataan baku mengenai kualitas serta kuantitas dokumentasi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan klinis yang berkelanjutan (Safira, 2019). Pendokumentasian yang akurat juga memfasilitasi koordinasi interprofesional yang efektif, sehingga mencegah terjadinya duplikasi tindakan yang tidak efisien dalam sistem pelayanan kesehatan (Sari, 2020 ;Barus, 2020). Selanjutnya, pendokumentasian yang sistematis berfungsi sebagai sumber data penelitian serta indikator mutu yang krusial bagi manajemen rumah sakit dalam upaya peningkatan standar akreditasi (Karima, 2020; Sihombing, 2019). Standar asuhan keperawatan berfungsi sebagai instrumen evaluasi guna memastikan efisiensi dan efektivitas pelayanan secara menyeluruh. Dan menjamin bahwa setiap tindakan keperawatan memiliki bukti pencatatan yang objektif dan lengkap, untuk melindungi hak-hak pasien serta memperkuat posisi legal tenaga keperawatan dalam lingkup pelayanan kesehatan.

Disiplin dalam penerapan standar mendukung terciptanya akuntabilitas setiap anggota tim dalam memberikan perawatan yang komprehensif bagi pasien (Tarigan, 2019). Pencapaian standar ini sangat dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang harus dihormati oleh setiap perawat dalam praktik klinis. Peningkatan kompetensi perawat dalam memahami regulasi dokumentasi terbukti berkorelasi positif dengan efektivitas pelaksanaan asuhan keperawatan yang berorientasi pada keselamatan pasien (Inayati & Sriyati, 2020). Oleh karena itu, penguasaan terhadap standar ini menjadi prasyarat mutlak bagi perawat untuk menjamin kesinambungan layanan yang aman dan berkualitas selama 24 jam penuh. Dengan demikian, pemahaman mendalam serta keterampilan praktis dalam menerapkan standar

tersebut merupakan keharusan bagi tenaga keperawatan untuk menjamin efektivitas serta kelancaran koordinasi antar disiplin ilmu (S, 2019; Safitri, 2019).

Kepatuhan dalam menerapkan standar asuhan keperawatan menjadi indikator esensial bagi manajemen rumah sakit untuk memantau kelengkapan catatan asuhan sebagai bukti pertanggungjawaban hukum dan evaluasi mutu pelayanan profesional (Sari, 2019; titania, 2019). Implementasi standar secara konsisten berfungsi sebagai alat ukur efektivitas kinerja perawat dalam aspek klinis, edukatif, dan administratif (Aulia, 2020; jannati, 2019). Perlu adanya pendidikan berkelanjutan bagi para perawat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan konsep proses keperawatan.

2. Fungsi dan Manfaat Standar Mutu Asuhan Keperawatan

Standar mutu asuhan keperawatan berfungsi sebagai kerangka acuan utama yang menjamin konsistensi pelayanan profesional, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi perawat dan institusi kesehatan melalui kelengkapan catatan asuhan yang sistematis (Sihaloho, 2020; silalahi, 2020). Optimalisasi sumber daya manusia dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak pasien terhadap pelayanan yang manusiawi dan berkualitas (Prayogi, 2018; Simamora et al., 2017). Implementasi standar mutu berperan signifikan dalam meminimalisir tingkat kesalahan, karena setiap tindakan yang diberikan berbasis pada bukti empiris yang terukur.

Penguatan supervisi berjenjang yang terstruktur secara klinis terbukti mampu memastikan bahwa setiap proses dokumentasi tetap selaras dengan instrumen mutu yang berlaku, sehingga meminimalisir risiko ketidaksesuaian asuhan di lapangan (Fatimah & Sulistyowati, 2025). Supervisi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai pemantauan administratif, tetapi juga sebagai sarana penguatan motivasi agar perawat tetap konsisten mendokumentasikan setiap tahapan asuhan mulai dari pengkajian hingga evaluasi (Maulani, 2016). Dengan demikian, pendokumentasian yang komprehensif menjadi alat komunikasi vital antara tim kesehatan, keluarga, dan pasien, sekaligus menjadi indikator utama keberhasilan asuhan yang bermutu. Pencapaian target dokumentasi yang optimal menjadi tolok ukur esensial dalam penilaian kinerja klinis, mengingat ketidaklengkapan catatan dapat menurunkan mutu pelayanan secara keseluruhan.

Kelengkapan catatan medis merupakan wujud nyata produktivitas kerja yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesionalisme unit kesehatan (Pasaribu, 2020; Wahyudi & Gunarto, 2019). Integrasi sistem

pendokumentasian yang sistematis meminimalkan risiko kesalahan pemberian asuhan sekaligus memperkuat bukti pertanggungjawaban perawat dalam aspek hukum dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Elvahra, 2020; Mardiani, 2019). Pentingnya standardisasi dalam praktik ini juga mencakup fungsi edukasi dan penelitian, di mana data yang terdokumentasi dengan benar menjadi dasar pengembangan ilmu keperawatan yang berkelanjutan (Sipayung, 2020). Oleh karena itu, penguatan kepatuhan perawat terhadap standar dokumentasi melalui supervisi klinis secara konsisten mutlak diperlukan guna memastikan kesinambungan kualitas asuhan yang diberikan kepada pasien (Cahyo et al., 2025; Hanhara, 2019). Penerapan supervisi ini juga berfungsi sebagai pendekatan reflektif yang memberdayakan perawat dalam menghadapi tantangan klinis, sekaligus memfasilitasi dukungan emosional yang krusial untuk menjaga stabilitas kualitas layanan.

3. Penyusunan dan Implementasi Standar Asuhan Keperawatan

Proses ini diawali dengan pembentukan tim penyusun yang bertanggung jawab merumuskan draf panduan, Standar Prosedur Operasional, serta instrumen penilaian mutu yang komprehensif (Habibi et al., 2022). Langkah selanjutnya melibatkan uji coba instrumen tersebut melalui mekanisme supervisi klinis yang terstruktur guna memastikan relevansi dan akseptabilitasnya dalam praktik keperawatan di lapangan (Sembiring, 2020; Wijaya et al., 2025). Setelah tahap uji coba, dilakukan evaluasi kritis untuk mengidentifikasi hambatan administratif maupun teknis yang mungkin menghambat kepatuhan perawat dalam melakukan pendokumentasian yang lengkap (Anshori et al., 2014). Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai basis perbaikan berkelanjutan dengan mempertimbangkan tingkat pengetahuan, kepatuhan, serta efektivitas supervisi kepala ruangan dalam mengarahkan perawat pelaksana (Nurfanita, 2025; Wahyuliati & Novita, 2023). Implementasi model supervisi berbasis digital, seperti penggunaan formulir elektronik yang diisi secara real-time, dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan konsistensi dan akurasi data dokumentasi (Utami et al., 2025).

Penggunaan teknologi informasi dalam dokumentasi keperawatan ini perlu didukung dengan pelatihan berkelanjutan bagi perawat pelaksana agar pemanfaatan sistem selaras dengan standar mutu yang telah ditetapkan (Purwandari et al., 2022). Selain itu, pemanfaatan sistem rekam medis elektronik ini berperan krusial dalam mempercepat alur informasi interprofesional, yang secara langsung meningkatkan efisiensi serta akurasi pengambilan keputusan klinis (Perdana et al., 2026). Penerapan pendekatan ini juga membantu

memitigasi kendala dokumentasi yang masih di bawah standar dengan memastikan bahwa setiap tahapan asuhan terekam dengan jelas (Manuhutu et al., 2020). Selanjutnya, penguatan fungsi manajemen pada level kepala ruang melalui supervisi berjenjang yang terintegrasi dengan sistem IT terbukti efektif dalam mengoptimalkan performa perawat serta menjamin kepatuhan terhadap standar asuhan (Oktaviarini et al., 2023). Upaya ini memerlukan komitmen manajerial dalam mensosialisasikan prosedur secara berkala agar setiap perawat memahami tanggung jawab profesional mereka dalam menjaga kualitas layanan (Chrismilasari et al., 2025).

Selanjutnya, evaluasi berkala terhadap indikator kinerja individu maupun unit harus dilakukan guna memastikan bahwa setiap perubahan dalam metode dokumentasi selaras dengan standar profesional dan tuntutan akreditasi yang berlaku (Wulandari & Handiyani, 2019). Untuk mendukung keberhasilan implementasi tersebut, penggunaan metode berbasis data seperti **Weighted Scoring** dapat diterapkan guna memprioritaskan penyelesaian masalah klinis yang paling krusial di unit pelayanan (Panjaitan et al., 2025). Selain itu, pemberian penghargaan (**reward**) dan penerapan sanksi (**punishment**) yang proporsional bagi perawat perlu diintegrasikan dalam kerangka penilaian kinerja untuk memotivasi peningkatan kelengkapan dokumentasi secara berkelanjutan (Heryyanoor et al., 2023; Noorkasiani et al., 2015). Selain itu, transisi menuju sistem dokumentasi berbasis elektronik terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi waktu pencatatan dan akurasi data dibandingkan metode konvensional yang berisiko tinggi terhadap kehilangan informasi (Firmansyah et al., 2025). Meskipun demikian, keberhasilan transformasi digital ini sangat bergantung pada mitigasi tantangan teknis serta manajemen beban kerja perawat agar tidak menghambat efektivitas pelayanan (Agustina et al., 2024; Ramadhani et al., 2025).

D. Indikator Kinerja Perawat

Indikator kinerja perawat mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, seperti ketepatan waktu dalam pendokumentasian elektronik serta tingkat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan (Noviani et al., 2025). Motivasi kerja dan tingkat pemahaman perawat terhadap konsep dokumentasi asuhan keperawatan berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan pencapaian indikator-indikator tersebut (Furroidah et al., 2023), (Wigatama et al., 2020). Budaya kerja yang positif menjadi faktor penting dalam membentuk kompetensi klinis serta profesionalisme perawat di lingkungan rumah sakit.

Pencapaian indikator kinerja ini juga sangat bergantung pada optimalisasi supervisi klinis yang dilakukan secara berjenjang guna meninjau efektivitas praktik berbasis standar 3S dalam proses asuhan harian (Fajri & Arif, 2025), (Yuliastanti & Wulandari, 2025). Mengingat bahwa beban kerja yang berlebih dan tingkat stres yang tidak terkelola dapat menjadi hambatan utama dalam mempertahankan akurasi pendokumentasian tersebut (Mayenti et al., 2024). Faktor-faktor seperti ketersediaan sarana pendukung, pelatihan yang memadai, serta mekanisme reward dan punishment yang transparan merupakan kunci empiris yang memengaruhi kepatuhan perawat dalam menjalankan proses dokumentasi (Purba, 2019). Oleh karena itu, integrasi rekam medis elektronik yang berlandaskan standar 3S perlu diperkuat melalui sistem informasi yang intuitif guna meminimalkan hambatan teknis serta meningkatkan kelengkapan dokumentasi.

Pengembangan strategi manajerial yang komprehensif, seperti penguatan sistem reward dan motivasi, terbukti signifikan dalam meningkatkan performa perawat dibandingkan dengan faktor tingkat pendidikan semata (Salim et al., 2024). Penekanan aspek supervisi yang tegas serta pendampingan manajerial secara berkelanjutan menjadi strategi esensial untuk meminimalisir deviasi dalam pendokumentasian asuhan keperawatan (Supratti & Ashriady, 2018). Penguatan supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana pemberian umpan balik konstruktif guna memperbaiki kedisiplinan perawat dalam mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Integrasi indikator kinerja berbasis data ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi tenaga keperawatan melalui bukti otentik praktik profesional yang terdokumentasi secara sistematis (Amalia et al., 2018). Implementasi sistem berbasis NANDA-I, NIC, dan NOC terbukti meningkatkan pemahaman perawat terhadap standar terminologi klinis yang krusial bagi kesinambungan asuhan. Oleh karena itu, penyelarasan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan operasional di lapangan harus didukung oleh kebijakan manajerial yang konsisten guna menjamin perubahan perilaku dalam praktik pendokumentasian (Saputra et al., 2020). Pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui pelatihan terfokus diperlukan guna meningkatkan kemampuan teknis perawat dalam mengoperasikan sistem informasi secara lebih akurat dan efisien.

1. Konsep Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan instrumen evaluasi sistematis yang digunakan untuk memantau, memonitor, dan menyimpulkan efektivitas pelayanan asuhan keperawatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit (Murni, 2019). Pengukuran ini mencakup kepatuhan perawat dalam melakukan pencatatan asuhan secara sistematis, yang merupakan kewajiban profesional sesuai dengan regulasi

pemerintah (Siahaan et al., 2021a, 2021b). Kewajiban ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010, yang mengamanatkan bahwa setiap perawat harus melaksanakan pendokumentasian asuhan secara komprehensif sebagai bagian dari tanggung jawab praktik klinis (Siahaan et al., 2021). Penerapan standar 3S dalam praktik sehari-hari menjadi tolok ukur utama bagi perawat dalam memenuhi persyaratan medico-legal yang menjamin keamanan dan efektivitas asuhan pasien (Wahyuliati et al., 2024; Wisuda et al., 2025). Penerapan metode asuhan berperan sebagai instrumen krusial dalam menunjang akreditasi, statistik, dan komunikasi lintas disiplin di lingkungan layanan kesehatan.

Intervensi pelatihan berbasis 3S ini terbukti meningkatkan pengetahuan praktisi keperawatan secara signifikan, dengan tingkat capaian pemahaman yang dapat mencapai angka sempurna setelah program edukasi intensif dilakukan (Mayenti et al., 2025). Hal ini didukung oleh temuan empiris yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan perawat dengan kepatuhan penerapan standar SDKI, SIKI, dan SLKI dalam praktik klinis (Wijaya & Juniarti, 2025). Sebagai instrumen evaluasi yang terukur, indikator ini berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah tindakan yang diberikan telah memenuhi kriteria keselamatan, efektivitas, dan etika profesi yang dipersyaratkan (Sulistyawati & Susmiati, 2020). Optimalisasi penggunaan 3S dalam dokumentasi asuhan berfungsi sebagai alat bukti akuntabilitas yang krusial, mengingat masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan perawat yang mumpuni dan tingkat penerapan praktis yang belum mencapai hasil optimal di lapangan (Febrianita & Riski, 2024). Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi seperti pelatihan terstruktur yang terbukti efektif meningkatkan kesesuaian pendokumentasian terhadap standar 3S secara berkala.

2. Jenis-jenis Indikator Kinerja Perawat

Indikator kinerja perawat secara umum dikategorikan ke dalam dua dimensi utama, yakni indikator proses yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap standar asuhan dan indikator hasil yang berorientasi pada keluaran klinis pasien. Indikator proses mencakup ketepatan perawat dalam melakukan pengkajian, perumusan diagnosis, serta pemilihan intervensi yang relevan dengan standar 3S (Muhsinah et al., 2025). Di sisi lain, indikator hasil berfokus pada evaluasi capaian kesehatan pasien yang diukur melalui standar luaran keperawatan, guna memastikan bahwa setiap tindakan memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan kondisi klien (Qasim et al., 2024). Pengembangan

instrumen evaluasi kinerja yang terintegrasi dengan kerangka 3S juga memerlukan validasi sistematis untuk memastikan akurasi data dalam audit klinis serta menunjang pengambilan keputusan berbasis bukti bagi manajer keperawatan (Wisuda et al., 2025). Pencapaian target kinerja ini juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas supervisi klinik yang mampu menjembatani hambatan teknis dalam pengisian rekam medis terintegrasi (Wanti et al., 2022).

Integrasi indikator kinerja yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam menciptakan pelayanan keperawatan yang profesional, aman, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien (Dewi et al., 2021; Napitu, 2020). Keterkaitan yang terukur antara ketiga komponen tersebut berfungsi sebagai indikator kunci bagi manajer keperawatan untuk mengevaluasi efektivitas setiap tindakan medis yang diberikan kepada pasien (Koerniawan et al., 2020). Audit keperawatan yang dilakukan secara rutin merupakan peran vital dalam memastikan konsistensi dan akurasi data dalam rekam medis, yang berfungsi meningkatkan kualitas asuhan serta keselamatan pasien secara keseluruhan (Metilda et al., 2026). Mengingat efikasi audit tersebut, peran kepala ruangan sebagai manajer lini depan menjadi krusial dalam memberikan pendampingan dan supervisi berkelanjutan guna memastikan setiap kegiatan klinis selaras dengan tujuan organisasi serta standar mutu yang telah ditetapkan.

Upaya optimalisasi peran tersebut dapat dilakukan melalui supervisi klinis yang konsisten, di mana kepala ruangan bertanggung jawab memastikan seluruh staf perawat memiliki kompetensi yang relevan dalam pemenuhan standar dokumentasi (Teresa et al., 2021), (Fatimah & Sulistyowati, 2025). Pemberian umpan balik yang terstruktur mengenai hasil capaian indikator ini merupakan langkah strategis untuk membangun rasa saling memiliki di antara staf, sekaligus meningkatkan motivasi dan kinerja profesional mereka (Nurdiana et al., 2018), (Salsabila, 2020). Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan yang suportif dari kepala ruangan merupakan elemen penting dalam menggerakkan sumber daya untuk mencapai sasaran mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Lestari et al., 2025). Pengelolaan sistem manajerial yang tepat sangat krusial untuk mengarahkan sumber daya keperawatan agar konsisten dalam memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.

Penguatan fungsi pengawasan oleh kepala ruangan terbukti memiliki korelasi signifikan terhadap kelengkapan pendokumentasian asuhan keperawatan sebagai bukti legal dan profesionalisme pemberian layanan (Fitrawan et al., 2022), (Umasangadji, 2025). Penguatan aspek pengarahan dan motivasi dari kepala ruangan secara langsung memengaruhi ketepatan pendokumentasian serta kualitas luaran asuhan keperawatan di unit rawat inap

(Sartiwi, 2014), (Rusmianingsih et al., 2023). Oleh karena itu, penyelarasan antara gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan pemahaman perawat mengenai standar operasional prosedur menjadi kunci utama dalam memperbaiki angka kepatuhan dokumentasi (Kurniawati, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, penilaian kinerja yang akurat menuntut adanya hubungan logis antara diagnosis, intervensi, dan luaran sebagai satu kesatuan proses yang koheren dalam dokumentasi.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perawat

Kinerja perawat sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta motivasi individu yang menentukan kualitas praktik asuhan (Soekerno et al., 2025). Beban kerja yang tidak seimbang, kurangnya supervisi dari kepala ruangan, serta keterbatasan sistem pendokumentasian sering menjadi hambatan signifikan dalam mencapai standar mutu pelayanan yang optimal (Yuliastanti & Wulandari, 2025). Selain faktor tersebut, karakteristik psikologis dan kelelahan kerja juga terbukti secara empiris memiliki korelasi negatif terhadap ketepatan pendokumentasian asuhan di lingkungan rumah sakit (Mayenti et al., 2025). Ketersediaan infrastruktur pendukung dan kemudahan akses pada sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan salah satu penunjang kepatuhan tenaga keperawatan dalam melaksanakan tugas dokumentasi keperawatan setiap waktu.

Manajemen beban kerja yang efektif melalui redistribusi tugas secara proporsional terbukti mampu mengurangi stres kerja, yang secara signifikan meningkatkan kepatuhan perawat dalam memenuhi standar dokumentasi elektronik (Dewi et al., 2024). Di samping aspek teknis, dukungan manajerial melalui kebijakan strategis untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan menjadi kunci keberhasilan dalam transformasi digital di lingkungan rumah sakit (Silalahi, 2020). Faktor motivasi kerja, gaya kepemimpinan kepala ruang, dan tingkat kompetensi profesional juga terbukti secara signifikan memengaruhi kesediaan perawat dalam mengimplementasikan perubahan standar asuhan ke arah yang lebih berkualitas (Fortuna, 2025). Sistem kompensasi yang adil dan transparan berperan penting sebagai stimulus eksternal dalam mempertahankan performa kerja yang optimal serta meningkatkan komitmen perawat terhadap standar mutu pelayanan. Kompetensi perawat dalam mengoperasikan sistem informasi harus terus ditingkatkan, mengingat keterbatasan kemampuan teknis sering menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

E. Upaya Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan dan Kinerja Perawat

Pengembangan strategi peningkatan mutu asuhan keperawatan memerlukan pendekatan komprehensif melalui penyelenggaraan pelatihan teknis berbasis standar 3S yang terbukti secara signifikan meningkatkan kesesuaian pendokumentasian (Wahyuliati et al., 2024). Selain pelatihan, implementasi diskusi refleksi kasus secara rutin dapat memfasilitasi perawat dalam mengasah kemampuan berpikir kritis sekaligus memecahkan kendala teknis terkait penerapan standar 3S (Sudaryati et al., 2022). Intervensi ini didukung oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa pelatihan terstruktur, yang mencakup simulasi kasus dan praktik langsung, berkontribusi nyata terhadap peningkatan pengetahuan serta keterampilan klinis perawat dalam mengaplikasikan kerangka kerja SDKI, SLKI, dan SIKI (Wisuda, Suraya, Oxyandi, et al., 2025; Wisuda, Suraya, Rusmarita, et al., 2025). Selain itu, integrasi simulasi peran dalam program pengembangan staf memungkinkan perawat untuk mempraktikkan pengisian catatan keperawatan secara akurat, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan di bangsal rawat inap (Wisuda & Suraya, 2024). Lebih lanjut, penguatan kompetensi melalui pertukaran gagasan dan pengalaman klinis antar sejawat berperan penting dalam menciptakan budaya kerja yang berbasis pada bukti untuk menjaga keselamatan serta etika asuhan pasien.

Upaya berkelanjutan ini selaras dengan kebutuhan untuk menyelaraskan praktik klinis dengan SDKI, SIKI, dan SLKI sebagai tolok ukur standar dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan etis bagi setiap pasien (Sulistiyawati & Susmiati, 2020). Transformasi praktik berbasis standar ini memerlukan komitmen institusional dalam menyediakan panduan praktis yang aplikatif untuk mengatasi tantangan pemahaman perawat di lapangan. Strategi ini hendaknya didukung dengan metode pelatihan, seminar, dan workshop yang terbukti secara signifikan meningkatkan kemampuan perawat dalam penerapan 3S sesuai standar prosedur operasional.

Pemanfaatan model evaluasi kinerja berbasis data klinis yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan manajer keperawatan untuk memetakan kesenjangan kompetensi guna merancang intervensi edukatif yang lebih relevan dan berkelanjutan (Romawati et al., 2024). Selanjutnya, pendekatan supervisi klinik yang terintegrasi secara empiris telah terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja perawat dalam mengelola asuhan keperawatan di unit rawat inap (Sitorus et al., 2025). Implementasi sistem evaluasi yang terstruktur ini juga menuntut keterlibatan aktif pimpinan unit dalam memberikan umpan balik

berbasis bukti untuk memastikan bahwa setiap perawat mampu beradaptasi dengan standar asuhan terbaru.

1. Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Program pengembangan profesional ini harus mencakup diseminasi ilmu mendalam mengenai konsep 3S serta sesi simulasi peran untuk memperkuat pemahaman praktis perawat dalam konteks klinis (Wisuda & Suraya, 2024). Kegiatan ini diperluas dengan melibatkan diskusi kelompok terfokus guna memecahkan hambatan implementasi secara kolektif, sehingga setiap perawat dapat mencapai standar kompetensi yang diharapkan dalam pemberian asuhan yang aman (Simamora, 2019). Penerapan model supervisi 4S yang mencakup struktur, keterampilan, dukungan, dan keberlanjutan dapat menjadi instrumen strategis untuk memantau efektivitas penerapan standar asuhan di berbagai unit pelayanan (Arif et al., 2024). Manajemen rumah sakit perlu membangun komitmen kuat melalui penyediaan fasilitas yang memadai serta lingkungan kerja yang mendukung budaya tanpa hukuman untuk memperkuat perlindungan bagi perawat dan pasien.

Pengembangan standar kinerja perawat harus diintegrasikan dengan indikator mutu pelayanan yang berfokus pada budaya keselamatan pasien sebagai upaya nyata dalam mitigasi insiden klinis (Suci, 2018). Pihak manajemen rumah sakit memegang peranan krusial dalam menjamin kepatuhan seluruh staf terhadap panduan operasional guna meminimalkan risiko kesalahan identifikasi maupun insiden klinis yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien (Anisah & Jati, 2022; Warashati et al., 2020). Selain itu, institusionalisasi pelatihan berbasis bukti dan keterlibatan perawat dalam komite keselamatan rumah sakit terbukti memperkuat domain budaya keselamatan yang berkorelasi positif dengan indikator kinerja utama, seperti pengendalian infeksi dan manajemen obat (Ibrahim et al., 2025). Integrasi sistem berpikir dalam kurikulum keperawatan dan standar nasional keselamatan pasien juga perlu diperkuat guna membekali tenaga kesehatan dengan kompetensi analisis kesalahan yang mumpuni (Atalla et al., 2025). Terciptanya lingkungan belajar berkelanjutan di mana perawat didukung untuk terus mengembangkan kemampuan klinisnya akan berdampak positif pada kualitas asuhan dan keselamatan pasien secara holistik.

Selain itu, pemetaan faktor internal individu, seperti masa kerja dan tingkat pendidikan, harus dijadikan dasar dalam menyusun program pengembangan sumber daya manusia yang lebih adaptif (harahap, 2019). Peningkatan interaksi antara supervisor dan perawat melalui mekanisme supervisi yang terstruktur juga krusial untuk memastikan bahwa profesionalisme praktik keperawatan

tetap terjaga di setiap unit pelayanan (Fatonah & Yustiawan, 2020). Penyusunan instrumen supervisi klinis yang berjenjang menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap perawat manajer dapat memonitor kinerja klinis secara akurat dan konsisten (Dahlia et al., 2020). Penerapan supervisi yang efektif oleh kepala ruang secara konsisten dan berkelanjutan mampu menjembatani antara pemahaman teoritis perawat dan perubahan perilaku klinis yang nyata dalam pelayanan.

2. Supervisi dan Pembinaan

Pelaksanaan supervisi keperawatan yang terstruktur secara sistematis berfungsi sebagai fungsi manajerial untuk menjamin kepatuhan terhadap standar operasional prosedur sekaligus meningkatkan profesionalisme pelayanan. Interaksi profesional melalui supervisi memungkinkan perawat untuk menerima bimbingan, dukungan, dan bantuan yang krusial bagi pengembangan keterampilan klinis serta peningkatan sikap kepedulian terhadap pasien (Wati et al., 2019). Pengawasan klinis yang efektif melalui pendekatan kolaboratif mampu mengoptimalkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi yang komprehensif bagi pasien dan keluarganya (Tambun et al., 2020). Implementasi metode supervisi berjenjang tidak hanya memfasilitasi umpan balik yang terarah, tetapi juga terbukti secara signifikan meningkatkan kesesuaian dokumentasi asuhan keperawatan dan mutu pelayanan secara keseluruhan (Fatimah & Sulistyowati, 2025).

Efektivitas supervisi klinik yang berkelanjutan memerlukan pelatihan kontinu bagi kepala ruangan agar keterampilan manajerial dan teknis manajerial tetap relevan dengan perkembangan standar mutu asuhan. Keterlibatan aktif kepala ruangan dalam proses evaluasi ini juga berperan penting dalam merespons tuntutan masyarakat akan kualitas asuhan yang terampil dan berbasis ilmu keperawatan yang mutakhir (Hursepuny & Tarigan, 2024). Dengan demikian, program pelatihan yang terfokus pada keterampilan supervisi klinis menjadi instrumen esensial untuk memotivasi staf dalam meningkatkan mutu asuhan dan efektivitas dokumentasi keperawatan (Suryati et al., 2025). Sinergi antara motivasi ekstrinsik melalui supervisi dan penguatan kapasitas klinis staf terbukti mampu meningkatkan kualitas pendokumentasian dari kategori kurang baik menjadi baik pada seluruh tahapan proses keperawatan (Manuhutu et al., 2020). Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kepemimpinan kepala ruang dalam memberikan umpan balik konstruktif guna meminimalisir kelalaian administratif yang kerap terjadi (Wahyuliati & Novita, 2023; .

Tidak disiplinnya fase kontrol menjadi faktor utama rendahnya kelengkapan catatan asuhan keperawatan (Salsabila, 2020). Oleh karena itu, kepala ruangan perlu menerapkan pendekatan yang suportif dengan menghargai setiap kontribusi perawat untuk membangun motivasi kerja, daripada sekadar berfokus pada identifikasi kesalahan dalam dokumentasi. Selain itu, pemberian penghargaan dan dukungan interpersonal dari manajer unit secara konsisten terbukti mampu meningkatkan motivasi kerja perawat secara signifikan, berdampak pada kepatuhan pelaksanaan standar asuhan. Integrasi antara penguatan motivasi intrinsik dan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi melalui program pelatihan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memelihara standar mutu jangka panjang (Taufik et al., 2024), (Miladiyah et al., 2015). Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga keperawatan yang tidak proporsional dengan beban kerja pasien sering kali menjadi kendala objektif yang menghambat konsistensi pendokumentasian, sehingga diperlukan penyesuaian rasio perawat-pasien sebagai bagian dari strategi manajemen mutu (Sutomo & Usman, 2019).

Optimalisasi sistem kerja juga harus memperhatikan faktor organisasi dan psikologis yang berpengaruh langsung terhadap motivasi perawat dalam menjalankan tanggung gugat profesionalnya (Sitorus, 2020). Sebagai langkah strategis, manajemen rumah sakit dapat mengadopsi sistem dokumentasi berbasis komputerisasi guna mengurangi beban administratif yang membebani perawat serta mempercepat proses pencatatan asuhan (Heryyanoor et al., 2023). Di samping pemanfaatan teknologi, upaya untuk meningkatkan motivasi perawat harus didukung oleh penguatan faktor intrinsik seperti tanggung jawab dan pengakuan atas pencapaian klinis mereka (Hanhara, 2019). Implementasi kebijakan yang menekankan pada sistem kompensasi dan pengakuan yang adil terbukti memiliki hubungan bermakna terhadap peningkatan kinerja perawat dalam melaksanakan dokumentasi asuhan sesuai standar (Erma, 2013). kepala ruangan perlu memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pemberdayaan perawat melalui hubungan interpersonal yang suportif untuk menstimulasi motivasi kerja secara berkelanjutan.

3. Sistem Penghargaan dan Pengakuan

Penerapan sistem penghargaan yang terstruktur, baik berupa insentif finansial maupun bentuk pengakuan profesional, terbukti mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik perawat dalam menjalankan tanggung jawab pendokumentasian yang tepat (Hisamjulfikrimunthe, 2019;

kartika, 2019). Selain itu, keterlibatan aktif manajemen dalam mengapresiasi pencapaian kinerja individu secara konsisten dapat memperkuat komitmen perawat terhadap standar mutu pelayanan, yang secara tidak langsung berdampak pada peningkatan kualitas dokumentasi asuhan (kaban, 2019). Lebih lanjut, transparansi dalam kriteria penilaian kinerja menjadi elemen vital yang memastikan bahwa setiap perawat memahami kaitan langsung antara upaya pendokumentasian yang akurat dengan evaluasi profesional mereka (Zahlimar, 2023), (Passya et al., 2019). Pemberian penghargaan yang tepat dapat meminimalisir perilaku menyimpang dan mendorong perawat untuk bekerja secara maksimal dalam memenuhi tuntutan administratif.

Kebijakan penerapan reward dan punishment dari pimpinan memiliki pengaruh dominan terhadap peningkatan produktivitas kinerja perawat dibandingkan dengan motivasi kerja. Selain itu, penyediaan sarana pendukung yang memadai, seperti formulir dengan format yang efisien dan material penunjang yang berkualitas, merupakan langkah krusial untuk memfasilitasi PPA dalam menjalankan kewajiban pendokumentasian secara lebih efektif (Purbobinuko et al., 2021). Pendekatan ini memerlukan evaluasi berkala terhadap alur kerja administratif guna mengidentifikasi hambatan teknis yang menghalangi perawat dalam mencatat data pasien secara akurat dan tepat waktu (Panjaitan et al., 2025). Perbaikan kualitas supervisi oleh pimpinan perlu diprioritaskan sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan telah terdokumentasi sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

F. Simpulan

Peningkatan mutu asuhan keperawatan secara komprehensif menuntut sinergi antara kebijakan manajemen yang suportif, sistem supervisi yang terstruktur, serta penguatan kompetensi klinis perawat (Metilda et al., 2026). Integrasi antara pengembangan kapasitas profesional dan sistem pengawasan berbasis digital perlu diperkuat untuk menjamin pemenuhan standar dokumentasi yang akurat dan konsisten (Nurfanita, 2025); Utami et al., 2025). Selain itu, pembatasan rasio jumlah pasien yang ditangani perawat perlu dipertimbangkan agar staf dapat lebih fokus dan bertanggung jawab dalam memenuhi kelengkapan catatan asuhan yang berkualitas (Amalia et al., 2018). Manajemen rumah sakit perlu menetapkan kebijakan formal terkait pendokumentasian berbasis sistem informasi untuk menjamin perlindungan hukum bagi perawat sekaligus memastikan akuntabilitas pelayanan.

Pemberian pelatihan berkala mengenai standar dokumentasi yang merujuk pada standar diagnosis, luaran, dan intervensi keperawatan perlu diintensifkan guna mengurangi beban kerja kognitif perawat. Standardisasi dokumentasi yang selaras dengan Standar Diagnosis, Luaran, dan Intervensi Keperawatan Indonesia menjadi krusial untuk mencegah risiko kesalahan klinis serta menjamin kesinambungan asuhan bagi pasien (Fatmawati et al., 2024). Transformasi sistem dokumentasi dari manual ke arah digitalisasi yang terintegrasi secara komprehensif terbukti mampu meningkatkan kualitas serta efisiensi pendokumentasian asuhan secara nyata (ningsih, 2017). Peningkatan efektivitas supervisi kepala ruangan, yang mencakup pengarahan, motivasi, dan evaluasi berkelanjutan, terbukti secara empiris memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan perawat dalam melakukan pendokumentasian asuhan (Cahyo et al., 2025; Sartiwi, 2014). Hal ini sejalan dengan regulasi yang mewajibkan perawat untuk mencatat asuhan keperawatan secara sistematis sebagai bentuk pemenuhan kewajiban profesional sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 (Siahaan, Nababan, Harefa, et al., 2021; Siahaan, Nababan, Sinaga, et al., 2021).

Selain regulasi tersebut, pengembangan budaya kerja yang kolaboratif dan suportif merupakan faktor determinan yang secara positif memengaruhi kinerja perawat dalam mempertahankan standar dokumentasi yang berkualitas (Wuryanti, 2025). Faktor internal seperti tingkat motivasi dan pengalaman kerja perawat perlu menjadi perhatian utama manajemen, mengingat keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendokumentasian asuhan di ruang rawat inap (Soekerno et al., 2025; Umihara et al., 2024). Selanjutnya, optimalisasi beban kerja melalui penyesuaian rasio perawat-pasien serta penyediaan sarana pendukung yang memadai harus diintegrasikan dengan sistem penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang transparan untuk mendorong konsistensi kinerja staf (Supratti & Ashriady, 2018), (Purba, 2019). Mengingat beban kerja sering menjadi hambatan utama dalam penyelesaian dokumentasi, manajemen perlu mengalokasikan waktu yang memadai agar perawat dapat melakukan pencatatan asuhan komprehensif tanpa mengabaikan aspek keselamatan pasien.

Audit rekam medis secara berkala berbasis instrumen nasional juga harus dilakukan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap standar minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Keristiana et al., 2026; Nindyanto et al., 2013). Pelaksanaan supervisi yang dilakukan secara konsisten oleh kepala ruangan berfungsi sebagai variabel penentu yang dapat meningkatkan motivasi perawat dalam memenuhi kewajiban pendokumentasian secara akurat (Agustina, 2020; Suryani et al., 2024). Keterlibatan aktif manajemen dalam menyediakan lingkungan

kerja yang kondusif berkorelasi dengan peningkatan kepatuhan dan kualitas dokumentasi asuhan di unit rawat inap (Susiana et al., 2019). Perilaku perawat dalam menjaga kredibilitas catatan medis juga sangat dipengaruhi oleh tingkat motivasi kerja dan pengalaman klinis, sehingga intervensi manajemen harus menyorot pada aspek psikologis serta profesionalisme staf (Hasmawati et al., 2020). Selaras dengan hal tersebut, peningkatan kompetensi klinis perawat melalui pelatihan berkelanjutan diharapkan berkorelasi positif dengan perbaikan akurasi serta kelengkapan pendokumentasian proses keperawatan di lingkungan layanan kesehatan.

G. Referensi

- (I'ien), N., , I. (2026). Manajemen Keperawatan Berbasis Mutu, Keselamatan Pasien, dan Pelayanan Profesional. In *Neliti*.
<https://repository.cideka.com/publications/688419/manajemen-keperawatan-berbasis-mutu-keselamatan-pasien-dan-pelayanan-profesional>
- Agustina, A., Sillemu, S., Has, E. M. M., & Indarwati, R. (2024). Dokumentasi Keperawatan Elektronik untuk Meningkatkan Kualitas Asuhan Keperawatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*. <https://doi.org/10.33846/sf15230>
- Agustina, B. (2020). HUBUNGAN MOTIVASI DAN SUPERVISI DENGAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RSUD KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019. In *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University.
- Ahsan, A., Setyoadi, S., Noviyanti, L. W., Syahniar, & Putri, N. (2019). PENGARUH PELATIHAN BERBASIS KNOWLEDGE MANAGEMENT TERHADAP KELENGKAPAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG 26 HCU PARU RUMAH SAKIT SAIFUL ANWAR MALANG. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL*, 27–32.
<http://ejournal.stikesmajapahit.ac.id/index.php/PSN/article/download/334/332>
- Amalia, A., Malini, H., & Yulia, S. (2018). Kepuasan Perawat Terhadap Kualitas Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berbasis Komputer. *Deleted Journal*, 21(3), 169–179. <https://doi.org/10.7454/jki.v21i3.680>
- Andoko, A., & Putri, I. (2020). PENGARUH SUPERVISI DAN SARANA PRASARANA DENGAN KINERJA PERAWAT. *Malahayati Nursing Journal*, 2(1), 91–104. <https://doi.org/10.33024/manuju.v2i1.1570>
- Andri, F., Indra, R., & Susmarini, D. (2015). MANUSKRIP ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAWAT DALAM MEMENUHI KELENGKAPAN

DOKUMENTASI KEPERAWATAN DI IGD RUMAH SAKIT WILAYAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 10(4). <https://doi.org/10.35842/mr.v10i4.103>

- Angeline, F. (2020). *model dokumentasi keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pj2ry>
- Anisah, S., & Jati, B. L. (2022). Optimalisasi Peran dan Fungsi Kepala Ruangan Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Regulasi dan SOP Keselamatan Pasien. *JURNAL ANTARA KEPERAWATAN*, 5(2). <https://doi.org/10.37063/antaraperawat.v5i2.746>
- Anshori, Y. N., Mukarromah, N., & Agustin, R. (2014). *PENERAPAN SUPERVISI KEPALA RUANGAN DALAM KELENGKAPAN DOKUMENTASI KEPERAWATAN DI RUANG SHOFA MARWAH RS SITI KHODIJAH SEPANJANG*. <http://repository.um-surabaya.ac.id/1667/>
- Anto, S., Latif, S. A., Pannyiwi, R., Ratu, M., & Werdyaningsih, E. (2022). Analisis Beban Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan. *Barongko Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 41–46. <https://doi.org/10.59585/bajik.v1i1.38>
- Anton, A., & Usman, S. (2017). FAKTOR DENGAN MOTIVASI PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RSUD MEURAXA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 2(3). <http://jim.unsyiah.ac.id/FKep/article/download/4032/3045>
- Ardiansyah, muhammad anggi. (2020). *PENTINGNYA MENGETAHUI DIAGNOSA KEPERAWATAN DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mq5vp>
- Arif, R. (2024). Determinan yang mempengaruhi Penerapan Asuhan Keperawatan Digital di RSAU Dr. M. Salamun. *Malahayati Nursing Journal*, 6(10), 4311–4328. <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i10.17155>
- Arif, R., Asmirajanti, M., Riyanto, A., Inayah, I., & Rohayati, L. (2025). DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN ASUHAN KEPERAWATAN DIGITAL. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 13(2), 226–244. <https://doi.org/10.14710/jmki.13.2.2025.226-244>
- Arif, Y., Khairina, I., Susmiati, S., Nelwati, N., Puteri, Z. M., Ananda, Y., Murni, D., Sidaria, S., Muthmainnah, M., & Maisa, E. A. (2024). Efektifitas Sosialisasi Supervisi 4S dalam Rangka Peningkatan Budaya Keselamatan Pasien. *PengabdianMu Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 314–319. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i2.6041>
- Asyiah, J. (2020). *STANDART DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3vbrd>

- Atalla, A. D. G., Bahr, R. T., & El-Sayed, A. A. I. (2025). Exploring the hidden synergy between system thinking and patient safety competencies among critical care nurses: a cross-sectional study. *BMC Nursing*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-025-02717-6>
- Atmanto, A. P., Aggorowati, A., & Rofii, M. S. (2020). EFEKTIFITAS PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN DIAGNOSA DAN INTERVENSI KEPERAWATAN BERBASIS ANDROID TERHADAP PENINGKATAN MUTU DOKUMENTASI KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 9(1), 83–83. <https://doi.org/10.31596/jcu.v9i1.517>
- Aulia, T. (2020). *EFEKTIVITAS DOKUMENTASI KEPERAWATAN OLEH PERAWAT DI LAYANAN KESEHATAN (Autosaved)*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hww87>
- Azmi, N. N. (2025). Challenges Faced by Health Center Nurses in the Implementation of Electronic Nursing Care (ENC): Qualitative Descriptive Analysis in City X. *Journals of Ners Community*, 15(2), 60–70. <https://doi.org/10.55129/jnerscommunity.v15i2.3182>
- Barus, C. V. br. (2020). *PENTINGNYA DOKUMENTASI KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/w95kb>
- Barus, N. F. br. (2020). *Pentingnya Pelaksanaan Pendokumentasian Keperawatan Dalam Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ktzhn>
- Binta, A. P. (2025). Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(2), 107–122. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i2.130>
- Bismar, M. (2020). *MANFAAT DOKUMENTASI KEPERAWATAN DALAM ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3mys5>
- Cahyo, A. D., Sari, D. W. P., & Abdurrouf, M. (2025). Hubungan antara Supervisi dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di RSI NU Demak. *NAJ Nursing Applied Journal*, 3(3), 93–104. <https://doi.org/10.57213/naj.v3i3.832>
- Carliastuti, & Stella, S. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan dan Motivasi Perawat Pelaksana Berhubungan Dengan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan. *Journal of Management Nursing*, 1(3), 77–86. <https://doi.org/10.53801/jmn.v1i3.36>
- Chrismilasari, L. A., Nursery, S. M. C., & Maratning, A. (2025). OPTIMALISASI PELAKSANAAN SUPERVISI KEPERAWATAN MELALUI PENGEMBANGAN SOP DAN SEMINAR DI RUMAH SAKIT SUAKA INSAN BANJARMASIN. *JURNAL SUAKA INSAN MENGABDI (JSIM)*, 7(1), 34–40. <https://doi.org/10.51143/jsim.v7i1.854>
- Christina, P., Indrachyani, A., & Yatnikasaria, A. (2019). Analisis Ketidaksinambungan Dokumentasi Perencanaan Asuhan Keperawatan :

Metode Ishikawa. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 12(2).
<https://doi.org/10.48144/jiks.v12i2.166>

- Clara, N. (2016). FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PADANG TAHUN 2016. In *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University.
- Dahlia, A. I., Novieastari, E., & Afriani, T. (2020). Supervisi Klinis Berjenjang Sebagai Upaya Pemberian Asuhan Keperawatan yang Aman Terhadap Pasien. *Dunia Keperawatan Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 8(2), 304–304. <https://doi.org/10.20527/dk.v8i2.7757>
- Darmawan, V. I. (2019). *Hubungan Motivasi Perawat dengan Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan secara Elektronik di Instalasi Rawat Inap RS Paru Jember*. <http://repository.ub.ac.id/175556/>
- Deiby, M. M. S., Manoppo, J. I. Ch., & Kaunang, E. D. (2025). Analisis Hubungan Antara Disiplin Kerja, Kepemimpinan Dan Penghargaan Dengan Kinerja Perawat Dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di RSUD Poso. *KREATIF Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(2), 159–172. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i2.6144>
- Deirma. (2019). *HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MELAKUKAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/vekw7>
- Deswita, D., Arif, Y., & Supiyah, S. (2020). Penerapan Supervisi Klinik Model Group dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di RSUD Indrasari Rengat. *Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES (Journal of Health Research Forikes Voice)*, 11, 53–53. <https://doi.org/10.33846/sf.v11i0.624>
- Dewi, L. S., Utami, T. N., & Lubis, M. (2021). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERAWAT PELAKSANA RUANG RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT SRI PAMELA. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 2(4), 241–247. <https://doi.org/10.31004/jkt.v2i4.3112>
- Dewi, Y. P., Yaniawati, R. P., & Sukadjie, B. (2024). The Influence Of Nurse Workload And Works Stress On Compliance With Filling Out Electronic Medical (Mixed Methods Experiment). *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)*, 10(12), 1324–1333. <https://doi.org/10.33024/jkm.v10i12.18575>
- Dyna, D. (2016). HUBUNGAN BEBAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA DENGAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN PADA PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI TAHUN 2016. In *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University.
- Ellina, A. D., Skripsia, C. D., S, M. I. N., & Fatima, H. (2023a). Implementasi Penilaian Kinerja Berbasis Indikator Mutu Keperawatan Di Rumah Sakit Baptis Kediri.

Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(1), 31–42.
<https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i1.508>

- Elvahra, Z. (2020a). *Pentingnya Mengetahui Perencanaan Keperawatan Dalam Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gpkhv>
- Elvahra, Z. (2020b). *Bagaimana Standarisasi Penegakkan Diagnosa Keperawatan dalam Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8s5ma>
- Erma, K. (2013). HUBUNGAN MOTIVASI DENGAN PELAKSANAAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD BANGKINANG TAHUN 2013. In *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University.
- Ernawati, N. (2017). *PENGEMBANGAN MODEL SUPERVISI KLINIS BERBASIS TEORI PROCTOR DAN INTERPERSONAL RELATIONSHIP CYCLE (PIR-C) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://repository.unair.ac.id/66174/>
- Evalina, L. (2020). *Penerapan Proses Keperawatan di Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fnwmt>
- Fajri, Y. (2025). PENGEMBANGAN MODEL ELECTRONIC NURSING CARE (E-NC) BERBASIS STANDAR 3S (SDKI, SLKI DAN SIKI) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN. In *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University.
- Fajri, Y., & Arif, Y. (2025). Efektifitas Electronic Nursing Care (E-NC) Berbasis Standar 3S (SDKI, SLKI dan SIKI) Dalam Meningkatkan Mutu Pendokumentasian Asuhan Keperawatan. *Jurnal Ners*, 9(4), 6340–6345. <https://doi.org/10.31004/jn.v9i4.50620>
- Fatimah, F., & Sulistyowati, E. (2025). PENGARUH PROGRAM SUPERVISI KLINIS BERJENJANG TERHADAP KESESUAIAN ASUHAN KEPERAWATAN MENGGUNAKAN EMR. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 2369–2377. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i1.43396>
- Fatmawati, F., Yola, Y. F., Fenita, F. R., Rusmanwadi, R. R., & Windureswari, W. W. (2024). Analysis of Factors Relating The Quality of Nursing Care Documentation. *Frontiers on Healthcare Research*, 1(1), 39–45. <https://doi.org/10.63918/fhr.v1.n1.p39-45.2024>
- Fatonah, S., & Yustiawan, T. (2020). Supervisi Kepala Ruangan dalam Meningkatkan Budaya Keselamatan Pasien. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(1), 151–161. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1408>
- Febrianita, Y., & Riski, M. S. (2024). ANALISIS PENGETAHUAN PERAWAT TERKAIT 3S (SDKI, SLKI, SIKI) DAN PENGGUNAAN DALAM ASUHAN KEPERAWATAN DI RSUD X SIAK SRI INDRAPURA. *Menara Medika*, 7(1), 95–105. <https://doi.org/10.31869/mm.v7i1.5826>

- Firmansyah, D., Kamaluddin, R., & Purnawan, I. (2025). Efektivitas penggunaan asuhan keperawatan digital terhadap kualitas dokumentasi keperawatan: A systematic review. *HOLISTIK JURNAL KESEHATAN*, 19(1), 195–204. <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i1.808>
- Fithriyani, F. (2016). analisis hubungan fungsi manajerial kepala ruangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap RSUD Pariaman Tahun 2016. In *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University.
- Fitrawan, D., Amita, D., Andrianti, S., Marlana, F., & Podesta, A. (2022). HUBUNGAN FUNGSI MANAJEMEN CONTROLLING KEPALA RUANGAN DENGAN KELENGKAPAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG SERUNI DAN MELATI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. YUNUS BENGKULU. *Mitra Raflesia (Journal of Health Science)*, 14(2), 184–184. <https://doi.org/10.51712/mitraraflesia.v14i2.230>
- Fitriani, H., Badrujamaludin, A., & Rudhiati, F. (2022). Pelatihan Pengelolaan Kasus Berdasarkan Berpikir Kritis dengan Pendekatan Proses Keperawatan di Santosa Hospital Bandung Central (SHBC). *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(4), 1205–1211. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i4.5535>
- Fortuna, I. D. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perawat di Rumah Sakit: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Manajemen Kesehatan Dan Keperawatan.*, 1(4), 193–201. <https://doi.org/10.35968/wnyrep90>
- friska, A. (2019). *PENULISAN DOKUMENTASI DENGAN BAIK DAN BENAR OLEH PERAWAT DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/sw3zn>
- Furroidah, F., Maulidia, R., & Maria, L. (2023). HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT DENGAN TINGKAT KEPATUHAN DALAM MENERAPKAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 12(1), 26–38. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v12i1.314>
- Gea, K. N. R. (2020). *Penerapan Perencanaan Keperawatan dan Implementasi di Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3gmz2>
- Ginting, C. A. (2019a). *Optimalisasi Peran Perawat dalam Penerapan K3 di Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9uzgc>
- Ginting, C. A. (2019b). *Optimalisasi Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Sebagai Peningkatan Kualitas Kinerja Perawat*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kq3xm>
- Ginting, D. (2020). *PEMANFAATAN TEKNOLOGI KESEHATAN DAN SISTEM INFORMASI DALAM PROSES ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tx6sg>

- Habibi, A., Novieastari, E., Yatnikasari, A., & Handiyani, H. (2022). OPTIMALISASI SUPERVISI BERJENJANG SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI RUMAH SAKIT X. *Jurnal JKFT*, 7(2), 113–113. <https://doi.org/10.31000/jkft.v7i2.7560>
- hafaz, I. (2019). *CARA PERAWAT MENJALANKAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wmnyg>
- Halawa, T. N. N. (2020). *EFEKTIVITAS FORMAT PENDOKUMENTASIAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bhp2k>
- Hanhara, R. (2019a). *EVALUASI KEPERAWATAN UNTUK MEMPERKUAT PROSES KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/74jx8>
- HARAHAP, A. P. K. (2019). *PENTINGNYA PEMAHAMAN SEORANG PERAWAT DALAM KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5ady6>
- harahap, N. mahlini. (2019). *Hubungan Perawat Terhadap Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ufdrw>
- Hardono, H., & Bunga, A. L. (2025). Optimalisasi Penerapan Patient Safety Goals dalam Pelayanan Keperawatan: Literatur review. *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), 5319–5335. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3051>
- Harefa, D. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/dy76j>
- Harismayanti, H., Hidayat, E. H., Syukur, S. B., & Kezia, K. (2025). GAMBARAN PENGETAHUAN PERAWAT DALAM PENERAPAN STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 4740–4746. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.39272>
- Haryani, F. (2011). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA PERAWAT DALAM KELENGKAPAN PENGISIAN DOKUMEN ASUHAN KEPERAWATAN PASIEN RAWAT INAP KELAS III RSUD KOTA SEMARANG TAHUN 2011*. <http://eprints.undip.ac.id/33436/>
- Haryati, T. S., Yetti, K., Afriani, T., & Handiyani, H. (2019). *Manajemen Risiko: Bagi Manajer Keperawatan dalam Meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien*.
- Hasan, R., Habibi, A., Ahmad, S. N. A., & Ramdhan, Q. N. (2021). HUBUNGAN MOTIVASI KERJA DENGAN KINERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RSUP SITANALA TANGERANG. *Jurnal JKFT*, 6(2), 83–83. <https://doi.org/10.31000/jkft.v6i2.5758>
- Hasibuan, A. N. (2020). *PENTINGNYA PERAWAT MENGETAHUI ISSUE KESELAMATAN PASIEN UNTUK MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5hy72>

- Hasmawati, H., Werdati, S., & Fatimah, F. S. (2020). Hubungan Antara Motivasi dengan Perilaku Perawat dalam Mendokumentasikan Asuhan Keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSUD Wates Kulon Progo. *Indonesian Journal of Hospital Administration*, 3(1), 45–45. <https://doi.org/10.21927/ijhaa.v3i1.1397>
- Hayati, S. N., Supriatin, E., & Sudrajat, D. A. (2025). PELAKSANAAN DISKUSI REFLEKSI KASUS (DRK) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM KEAMANAN dan KEWASPADAAN OBAT. *Jurnal Abdimas Sains*, 2(2), 47–52. <https://doi.org/10.33755/jas.v2i2.26>
- Hendriana, Y., & Pranatha, A. (2020). Standar nursing language berbasis NANDA, NOC, dan NIC terhadap kualitas pengisian dokumentasi keperawatan. *Nurscope Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 5(2), 26–26. <https://doi.org/10.30659/nurscope.5.2.26-31>
- Heryyanoor, H., Pertiwi, M. R., & Hardiyanti, D. (2023). Persepsi Perawat tentang Penerapan Dokumentasi Keperawatan di Rumah Sakit A. *Jurnal Ners*, 7(2), 1230–1240. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.16839>
- Hidayati, N., Widodo, A., & Yulian, V. (2025). Determinan kepuasan perawat terhadap dokumentasi asuhan keperawatan di rekam medis berbasis elektronik. *HOLISTIK JURNAL KESEHATAN*, 19(5), 996–1003. <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i5.979>
- Hisamjulfikrimunthe. (2019). *FAKTOR-FAKTOR PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/r2p35>
- Hrp, E. R. (2019a). *KEBIJAKAN YANG DILAKUKAN OLEH PERAWAT DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/bdpyq>
- Hrp, E. R. (2019b). *TUJUAN DARI PERENCANAAN ASUHAN KEPERAWATAN DALAM MENINGKATKAN HASIL PELAYANAN YANG MAKSIMAL*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/dyqut>
- Hursepuny, F. L., & Tarigan, E. (2024). Peran Kepala Ruang dalam Meningkatkan Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(6), 1367–1374. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i6.5100>
- Hutabarat, M. R. A. (2020). *Pelatihan Proses Keperawatan Terhadap Dokumentasi AsuhanKeperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k9njt>
- Ibrahim, M. M., Abdul-Rahaman, F., Sayibu, M. S., Alhassan, D. N., Awudu, R. T., Mohammed, I., Wuni, A., & Abdulai, A.-M. (2025). Assessing the impact of nurses' patient safety competencies on key performance indicators (KPIs) for patient safety outcomes at Tamale Teaching Hospital: the mediating role of leadership and barriers to competency development. *BMC Health Services Research*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-025-13384-3>

- Imanda, I. (2020). *LANGKAH-LANGKAH PENDOKUMENTASIAN RENCANAAN PROSES KEPERAWATAN SEBAGAI SISTEM ACUAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h4et9>
- Inayati, A., & Sriyati, S. (2020). Case Study Report: Tingkat Pengetahuan Dokumentasi Asuhan Keperawatan terhadap Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Indonesian Journal of Hospital Administration*, 3(1), 1–1. <https://doi.org/10.21927/ijhaa.v3i1.1395>
- Indrayani, D., & Siswadi, Y. (2025). EFEKTIVITAS PELATIHAN DALAM MENINGKATKAN KELENGKAPAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN ELEKTORNIK: TINJAUAN SISTEMATIS. *Jurnal Penelitian Keperawatan Kontemporer*, 5(4). <https://doi.org/10.59894/jpkk.v5i4.1043>
- Intan, I. P., Wulandari, R. Y., Elasari, Y., & Nugroho, T. A. (2024). Hubungan Supervisi Kepala Ruangan Dan Pengetahuan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berdasarkan 3S (SDKI, SIKI, SLKI) Dengan Mutu Asuhan Keperawatan Di Ruangan Rawat Inap RSUD Jendral Ahmad Yani Metro Lampung. *Jurnal Medika Malahayati*, 8(3), 711–719. <https://doi.org/10.33024/jmm.v8i3.15908>
- Iqbal, M., Fachrin, S. A., & Saleh, L. M. (2020). Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap dan Kualitas Kerja Dengan Kinerja Perawat Dalam Penerapan Sistem Keselamatan Pasien Di RSUD Sinjai Tahun 2020. *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)*, 1(2), 44–57. <https://doi.org/10.52103/jahr.v1i2.238>
- Irawan, A. G., Yulia, S., & Mulyadi, M. (2017). HUBUNGAN SUPERVISI DENGAN PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT XX. *Masker Medika*, 5(1), 241–254. <https://jmm.ikestmp.ac.id/index.php/maskermedika/article/view/164>
- ISWARA, A. (2020). *HUBUNGAN PENGETAHUAN PERAWAT DALAM DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DENGAN PELAKSANAAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fdz6e>
- Jainurakhma, J. (2022). PENERAPAN METODE ASUHAN KEPERAWATAN PROFESIONAL: ANALISIS MOTIVASI TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA PERAWAT. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 11(2), 194–200. <https://doi.org/10.33475/jikmh.v11i2.298>
- Janggeng, A., Sianturi, S. R., & Lina, R. N. (2022). Knowledge and Attitude of Nurses with Computerized Based Nursing Care Documentation. *Media Keperawatan Indonesia*, 5(4), 267–267. <https://doi.org/10.26714/mki.5.4.2022.267-273>
- jannah, nurfatul. (2020). *standart Dan Model Dokumentasi Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nh8yd>
- jannati, rayyan. (2019). *PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/84jtd>

- kaban, R. pratama. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/m3upg>
- Karima. (2020). *Proses Pendokumentasian Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5zdpv>
- Karmadi, K., Lieskusumastuti, A. D., Nurhayati, I., Widiyanto, A., & Atmojo, J. T. (2023). Meta-Analisis Pengaruh Empati dalam Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 5(3), 1209–1218. <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i3.1748>
- kartika, Y. dwi. (2019). *"HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DALAM PROSES DOKUMENTASI KEPERAWATAN."* <https://doi.org/10.31219/osf.io/5fg9s>
- Kasumayanti, E., Nelma, U., & Hidayat, R. (2025). Optimalisasi Penilaian Kinerja Perawat Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Komprehensif dan Keselamatan Pasien di Ruangan MPKP Kuantan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2949–2954. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2075>
- Keristiana, N. W., Dwijayanto, I. M. R., & Fristalia, M. D. (2026). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN BEBAN KERJA DENGAN KELENGKAPAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG INTENSIVE RSUD MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Intan Husada Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.52236/ih.v14i1.859>
- Koerniawan, D., Daeli, N. E., & Srimiyati, S. (2020). Aplikasi Standar Proses Keperawatan: Diagnosis, Outcome, dan Intervensi pada Asuhan Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(2), 739–751. <https://doi.org/10.31539/jks.v3i2.1198>
- Krisna, D. A., Kusumaningsih, D., Kristanto, E. Y., & Nopriyanto, D. (2024). Description Of Optimization Of Education About The Rights And Obligations Of New Patients And Family: Pilot Study. *Jurnal Kesehatan Pasak Bumi Kalimantan*, 6(2), 308–308. <https://doi.org/10.30872/j.kes.pasmi.kal.v6i2.13199>
- Kurniati, D. (2019). *KONSEP DASAR ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gns8a>
- Kurniawati, N. (2023). Hubungan Fungsi Pengarahan dan Fungsi Pengawasan Kepala Ruangan dengan Kelengkapan Pendokumentasian Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSIA Kemang Medical Care Tahun 2022. *Journal of Management Nursing*, 3(1), 278–282. <https://doi.org/10.53801/jmn.v3i1.147>
- L.Tobing, R. S. C. (2020a). *Sistem Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/78kfw>

- Lestari, M., Azka, A. S., Zahwan, A., Rachmania, F. A., Zanah, R. M., Ridwan, H., & Sutresna, I. (2025). Peran Kepala Ruangan dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Keperawatan: Systemtic Review. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 661–668. <https://doi.org/10.54082/jupin.976>
- Lia, M. (2015). *HUBUNGAN IMBALAN DAN BEBAN KERJA PERAWAT DENGAN KINERJA PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) I SE-KOTA PARIAMAN*. <http://scholar.unand.ac.id/432/>
- Limbong, M., & Tarigan, E. (2024). Analisis Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah : Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(3), 620–629. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i3.4853>
- Lubis, S. C. (2020). *PERAN PERAWAT DALAM PENERAPAN SASARAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7zfhr>
- Maha, A. S. (2019). *Pentingnya Evaluasi Asuhan Keperawatan bagi pasien dan Perawat*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6x5m4>
- Manuhutu, F., Novita, R. V. T., & Supardi, S. (2020). PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN OLEH PERAWAT PELAKSANA SETELAH DILAKUKAN PELATIHAN SUPERVISI KEPALA RUANG DI RUMAH SAKIT X, KOTA AMBON. *Jurnal Ilmiah Perawat Manado (Juiperdo)*, 8(1), 171–191. <https://doi.org/10.47718/jpd.v8i01.1150>
- Mardiani, R. (2019). *Besarnya Manfaat Dokumentasi Dalam Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3rjak>
- Maulani, M. (2016). HUBUNGAN PENDIDIKAN, MOTIVASI KERJA, SUPERVISI KEPALA RUANGAN DENGAN KINERJA PERAWAT. *JURNAL WACANA KESEHATAN*, 1(2). <https://doi.org/10.52822/jwk.v1i2.10>
- Mayenti, F., Efliani, D., & Meri, D. (2025). Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perawat dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit Tipe A Kota Pekanbaru. *Jurnal Ners*, 10(1), 658–664. <https://doi.org/10.31004/jn.v10i1.52252>
- Mayenti, F., Meri, D., & Gusniwati, Y. (2024). HUBUNGAN BEBAN KERJA, STRES KERJA DAN KOMPETENSI DENGAN KINERJA PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN. *Al-Asalmiya Nursing Jurnal Ilmu Keperawatan (Journal of Nursing Sciences)*, 13(2), 256–264. <https://doi.org/10.35328/keperawatan.v13i2.2814>
- Megawati, Y. (2020). *KONSEP DOKUMENTASI KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7yf2>

- Mendrofa, H. K., Jobber, N. F., & Nasrah, N. (2025). FAKTOR DETERMINAN PENERAPAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN 3S (SDKI, SLKI, SIKI) PADA RUANG RAWAT INAP DIRUMAH SAKIT WILAYAH KOTA JAYAPURA. *Indonesian Trust Health Journal*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.37104/ithj.v8i1.326>
- Metilda, M., Cahyanti, A. D., Novitaa, A., Amelia, M., Hidayanti, R. S., & Nurfitri, S. (2025). LITERATURE REVIEW: PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN DALAM MANAJEMEN RISIKO DAN PATIENT SAFETY DI RUANG RAWAT INAP. *SINERGI Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 5103–5121. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i11.1978>
- Metilda, Nisa, N. C., Aris, S. S., Setiasih, G. T., Afifah, N., & Putri, D. (2026). PERAN AUDIT KEPERAWATAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PERAWATAN MELALUI DOKUMENTASI DAN EVALUASI REKAM MEDIS. *SINERGI Jurnal Riset Ilmiah*, 3(2), 610–627. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i2.2355>
- Miladiyah, N., Mustikasari, M., & Gayatri, D. (2015). Hubungan Motivasi dan Komitmen Organisasi dengan Kinerja Perawat dalam Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 18(1), 9–16. <https://doi.org/10.7454/jki.v18i1.392>
- Mimit, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Dan Faktor Determinannya di Ruang Rawat Inap RSUD Pasaman Barat Tahun 2015. In *Andalas University eThesis (Andalas University)*. Andalas University.
- Monalisa, I., Hilmy, M. R., & Anindita, R. (2023). The Role of Nurse Motivation, Competence And Workload for Increasing Completeness of Nursing Process Documentation At Class B Private Hospital In Jakarta. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*, 6(3), 178–183. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v6i3.723>
- Muawanah, M., Purnomo, H., Sofyan, K., Uripno, P. S., & Normawati, A. T. (2022). Penerapan Supervisi Model Klinis Terhadap Pencapaian Budaya Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Studi Keperawatan*, 3(1), 15–17. <https://doi.org/10.31983/j-sikep.v3i1.8362>
- Muhsinah, S., Rini, D. S., & Tahir, R. (2025). Pelatihan Penggunaan 3S (SDKI, SLKI, SIKI) dalam Asuhan Keperawatan di Puskesmas Motui. *Jurnal Inovasi Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.36990/jipppm.v5i1.1315>
- Munawaroh, M., Hadi, M., Naryati, N., & Suminarti, T. (2025). Penerapan Supervisi Model 4s terhadap Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berbasis Emr di Rumah Sakit An-Nisa Tangerang. *MAHESA Malahayati Health Student Journal*, 6(1), 25–35. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v6i1.20009>
- munthe, A. pebrina rizki fani. (2019). *Konsep Dasar Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7p8u9>

- Murni, D. (2019). *KAJIAN FAKTOR ORGANISASI DENGAN KINERJA PERAWAT PELAKSANA DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN*. 11(2). <https://doi.org/10.25077/njk.11.2.%p.2015>
- Mursid, A., Saleh, A., Malasari, S., & Amahoru, N. B. (2022). Optimalisasi Pemberian Asuhan Keperawatan Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan. *AKSIOLOGIYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(4). <https://doi.org/10.30651/aks.v6i5.5063>
- Musrifah, M., Hamid, A. Y. S., Syafwani, M., Harun, L., & Mahdalena, M. (2025). The Relationship between Workload and Internet Network Quality with the Completeness of Electronic Nursing Care Documentation. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 7(6), 291–298. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v7i6.510>
- Nurhaliza, S. (2019b). *Pengatahuan Konsep Dasar Proses Keperawatan dalam Menerapkan Standar Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5qn4p>
- Napitu, J. (2020). *Hubungan kinerja perawat dengan penerapan proses keperawatan di rumah sakit*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dfr9c>
- Naryati, N., Aisyah, A., Widiastuti, E., Widakdo, G., Latipah, S., Hidayanti, L., Yuliatwati, Y., & Fadillah, H. (2025). Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan melalui Pemberdayaan Perawat PPJA dalam Metode Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 8(11), 5759–5771. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v8i11.23106>
- Nasution, A. P. K. (2019). *MENERAPKAN KOMPONEN DASAR PROSES KEPERAWATAN YANG DILAKUKAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/t6w4y>
- Nasution, T. L. (2019). *Penerapan Standar Proses Keperawatan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/ptm2x>
- Ndama, M., & Aminuddin, A. (2018). AN ANALYSIS OF RELATED FACTORS WITH NURSE'S MOTIVATION IN DOCUMENTATION OF NURSING CARE IN SICKROOM OF MADANI PALU GENERAL HOSPITALS. *Jurnal Kesehatan Prima*, 11(1), 57–57. <https://doi.org/10.32807/jkp.v11i1.83>
- Nindyanto, S. I. A., Sukesu, N., & Purnomo, M. A. B. (2013). PENGARUH SUPERVISI KEPALA RUANG TERHADAP DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD UNGARAN. *Karya Ilmiah S.1 Ilmu Keperawatan*. <http://112.78.40.115/e-journal/index.php/ilmukeperawatan/article/view/191>
- ningsih, M. (2017). *Meningkatkan Kualitas Dokumentasi Asuhan Keperawatan Dengan Sistem Informasi Keperawatan Berbasis Komputer*. 2(1). <https://doi.org/10.33666/jitk.v2i1.30>

- Nisfu, N. (2020). "KARAKTERISTIK DIAGNOSA DALAM STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN." <https://doi.org/10.31219/osf.io/z65cm>
- Noorkasiani, N., Gustina, G., & Maryam, R. S. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kelengkapan Dokumentasi Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 18(1), 1–8. <https://doi.org/10.7454/jki.v18i1.391>
- Noviani, R. W. H., Masropah, A., & Pasaribu, K. (2025). Hubungan sistem pendokumentasian berbasis elektronik dengan kinerja perawat di instalasi rawat inap. *JOURNAL OF Qualitative Health Research & Case Studies Reports*, 5(5), 785–791. <https://doi.org/10.56922/quilt.v5i5.1759>
- Nubuwah, R. T. N. (2019). *PERAN PERAWAT DALAM PENINGKATAN PATIENT SAFETY DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/shkfu>
- Nugroho, S. A., Fadaugas, L. G., Munawar, M., Hidayatullah, M., Hartoni, M. Y., & Gilang, M. B. (2025). Sistem Dokumentasi Digital untuk Peningkatan Mutu Dokumentasi Keperawatan Medikal Bedah. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 7(6), 353–360. <https://doi.org/10.37287/jppp.v7i6.994>
- Nugroho, S. H. P., & Sujianto, U. (2017). Supervisi Kepala Ruang Model Proctor untuk Meningkatkan Pelaksanaan Keselamatan Pasien. *Deleted Journal*, 20(1), 56–64. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i1.348>
- Nur, H. A., Dharmana, E., & Santoso, A. (2017). Pelaksanaan Asesmen Risiko Jatuh di Rumah Sakit. *JNKI (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(2), 123–123. [https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5\(2\).123-133](https://doi.org/10.21927/jnki.2017.5(2).123-133)
- Nurdiana, N., Hariyati, Rr. T. S., & Anisah, S. (2018). Penerapan Fungsi Manajemen Kepala Ruangan dalam Pengendalian Mutu Keperawatan. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 2(3), 160–160. <https://doi.org/10.32419/jppni.v2i3.93>
- Nurfanita, V. (2025). STRATEGI INTERVENSI STRATEGI INTERVENSI UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN, SUPERVISI DAN KEPATUHAN GUNA MENGHASILKAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN YANG BAIK. *Masker Medika*, 13(1), 46–53. <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v13i1.740>
- Nurhaliza, S. (2019a). "Pengatahuan Konsep Dasar Proses Keperawatan dalam Menerapkan Standar Asuhan Keperawatan." <https://doi.org/10.31219/osf.io/ku2ne>
- Oktaviani, R. D. (2019). *PERAWAT DALAM MELAKUKAN EVALUASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qfmx6>
- Oktaviarini, E., Yetti, K., Suhendri, A., & Hadi, M. (2023). Optimalisasi Fungsi dan Peran Manajemen Keperawatan pada Level Kepala Ruang dalam

- Pendokumentasian Supervisi Berbasis IT. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(2), 2100–2109. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.6806>
- Panggabean, S. F. M. (2020). *HUBUNGAN KARAKTERISTIK PERAWAT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN DALAM MELAKUKAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7j2ze>
- Panjaitan, M. J. P. A., Simanjuntak, S. M., Sipayung, F., & Sitanggang, S. E. (2025). Kajian Sistem Manajemen Keperawatan di Ruang Rawat Inap Unit Bugenville Rumah Sakit Swasta di Bandung. *Jurnal Ners*, 9(2), 3084–3091. <https://doi.org/10.31004/jn.v9i2.43747>
- Pasaribu, P. M. J. (2020). *Pentingnya Dokumentasi Keperawatan Serta Manfaatnya Terhadap Lingkungan Kerja*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/s2ugv>
- Passya, P., Rizany, I., & Setiawan, H. (2019). Hubungan Peran Kepala Ruangan dan Supervisor Keperawatan dengan Motivasi Perawat dalam Melakukan Dokumentasi Keperawatan. *JURNAL KEPERAWATAN RAFLESIA*, 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.33088/jkr.v1i2.409>
- Perdana, R. R., Afriani, T., Wirdani, A. W., Hariyati, R. T. S., Harpendewisasmita, H., & Kuntarti, K. (2026). Optimalisasi fungsi actuating kepala ruangan dalam supervisi dokumentasi asuhan keperawatan di rumah sakit. *HOLISTIK JURNAL KESEHATAN*, 19(11), 3356–3363. <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i11.1751>
- Prayogi, A. S. (2018). Hubungan Kinerja Perawat Dengan Kepuasan Pasien Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Tk. III 04.06.03 Dr. Soetarto Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (JIKI)*, 1(2), 9–9. <https://doi.org/10.31000/jiki.v1i2.79>
- Pringgayuda, F. (2024). Inhouse Training Dokumentasi Asuhan Keperawatan di Klinik Pratama Muhammadiyah Pringsewu. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 7(12), 5583–5593. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i12.17599>
- Purba, M. A. (2019a). *PERAN PERAWAT DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/r6kqj>
- Purba, M. A. (2019b). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENDOKUMENTASIAN DIAGNOSA KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9cm32>
- Purba, N. A. S. (2019a). *Analisi Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/y28pb>
- Purba, N. A. S. (2019b). *PENDOKUMENTASIAN STANDART ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/mp47z>
- Purba, R. J. (2019c). *PRINSIP DALAM PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH MENUJU KESELAMATAN PASIEN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/s3ya2>

- Purbobinuko, Z. K., Prahesti, R., & Ningsih, K. P. (2021a). *UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN PASIEN DALAM DOKUMENTASI REKAM MEDIS*. 6(2), 205–212. <https://doi.org/10.2411/jipiki.v6i2.607>
- Purbobinuko, Z. K., Prahesti, R., & Ningsih, K. P. (2021b). Upaya Meningkatkan Kepatuhan Profesional Pemberi Asuhan Pasien Dalam Dokumentasi Rekam Medis. *Jurnal Ilmiah Perkam Dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI)*, 6(2), 205–212. <https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i2.607>
- Purnamasari, I., Raharyani, A. E., & Karim, Y. (2023). In House Training 3S (SDKI, SLKI, SIKI) to Improve Nurses' Knowledge of 3S-Based Nursing Care. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 5(1), 35–42. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v5i1.1482>
- Purwandari, R., Kurniawan, D. E., & Kotimah, S. K. (2022). Nursing Documentation in Accredited Hospital. *Deleted Journal*, 25(1), 42–51. <https://doi.org/10.7454/jki.v25i1.1139>
- Putri, S. J. (2020). *HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DENGAN KEPATUHAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hwfp2>
- Putri, S., Basit, M., Asmadiannor, A., & Wijaksono, M. A. (2024). Motivasi perawat pelaksana dan peran ketua tim terhadap dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputer. *Journal of Health Research Science*, 4(2), 142–152. <https://doi.org/10.34305/jhrs.v4i2.1211>
- Qasim, M., Juwita, H., & S, S. D. R. (2024). Optimalisasi Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berbasis 3S PPNI di Ruang Perawatan RSU Bahagia Makassar. *Abdi Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(4), 893–900. <https://doi.org/10.24036/abdi.v6i4.1266>
- Rahma, J., & Simamora, R. H. (2020). *BESARNYA MANFAAT DOKUMENTASI PADA ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mdtez>
- Rahman, F. (2020). *Dokumentasi Keperawatan dalam Melakukan Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7g4re>
- Rahmi, A. P. (2019). *Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien Oleh Perawat Di Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f9s5n>
- Ramadani, T. (2019). *Mengoptimalkan Pelaksanaan Prosedur Keselamatan Pasien*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/bksf8>
- Ramadhani, S. O., Nurul, E., Aulia, L. N., Nurfadilah, S. D., & Ridwan, H. (2025). TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS: DAMPAK PENDOKUMENTASIAN BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP BEBAN KERJA PERAWAT. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 9131–9142. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.44349>

- Rambe, B. M. (2020). *Dampak Penerapan Model Dokumentasi Keperawatan Berbasis Elektronik Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jzk76>
- rambe, F. adelina. (2019). *STANDAR PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/js59n>
- Rangkuti, N. A. (2020). *Pengaruh Pelatihan dan Pengetahuan Perawat dalam Dokumentasi Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kwua7>
- Rani, M. G. (2019). *PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN OLEH PERAWAT UNTUK KESEMBUHAN PASIEN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gq6ew>
- Rani, M. P. Drs. I. G. (2019). *MENINGKATKAN PROSES KEPERAWATAN DALAM STANDAR KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7qgcw>
- Rani, M. Y. (2019). *MENINGKATKAN PROSES KEPERAWATAN DALAM STANDAR KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fzpqe>
- Rija, M. W. (2020). *MANFAAT DOKUMENTASI KEPERAWATAN DALAM ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/z27aj>
- Rismayanti, D., Mediawati, A. S., & Somantri, I. (2025). Evaluasi kinerja perawat di rumah sakit: A scoping review. *HOLISTIK JURNAL KESEHATAN*, 19(3), 492–499. <https://doi.org/10.33024/hjk.v19i3.903>
- Romawati, P., Hadi, M., Naryati, N., Fadillah, H., & Satinah, S. (2024). Efektifitas Pelatihan Asuhan Keperawatan terhadap Kinerja Pendokumentasian Keperawatan. *MAHESA Malahayati Health Student Journal*, 4(5), 1785–1796. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i5.14352>
- Rukmasari, E. A., & Putri, K. A. A. (2025). PERAN DOKUMENTASI KEPERAWATAN DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT: RAPID SCOPING REVIEW. *AKSELERASI Jurnal Ilmiah Nasional*, 7(3), 126–135. <https://doi.org/10.54783/jin.v7i3.1573>
- Rum, M. R. (2019). PENGARUH KEPATUHAN PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 18(1), 4–9. <https://doi.org/10.33221/jikes.v18i1.191>
- Rumadaul, N. S., & Dedi, B. (2025). PENGARUH EVALUASI BERKALA KINERJA PERAWAT TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 5204–5213. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.48825>
- Rumbewas, T. Y., Wardani, R., & Sultan, S. (2025). Penerapan 4S pada Model Asuhan Keperawatan di Ruang Bedah Wanita dan Ruang Paru BLUD Rumah Sakit Umum Jayapura. *KOLABORASI JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v6i1.759>

- Rusmianingsih, N., Puspanegara, A., Rahmadanti, S., & Nugraha, Moch. D. (2023). Hubungan supervisi kepala ruangan dengan kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan di instalasi Rawat inap RS Juanda Kuningan tahun 2023. *Journal of Midwifery Care*, 4(1), 10–24. <https://doi.org/10.34305/jmc.v4i1.963>
- S, C. Y. (2019). *STANDAR PENDOKUMENTASIAN YANG DITERAPKAN OLEH PERAWAT DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/fyj37>
- Sabarulin, Darmawansyah, & Abdullah, R. (2013). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PERAWAT DALAM MENDOKUMENTASIKAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT WOODWARD PALU*. 2(3). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jadkkm/article/download/929/810>
- Safira, N. (2019). *STANDART DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pyj7u>
- Safitri, R. (2019). *PENTINGNYA DOKUMENTASI YANG DILAKUKAN PERAWAT SEBAGAI BUKTI TINDAKAN YANG DILAKUKAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/gp5vz>
- Sagala, H. G. (2020). *MANFAAT DOKUMENTASI DALAM MEMBERIKAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/4ypf6>
- Salim, A., Yustina, I., Santoso, H. A., & Setiawan, S. (2024). The Influence of Education, Rewards and Motivation on Nurse Performance in Nursing Documentation Through Job Satisfaction at Puri Husada Tembilahan Regional General Hospital. *International Journal of Religion*, 5(11), 1421–1428. <https://doi.org/10.61707/81t64952>
- Salsabila, A. N., & Dhamanti, I. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERAWAT DALAM PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT: Literature Review. *Jurnal Ners*, 7(1), 524–530. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13740>
- Salsabila, T. (2020). *HUBUNGAN ANTARA SUPERVISI DENGAN KUALITAS PENDOKUMENTASIAN DALAM PROSES ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2xhrb>
- Samosir, E. (2020). *Analisis Konsep Dokumentasi Keperawatan Sebagai Standar Penting Dalam Pelayanan Kesehatan Berkualitas*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pkzmu>
- Saputra, C., Arif, Y., & Yeni, F. (2019). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS DAN KELENGKAPAN DOKUMENTASI KEPERAWATAN. *Jurnal Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9(3), 187–196. <https://doi.org/10.32583/pskm.9.3.2019.187-196>
- Saputra, C., Arif, Y., & Yeni, F. (2020). Andra's Nursing Informatic System Application (Annisa) dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Perawat tentang

- Dokumentasi Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(1), 20–30. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i1.1281>
- Saputra, W. B., Juanita, J., & Nasution, S. S. (2020). Pengaruh Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Perawat Pelaksana Dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Permata Bunda Medan Tahun 2018. *Jurnal Kesmas Jambi*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22437/jkmj.v4i1.8936>
- Saputri, D. (2019). *PENTINGNYA PRINSIP – PRINSIP DALAM PENDOKUMENTASIAN DALAM ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dwvzn>
- SARI, N. (2020). *MODEL, PRINSIP DAN KARAKTERISTIK DOKUMENTASI SEBAGAI DASAR PELAKSANA ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n8cyw>
- Sari, S. D. (2019). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4btxc>
- Sariningsih, C. (2015). *HUBUNGAN SUPERVISI KEPALA RUANG DAN REWARD DENGAN KEDISIPLINAN PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG*. <http://repository.unissula.ac.id/321/>
- Saroh, A. M. (2019). *“DOKUMENTASI SEBAGAI BUKTI TANGGUNG JAWAB DAN TANGGUNG GUGAT PERAWAT.”* <https://doi.org/10.31219/osf.io/nc85t>
- Sartiwi, W. (2014). HUBUNGAN KEGIATAN SUPERVISI KEPALA RUANGAN MENURUT PERSEPSI PERAWAT PELAKSANA DENGAN PELAKSANAAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT ISLAMIBNU SINA PADANG TAHUN 2014 [Andalas University]. In *Andalas University Repository (Andalas University)*. http://katalog.pustaka.unand.ac.id//index.php?p=show_detail&id=103258
- Sembiring, N. G. C. (2020). *Relasi Antara Supervisi Dengan Kualitas Pendokumentasian dalam Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3gnqv>
- Septi, F., Widyaningsih, I., Agustina, R., Ariesta, S. A. H., & Ridwan, H. (2025). Implementasi Fungsi Controlling Dalam Manajemen Keperawatan Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Rumah Sakit. *Nursing News Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 9(3), 378–390. <https://doi.org/10.33366/nn.v9i3.3392>
- Sharfina, D. (2019). *KEBIJAKAN PERAWAT DALAM PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/j5dzh>
- Siahaan, M., Nababan, D., Harefa, K., Siagian, M. T., & Silitonga, E. M. (2021a). PENGARUH SUPERVISI KEPALA RUANGAN TERHADAP KINERJA PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT

INAP RUMAH SAKIT TK. II PUTRI HIJAU MEDAN TAHUN 2021. *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE*, 7(2), 1439–1454. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v7i2.1721>

- Siahaan, M., Nababan, D., Harefa, K., Siagian, M. T., & Silitonga, E. M. (2021b). PENGARUH SUPERVISI KEPALA RUANGAN TERHADAP KINERJA PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RUMKIT TK II PUTRI HIJAU KESDAM I/BB KESDAM I/BB MEDAN TAHUN 2021. *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE*, 7(2), 1439–1454. <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/download/1721/940>
- Siahaan, M., Nababan, D., Sinaga, J., Siagian, M. T., & Silitonga, E. M. (2021). PENGARUH SUPERVISI KEPALA RUANGAN TERHADAP KINERJA PERAWAT DALAM PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP. *JOURNAL OF HEALTHCARE TECHNOLOGY AND MEDICINE*, 7(2), 1439–1454. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v7i2.1711>
- Sianipar, Y. (2020a). *BERBAGAI MANFAAT DARI UPAYA MEMPERTAHANKAN ERGONOMIC PADA BERBAGAI POSISI GUNA UNTUK KESELAMATAN PASIEN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uzgr5>
- Sianipar, Y. (2020b). *KESEHATAN KERJA SERTA TERHINDAR DARI BAHAYA DALAM PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tx28m>
- Sihaloho, A. A. (2020). *Motivasi perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n3gkt>
- Sihombing, R. W. C. (2019). *PENTINGNYA MELAKUKAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/pt9uw>
- silalahi, P. T. (2020). *Motivasi Perawat Dan Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7rdc9>
- Silalahi, R. D. (2020). *Peran Kepala Ruangan Dalam Pengembangan Dokumentasi Keperawatan Secara Elektronik Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/p6xev>
- Silitonga, E., Saragih, M. Y., & Sipayung, R. (2020). HUBUNGAN BEBAN KERJA DENGAN MOTIVASI KERJA PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN ASUHAN KEPERAWATAN. *Jurnal Keperawatan Priority*, 3(2), 85–92. <https://doi.org/10.34012/jukep.v3i2.978>
- Simamora, R. H. (2019). *Penguatan Peran Perawat dalam Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/r3qhx>
- Simamora, R. H., Bukit, E. K., Purba, J. M., & Siahaan, J. V. (2017). PENGUATAN KINERJA PERAWAT DALAM PEMBERIAN ASUHAN KEPERAWATAN MELALUI PELATIHAN RONDE KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA

- MEDAN. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 23(2), 300–300. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v23i2.6880>
- Simanjuntak, E. C. (2019). *PELAKSANAAN ASUHAN KEPERAWATAN YANG BERMUTU DI RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4ar8f>
- Sipayung, M. (2020). *Metode dan Model Dokumentasi Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/s8u43>
- siregar, A. salsha safira. (2020). *Pelaksanaan Dokumentasi Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bm3qn>
- Siswanto, L. M. H., Hariyati, Rr. T. S., & Sukihananto, S. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan. *Deleted Journal*, 16(2), 77–84. <https://doi.org/10.7454/jki.v16i2.5>
- Sitanggang, R. (2019). *Peran Perawat Menerapkan Prinsip Pasien Safety di RS*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/mf4vk>
- Sitorus, A. M. S. (2020a). *"PENTINGNYA KUALITAS PROSES KEPERAWATAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN"*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3km2s>
- Sitorus, A. M. S. (2020b). *"UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN MOTIVASI PERAWAT TENTANG DOKUMENTASI KEPERAWATAN"*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qpyzb>
- Sitorus, H., Kurniati, T., & Hidayat, A. A. A. (2025). Pengaruh model supervisi klinik terhadap kinerja perawat dalam asuhan keperawatan di instalasi rawat inap 2 rumah sakit. *Journal of Nursing Practice and Education*, 5(2), 162–169. <https://doi.org/10.34305/jnpe.v5i2.1562>
- Soekerno, N., Ahsan, A., & Laily, L. (2025). INTERNAL AND EXTERNAL DETERMINANTS OF NURSING CARE DOCUMENTATION: A SCOPING REVIEW IN INPATIENT SETTINGS. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 17(2), 633–643. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v17i2.2943>
- Suci, W. P. (2018). PENINGKATAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN MELALUI PEMBERDAYAAN CHAMPION KESELAMATAN PASIEN. *Jurnal Kesehatan Holistic*, 2(2), 23–36. <https://doi.org/10.33377/jkh.v2i2.17>
- Suciani, T. M., Ratnasari, & Yanto, A. (2024). PERSEPSI PERAWAT DALAM MELENGKAPI DOKUMENTASI KEPERAWATAN. *Jurnal Keperawatan Sumba (JKS)*, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.31965/jks.v3i1.1662>
- Sudarsono, M. F., Masyurrosyidi, H., & Chalidyanto, D. (2021). Sistem Remunerasi terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Perawat. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 115–124. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.1476>
- Sudaryati, S., Afriani, T., Hariyati, Rr. T. S., Herawati, R., & Yunita, Y. (2022). Diskusi Refleksi Kasus (DRK) Efektif Meningkatkan Kemampuan Perawat dalam

Melakukan Dokumentasi Keperawatan Sesuai Standar 3s (SDKI, SLKI, SIKI). *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(2), 823–830. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i2.3461>

- Suhartini, T., Wardatul, W., & Hadi, W. N. (2023). Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berbasis Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia bagi Motivasi, Beban Kerja, Supervisi, Model Kepemimpinan dan Organisasi, serta Fasilitas Layanan. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5(1), 1316–1326. <https://doi.org/10.31539/joting.v5i1.5090>
- Sulistiyawati, W., & Susmiati, S. (2020). The Implementation Of 3S (SDKI, SIKI, SLKI) to The Quality Of Nursing Care Documentation In Hospital's Inpatient Rooms. *STRADA JURNAL ILMIAH KESEHATAN*, 9(2), 1323–1328. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.468>
- Supratti, S., & Ashriady, A. (2018). PENDOKUMENTASIAN STANDAR ASUHAN KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAMUJU. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 2(1), 44–44. <https://doi.org/10.33490/jkm.v2i1.13>
- Suratman, E., & Sunartini, SpAK. (2003). *Kepuasan kerja perawat dan mutu pelayanan keperawatan sebagai dasar pengembangan tenaga keperawatan di rumah sakit Krakatau Steel Cilegon*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/21425>
- Suryani, L., Masmulyadi, M., & Perdani, A. L. (2024). The Relationship Between Knowledge, Motivation, and Supervision Towards Documentation Among Nurses at Private Hospital in Indonesia. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 10(3). <https://doi.org/10.33755/jkk.v10i3.600>
- Suryati, S., Handayani, H., & Kuntarti, K. (2025). Analisis Determinan Efektivitas Supervisi Klinik Terhadap Kepala Ruang di Rumah Sakit: Systematic Review. *Jurnal Ners*, 9(3), 3381–3392. <https://doi.org/10.31004/jn.v9i3.44741>
- Susiana, E. (2019). *FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MUTU PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RSUD DR. SOETOMO SURABAYA PENELITIAN KORELASIONAL*. <https://repository.unair.ac.id/81253/>
- Susiana, E., Wahyuni, E. D., & Asmoro, C. P. (2019). Factors Related to the Quality of Nursing Care Documentation. *Fundamental and Management Nursing Journal*, 2(1), 16–16. <https://doi.org/10.20473/fmnj.v2i1.12340>
- Sutomo, S. Y., & Usman, A. (2019). Study Kualitatif Supervisi Kepala Ruangan Dengan Pelaksanaan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Di Ruang Rawat Inap RSUD Praya Kab.Lombok Tengah Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 7(2), 49–58. <https://doi.org/10.37824/jkqh.v7i2.2019.137>
- Sutris, S., Asda, P., & Syarifah, N. Y. (2020). SUPERVISI KEPALA RUANGAN BERHUBUNGAN DENGAN KELENGKAPAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RSPAU dr. SUHARDI HARDJOLUKITO YOGYAKARTA.

- Suyanti, I., Purwarini, J., & Supardi, S. (2021a). Kelengkapan Dokumentasi Keperawatan Sebelum dan Sesudah Pelatihan Praktik Keperawatan Profesional di Rumah Sakit X Baturaja Kabupaten Oku. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.56338/mppki.v4i1.1389>
- Suyanti, I., Purwarini, J., & Supardi, S. (2021b). *Kelengkapan Dokumentasi Keperawatan Sebelum dan Sesudah Pelatihan Praktik Keperawatan Profesional di Rumah Sakit X Baturaja Kabupaten Oku*. 4(1), 42–49. <https://doi.org/10.31934/mppki.v4i1.1389>
- Swari, S. J., Alfiansyah, G., Wijayanti, R. A., & Kurniawati, R. D. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang. *ARTERI Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 50–56. <https://doi.org/10.37148/arteri.v1i1.20>
- Syafawani, N. A. (2020). *Gambaran Kinerja Perawat Pada Proses Dokumentasi Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/bcf6d>
- Syofian, E. F. (2020). *Kaitan Kinerja Perawat dalam Menerapkan Proses Keperawatan di Rumah Sakit*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/s5aj8>
- Talebong, L. T., & Wijayanti, C. D. (2024). ANALISIS FAKTOR PENERIMAAN DAN TANTANGAN PENGGUNAAN ELECTRONIC MEDICAL RECORD OLEH PERAWAT DI RUMAH SAKIT: KAJIAN LITERATUR [THE ANALYSIS OF ACCEPTANCE FACTORS AND CHALLENGES IN THE USE OF ELECTRONIC MEDICAL RECORD BY NURSES IN HOSPITALS: A LITERATURE REVIEW]. *Nursing Current Jurnal Keperawatan*, 12(1), 133–133. <https://doi.org/10.19166/nc.v12i1.8132>
- tamaela, dimas. (2021). *KEWAJIBAN RUMAH SAKIT UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN HAK PASIEN SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN KESEHATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/g9t6x>
- Tamba, T. O. (2020). *HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI PERAWAT DAN SUPERVISI DENGAN KUALITAS PENDOKUMENTASIAN PROSES KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fyr4b>
- Tambun, Y. M., Setiawan, S., & Simamora, R. H. (2020). Persepsi Perawat tentang Supervisi Klinis Pelaksanaan Edukasi Pasien dan Keluarga. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(2), 607–617. <https://doi.org/10.31539/jks.v3i2.1121>
- Tambunan, D. A. (2019). *MANFAAT MENERAPKAN KEBIJAKAN KESELAMATAN PASIEN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/axp86>

- Tambunan, L. S. (2020). *ISU TERKINI DALAM PENINGKATAN KESELAMATAN PASIEN DALAM LINGKUP KERJA PERAWAT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xm8c6>
- Tampubolon, K. N. (2020a). *TAHAP-TAHAP PROSES KEPERAWATAN DALAM PENGOPTIMALAN ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5pydt>
- Tampubolon, K. N. (2020b). *PELAKSANAAN DOKUMENTASI ASUHAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEPERAWATAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/eav5f>
- Tampubolon, T. R. (2019a). *PENTINGNYA MELAKUKAN ASUHAN KEPERAWATAN BESERTA KESALAHAN-KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x5u6v>
- Tampubolon, T. R. (2019b). *PENTINGNYA PENDOKUMENTASIAN ASKEP BESERTA KESALAHAN –KESALAHAN YANG SERING TERJADI DALAM PENDOKUMENTASIAN ASKEP*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ytdnh>
- Tanauma, M. N., Kaunang, E. D., Kaseke, M. M., & Surya, W. S. (2023). Faktor-faktor yang Berhubungan dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Pusat Raratotok Buyat. *E-CliniC*, 11(2), 176–184. <https://doi.org/10.35790/ecl.v11i2.44901>
- Tarigan, A. P. S. (2019). *Standar Pendokumentasian pada Pasien*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7246m>
- Tarigan, T. V. B. (2020). *MANFAAT DAN FAKTOR FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DOKUMENTASI DALAM ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/aghk6>
- Taufik, M., Sajidin, M., Lestari, I., & Saudah, N. (2024). Hubungan Supervisi dan Motivasi dengan Kepatuhan Perawat dalam Mengisi Form Re-Assessment Risiko Jatuh. *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*, 4(3), 11198–11206. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11848>
- Teresa, T., Afrianti, T., & Suminarti, T. (2021). Optimalisasi peran & fungsi manajemen kepala ruangan dalam supervisi dokumentasi asuhan keperawatan di rumah sakit x Jakarta. *HOLISTIK JURNAL KESEHATAN*, 14(4), 536–544. <https://doi.org/10.33024/hjk.v14i4.2705>
- Tesa, A., Dianti, P., Siregar, N., Cleodora, C., Wahyuni, S., Pitaloka, R. D., & Hanum, S. (2025). Rekam Medis Elektronik Dalam Praktik Keperawatan Dan Pelayanan Kesehatan: Literatur Review. *JURNAL PENDIDIKAN KESEHATAN*, 5(2), 203–215. <https://doi.org/10.64931/jks.v5i2.182>
- Theresia, N., & Christianni, Y. (2022a). Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Kerja Perawat dalam Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di

Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. *SHILAP Revista de Lepidopterología*. <https://doi.org/10.33846/sf13120>

- Theresia, N., & Christianni, Y. (2022b). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Kerja Perawat dalam Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")*, 13(1). <https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/view/1634>
- titania, E. lismanda. (2019a). *MANAJEMEN K3 OLEH PERAWAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DIRUMAH SAKIT*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/t72ra>
- titania, E. lismanda. (2019b). *MANFAAT DOKUMENTASI DALAM TAHAP PROSES ASUHAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2cz3y>
- Trihastuti, E., Nursalam, N., & Qur'aniati, N. (2016). LEADERSHIP, MOTIVATION, AND WORK LOAD ON NURSES PERFORMANCE IN DOCUMENTING NURSE CARE. *INDONESIAN NURSING JOURNAL OF EDUCATION AND CLINIC (INJEC)*, 1(1), 90–90. <https://doi.org/10.24990/injec.v1i1.93>
- ujung, H. (2019). *Standar Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5awpg>
- Ulfah, C. F., Wisnugati, A. Y., Susanto, T., & Iriawandani, D. S. (2025). Optimalisasi Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pelaksanaan Dokumentasi Implementasi Asuhan Keperawatan Melalui Sistem CARE TAG di RS X Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen Kesehatan Dan Keperawatan.*, 2(4), 231–238. <https://doi.org/10.35968/hj2nqr25>
- Umasangadji, A. (Anjas A. (2025). HUBUNGAN FUNGSI MANAJEMEN CONTROLLING KEPALA RUANGAN DENGAN KELENGKAPAN PENDOKUMENTASIAN ASUHANKEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSU PANCARAN KASIH MANADO. In *Neliti*. <https://www.neliti.com/publications/689983/hubungan-fungsi-manajemen-controlling-kepala-ruangan-dengan-kelengkapan-pendokum>
- Umihara, Y., Rita, K., & Mulyani, E. Y. (2024). Pengaruh Kompetensi Perawat Dan Dukungan Supervisi Terhadap Kualitas Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Berbasis Elektronik Dimediasi Motivasi Pada Perawat Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 6(2), 1140–1152. <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i2.3570>
- Utami, B. T., Anggoro, D., Susanto, T., & Lianasari, D. (2025). Si-MANTAP (Sistem Inovasi Manajemen dan Tata Pengawasan Asuhan Keperawatan) pada Ruang Anthurium 2, Rumah Sakit Perkebunan Jember. *Jurnal Manajemen Kesehatan Dan Keperawatan.*, 2(3), 161–169. <https://doi.org/10.35968/hnqt1p85>

- Utomo, B., Murdiati, F. S., Prasetyo, J., & Nyoto, N. (2025). Efektivitas Strategi Micro Teaching Berbasis 4S terhadap Kualitas Dokumentasi Keperawatan. *KOLABORASI JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 6(1), 184–196. <https://doi.org/10.56359/kolaborasi.v6i1.786>
- Vienty, F. (2015a). *HUBUNGAN FUNGSI PENGARAHAN KEPALA RUANGDENGAN PELAKSANAAN DOKUMENTASI ASUHANKEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAPRSUD KEPULAUAN MENTAWAI*. <http://scholar.unand.ac.id/1917/>
- Vienty, F. (2015b). HUBUNGAN FUNGSI PENGARAHAN KEPALA RUANGAN DENGAN PELAKSANAAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP RSUD KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015. *Document Repository (Universitas Andalas)*.
- Wahdah, V. N., Intiasari, A. D., & Mulyanto, J. (2025). Evaluasi Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Kinerja Perawat di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Cirebon. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Kesehatan*, 8(2), 243–252. <https://doi.org/10.56467/jptk.v8i2.446>
- Wahyudi, C. T., & Gunarto, C. S. (2019). Produktivitas Kerja Perawat Ruang Rawat Inap. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 9(1), 550–562. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v9i01.210>
- Wahyuliati, T., & Novita, R. V. (2023). Efektivitas Pelatihan dan Supervisi terhadap Peningkatan Kualitas Pendokumentasian Asuhan Keperawatan: Literature Review. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 6(7), 1250–1258. <https://doi.org/10.56338/mparki.v6i7.3459>
- Wahyuliati, T., Novita, R. V. T., & Supardi, S. (2024). EFEKTIVITAS PELATIHAN 3S (SDKI, SLKI, SIKI) PADA PERAWAT PELAKSANA TERHADAP KESESUAIAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RS X JAKARTA DAN BOGOR. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 9(2), 91–91. <https://doi.org/10.32419/jppni.v9i2.579>
- Wahyuni, E. S. (Eko), Karningsih, K. (Karningsih), Sabil, T. (T. M., Lombogia, M. (Moudy), Abd., A. M. N. (Moh.), Alifariki, L. (La O., Desyani, N. J. (Ni L., Umar, S. (Syaniah), Kristin, D. M. (Diyan), Kristiani, A. (Anie), Inayati, R. (Rahmi), Tukatman, T. (Tukatman), Siagian, H. J. (Heriviyatno), & Hidayati, H. (Hidayati). (2025). KESELAMATAN PASIEN DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN. In *Neliti*. <https://www.neliti.com/publications/690604/keselamatan-pasien-dalam-praktik-keperawatan-dan-kebidanan>
- Wahyuni, N. T., & Wardani, R. (2025). Penerapan Manajemen Asuhan Keperawatan Profesional Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Asuhan. *Jurnal Abdi Kesehatan Dan Kedokteran*, 4(2), 1–10. <https://doi.org/10.55018/jakk.v4i2.71>

- Wanti, V., Arif, Y., & Murni, D. (2022). ANALISIS HUBUNGAN PELAKSANAAN SUPERVISI KLINIK MODEL 4S DENGAN INDIKATOR PENDOKUMENTASIAN PENCATATAN TERINTEGRASI DI RSU UNIVERSITAS RIAU. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 13(2), 184–184. <https://doi.org/10.30633/jkms.v13i2.1480>
- Wanti, V., Arif, Y., & Murni, D. (2023). Analisis Hubungan Pelaksanaan Supervisi Terhadap CPPT di Rumah Sakit Umum Universitas Riau. *Malahayati Nursing Journal*, 5(9), 3229–3239. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i9.7880>
- Warashati, D., Novieastari, E., & Afriani, T. (2020). OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI KEPALA RUANGAN DALAM PELAKSANAAN SOSIALISASI REGULASI DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL KESELAMATAN PASIEN. *Jurnal Keperawatan Komprehensif*, 6(2), 85–94. <https://doi.org/10.33755/jkk.v6i2.165>
- WASHILAH, W., & SUHARTINI, T. (2023). ANALISIS FAKTOR DALAM MENILAI KUALITAS DOKUMENTASI KEPERAWATAN. *Media Husada Journal Of Nursing Science*, 4(1), 36–42. <https://doi.org/10.33475/mhjns.v4i1.120>
- Wati, N. M. N., Prihatiningsih, D., & Haryani, N. P. N. (2019). HUBUNGAN SUPERVISI KEPERAWATAN DENGAN PELAKSANAAN BUDAYA SAFETY. *Adi Husada Nursing Journal*, 4(2), 56–56. <https://doi.org/10.37036/ahnj.v4i2.126>
- Wianti, A., Setiawan, A., Murtiningsih, M., Budiman, B., & Rohayani, L. (2021). Karakteristik dan Budaya Keselamatan Pasien terhadap Insiden Keselamatan Pasien. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 96–102. <https://doi.org/10.31539/jks.v5i1.2587>
- Wigatama, A. S., Munawaroh, S., & Dwirahayu, Y. (2020). LITERATURE REVIEW : HUBUNGAN MOTIVASI KERJA PERAWAT DENGAN KINERJA PERAWAT DALAM PENGISIAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN. *Health Sciences Journal*, 4(2), 47–47. <https://doi.org/10.24269/hsj.v4i2.513>
- Wijaya, A., Sumartiyawati, N. made, Awildan, I., & Suhartiningsih, S. (2025). EVALUASI PELAKSANAAN SUPERVISI TERHADAP PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG IRNA II RSUD KABUPATEN LOMBOK UTARA. *Prima Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 11(1), 146–151. <https://doi.org/10.47506/43x66v05>
- Wijaya, L., & Juniarti, F. (2025). ANALISIS PENGETAHUAN PERAWAT TERHADAP PENERAPAN DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS SDKI, SIKI DAN SLKI. *Jurnal Kesehatan Dan Pembangunan*, 15(2), 67–78. <https://doi.org/10.52047/jkp.v15i2.403>
- Wiratama, P. (2019). *DOKUMENTASI KEPERAWATAN UNTUK MENILAI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/mte3h>
- Wisuda, A. C., & Suraya, C. (2024). IMPLEMENTASI 3S (SDKI, SIKI, SLKI) DALAM PELAYANAN KEPERAWATAN DI RUANG RAWAT INAP. *Ukhuwah Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 45–53.
<https://doi.org/10.52395/ujpkm.v2i1.427>
- Wisuda, A. C., Suraya, C., Oxyandi, M., & Isrizal. (2025). Development Of Nursing Care Instruments Based On The 3s Framework (Sdki, Slki, Siki) For Inpatient Settings. *Citra Delima Scientific Journal of Citra Internasional Institute*, 9(1), 36–44. <https://doi.org/10.33862/citradelima.v9i1.582>
- Wisuda, A. C., Suraya, C., Oxyandi, M., Surahmat, R., Putra, M. A. S., Husin, H., & Emiliasari, D. (2025). PENGEMBANGAN STANDAR DAN PANDUAN ASUHAN KEPERAWATAN BERBASIS SDKI, SLKI, DAN SIKI UNTUK MENINGKATKAN MUTU PRAKTIK KEPERAWATAN. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Citra Delima*, 2(2), 68–77. <https://doi.org/10.33862/jp.v2i2.591>
- Wisuda, A. C., Suraya, C., Oxyandi, M., Surahmat, R., Saputra, M. A. S., & Desvitasari, H. (2025). EFFECTIVENESS OF 3S-BASED NURSING DOCUMENTATION TRAINING (SDKI, SLKI, SIKI) ON NURSES' KNOWLEDGE, PERFORMANCE, AND DOCUMENTATION SKILLS. *Journal of Nursing Science Research.*, 2(1), 37–50. <https://doi.org/10.33862/jnsr.v2i1.589>
- Wisuda, A. C., Suraya, C., Rusmarita, R., & Nainggolan, S. S. (2025). Peningkatan Pengetahuan, Kinerja, dan Keterampilan Dokumentasi Perawat melalui Pelatihan Dokumentasi Keperawatan Berbasis 3S (SDKI, SLKI, SIKI). *Ukhuwah Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 9–17. <https://doi.org/10.52395/ujpkm.v3i1.491>
- Wongso, E. S., Tahjoo, A., & Nofiarni, N. (2024). Competency, Motivation, and Supervision Technique Strong Predict to Completeness of Nursing Documentation. *International Journal of Nursing and Health Services (IJNHS)*, 7(5), 164–172. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v7i5.800>
- Wulandari, D. F., & Handiyani, H. (2019). Pengembangan Dokumentasi Keperawatan Berbasis Elektronik Di RS X Kota Depok Dengan Menggunakan Teori Perubahan Lewins. *JKG (JURNAL KEPERAWATAN GLOBAL)*, 4(1). <https://doi.org/10.37341/jkg.v4i1.66>
- Wuryanti, L. (2025). KOMPETENSI KLINIS DAN BUDAYA KERJA PERAWAT PROFESIONAL TERHADAP KUALITAS DOKUMENTASI ASUHAN KEPERAWATAN: Kajian Literatur. *Masker Medika*, 13(1), 54–64. <https://doi.org/10.52523/maskermedika.v13i1.746>
- Yanti, R. I., & Warsito, B. E. (2013). *Hubungan Karakteristik Perawat, Motivasi, Dan Supervisi Dengan Kualitas Dokumentasi Proses Asuhan Keperawatan*. 1(2), 111695.
<http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JMK/article/download/1006/1055>
- Yeniria. (2020). *Pendokumentasian Asuhan Keperawatan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/nsqfw>

- Yulianti, Y., & Wulandari, C. I. (2025). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS DOKUMENTASI KEPERAWATAN : LITERATURE REVIEW. *PREPOTIF Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1637–1648. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i1.43388>
- Yusnaini, Y., Arif, Y., & Dorisnita, D. (2021). Kemampuan Kepemimpinan Klinis Perawat Pelaksana Berdasarkan Pendekatan Clinical Leadership Competency Framework dan Faktor-Faktor Determinannya. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 4(2), 337–350. <https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1914>
- Yusuf, A. (2016). KOMPETENSI PERAWAT DALAM MERAWAT PASIEN GANGGUAN JIWA. *Jurnal NERS*, 11(2), 230–230. <https://doi.org/10.20473/jn.v11i22016.230-239>
- Zahlimar, Z. (2023). HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DENGAN KINERJA KELENGKAPAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN DI INSTALASI RAWAT INAP RSUD H. HANAFIE MUARA BUNGO. *Jurnal Ners*, 7(1), 106–109. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.12047>
- Zebua, F. (2020b). KEMAMPUAN PERAWAT DALAM MEMBERIKAN ASUHAN KEPERAWATAN MENJADI ISSUE PENTING DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KEPUASAN PASIEN. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qm3yj>
- Zendrato, M. V., & Hariyati, Rr. T. S. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Asuhan Keperawatan di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit X. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI)*, 2(2), 85–85. <https://doi.org/10.32419/jppni.v2i2.86>
- Zulkarnain, Z. (2019). Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pengarahan Kepala Ruang Dengan Kinerja Perawat Dalam Menerapkan Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Bima. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(2). <https://doi.org/10.58258/jisip.v1i2.356>

CHAPTER 4

HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SUPERVISI KLINIS DI RUANG RAWAT INAP

Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan

Supervisi klinis merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen keperawatan yang memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di ruang rawat inap. Mutu pelayanan keperawatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu perawat, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan sistem pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, serta mengacu pada standar praktik profesional. Dalam konteks tersebut, supervisi klinis berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap intervensi keperawatan yang diberikan kepada pasien telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur, prinsip etika profesi, serta pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice). Dengan. Oleh karena itu, keberadaan supervisi klinis menjadi bagian yang sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan secara komprehensif.

Selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian mutu pelayanan, supervisi klinis juga memiliki peran nyata dalam pengembangan profesional perawat. Pelaksanaan supervisi yang dilakukan secara sistematis dan efektif dapat memudahkan supervisor dalam mengidentifikasi kesenjangan antara praktik yang dilakukan di lapangan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Melalui proses tersebut, supervisor dapat memberikan arahan, bimbingan, serta umpan balik yang konstruktif kepada perawat pelaksana. Umpan balik tersebut tidak hanya membantu perawat dalam memperbaiki kualitas praktik keperawatan, tetapi juga mendorong terbentuknya proses pembelajaran yang berkelanjutan. Dengan demikian, supervisi klinis berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan klinis, penguatan kemampuan berpikir kritis, serta ketepatan pengambilan keputusan dalam praktik keperawatan.

Di samping meningkatkan kompetensi perawat, supervisi klinis juga berperan penting dalam menjamin keselamatan pasien. Pelaksanaan supervisi yang optimal dapat membantu menurunkan risiko terjadinya kesalahan tindakan keperawatan

yang berpotensi membahayakan pasien. Melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan, supervisor dapat memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilaksanakan secara aman, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan demikian, supervisi klinis tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan keselamatan pasien di ruang rawat inap.

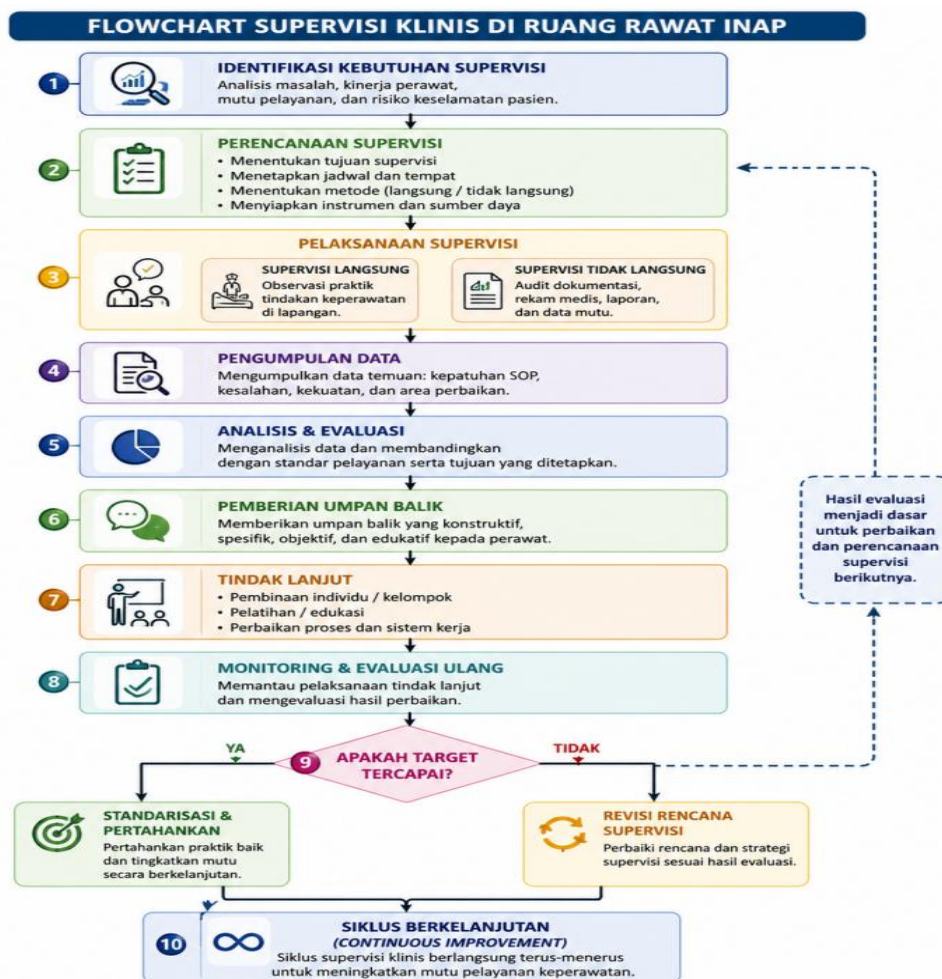
Meskipun supervisi klinis memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan keperawatan, implementasinya di ruang rawat inap masih menghadapi berbagai tantangan. Pada praktiknya, pelaksanaan supervisi klinis belum sepenuhnya berjalan secara optimal, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Berbagai kendala yang sering ditemukan di lapangan meliputi keterbatasan jumlah tenaga perawat, tingginya beban kerja, terbatasnya waktu yang tersedia untuk melakukan supervisi secara komprehensif, serta adanya perbedaan tingkat kompetensi di antara supervisor. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan supervisi klinis sering kali belum mampu memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

Berdasarkan fenomena tersebut, identifikasi terhadap hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis menjadi langkah yang sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas supervisi klinis, baik yang berasal dari aspek individu, organisasi, maupun lingkungan kerja. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai hambatan tersebut diharapkan dapat membantu manajemen keperawatan dalam merumuskan strategi perbaikan yang tepat, terstruktur, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kajian mengenai hambatan pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap memiliki relevansi yang tinggi sebagai dasar dalam pengembangan sistem manajemen keperawatan yang lebih efektif, sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan perlu untuk dibahas lebih mendalam pada BAB ini.

B. Supervisi Klinis dalam Praktik Keperawatan di Ruang Rawat Inap

Supervisi klinis dalam praktik keperawatan di ruang rawat inap merupakan suatu proses pembinaan profesional yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien telah sesuai dengan standar praktik yang berlaku (Nela, 2026). Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, ruang rawat inap menjadi salah satu unit dengan kompleksitas pelayanan yang tinggi karena melibatkan berbagai kondisi pasien, intervensi klinis yang beragam, serta koordinasi

multidisiplin yang intensif. Oleh karena itu, supervisi klinis di ruang rawat inap tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam meningkatkan kualitas praktik keperawatan melalui proses yang refleksi, evaluasi, dan umpan balik yang konstruktif. Pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap diarahkan pada peningkatan kemampuan perawat serta penguatan tanggung jawab profesional dalam memberikan asuhan keperawatan. Proses ini meliputi pengamatan secara langsung terhadap praktik klinis, diskusi kasus, pemberian bimbingan, serta evaluasi terhadap kinerja perawat dalam menerapkan proses keperawatan secara komprehensif. Melalui supervisi klinis yang dilaksanakan secara efektif, setiap perawat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan klinis secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang aman, tepat, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Selain itu, supervisi klinis juga berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan kesenjangan antara pengetahuan teoritis dengan pelaksanaan praktik di lapangan, sehingga standar pelayanan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan asuhan keperawatan. Berikut adalah gambaran supervisi klinis di ruang rawat inap :



Gambar 5.1: Flowchart Supervisi Klinis di Ruang Rawat Inap

Flowchart supervisi klinis di ruang rawat inap pada dasarnya menggambarkan rangkaian proses pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Alur tersebut menunjukkan bahwa supervisi tidak dilaksanakan secara insidental, melainkan melalui tahapan yang terencana, pelaksanaan yang terarah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Secara umum, *flowchart* dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan supervisi melalui pengamatan langsung terhadap praktik keperawatan, kemudian diikuti dengan proses penilaian terhadap kinerja perawat. Hasil dari penilaian tersebut selanjutnya disampaikan dalam bentuk umpan balik yang bersifat membangun, serta dilanjutkan dengan tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kemampuan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut kemudian didokumentasikan sebagai bagian dari proses manajerial. Dengan demikian, *flowchart* supervisi klinis mencerminkan suatu siklus pembinaan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilaksanakan sesuai standar, sekaligus mendukung peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan di ruang rawat inap

1. Posisi Supervisi Klinis dalam Sistem Pelayanan Keperawatan

Dalam sistem pelayanan keperawatan, supervisi klinis menempati kedudukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi manajemen keperawatan, terutama dalam aspek pengawasan (*controlling*) dan pembinaan (*directing*). Supervisi klinis berperan sebagai penghubung antara kebijakan manajerial dengan pelaksanaan praktik keperawatan oleh perawat pelaksana di ruangan. Melalui proses supervisi, standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diimplementasikan secara nyata, sehingga tercapai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Kedudukan strategis supervisi klinis juga tercermin dalam perannya untuk menjamin menjaga mutu keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan. Supervisi tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berperan dalam mendorong peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui kegiatan identifikasi masalah, analisis penyebab dan penetapan tindakan perbaikan yang tepat. Dalam sistem pelayanan keperawatan yang terstruktur, supervisi klinis menjadi bagian dari siklus manajemen mutu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan ilmu keperawatan yang menekankan pentingnya praktik berbasis bukti dan budaya keselamatan pasien dalam setiap proses pelayanan. Dengan demikian, supervisi klinis berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembinaan profesional yang

berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

2. Keterkaitan Supervisi dengan Mutu Asuhan Keperawatan

Supervisi klinis memiliki hubungan yang erat dengan mutu asuhan keperawatan, karena melalui kegiatan supervisi, dapat dilakukan pemantauan terhadap kesesuaian praktik keperawatan dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Mutu asuhan keperawatan mencerminkan tingkat keberhasilan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pasien secara holistik yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual. Dalam hal ini, supervisi klinis berperan untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses keperawatan mulai dari pengkajian, penetapan diagnosa, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi dilaksanakan secara tepat, sistematis dan konsisten sesuai standar praktik profesional. Selain itu, supervisi klinis juga berperan dalam meningkatkan mutu dokumentasi keperawatan yang merupakan komponen penting dalam penilaian kualitas pelayanan. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu mencerminkan tanggung jawab profesional perawat sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis serta evaluasi pelayanan. Melalui supervisi, supervisor dapat memberikan bimbingan dan perbaikan terhadap praktik pendokumentasian yang belum sesuai, sehingga kualitas pencatatan asuhan keperawatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Keterkaitan supervisi klinis dengan mutu asuhan keperawatan juga tampak dalam upaya pencegahan kesalahan (error prevention) dalam tindakan keperawatan. Pelaksanaan supervisi yang efektif, memungkinkan teridentifikasinya potensi kesalahan secara dini, sehingga risiko terhadap keselamatan pasien dapat diminimalkan. Hal ini sejalan dengan perkembangan praktik keperawatan yang menekankan pentingnya budaya keselamatan pasien dan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Dengan demikian, supervisi klinis memiliki kontribusi yang bermakna dalam mewujudkan tercapainya pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

3. Peran Kepala Ruangan dan Tim dalam Pelaksanaan Supervisi

Kepala ruangan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap. Sebagai pemimpin unit pelayanan keperawatan, kepala ruangan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan, melakukan pengorganisasian, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan supervisi klinis. Dalam pelaksanaannya, kepala ruangan tidak hanya

menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing, fasilitator, dan motivator bagi perawat pelaksana dalam meningkatkan kualitas praktik keperawatan. Kepala ruangan diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, terbuka dan kondusif bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan seluruh anggota tim keperawatan. Selain kepala ruangan, tim keperawatan juga memiliki peran yang penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan supervisi klinis. Pelaksanaan supervisi yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh anggota tim, baik sebagai pihak yang menerima pembinaan maupun yang berpartisipasi dalam proses supervisi. Dalam beberapa model praktik keperawatan, kegiatan supervisi dapat dilaksanakan secara kolaboratif melalui diskusi kasus, refleksi bersama, serta *peer supervision*. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi perawat untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga dapat meningkatkan mutu praktik keperawatan secara bersama-sama. Kerjasama antara kepala ruangan dan tim keperawatan juga berperan dalam menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. Melalui komunikasi yang efektif dan hubungan kerja yang harmonis, pelaksanaan supervisi klinis dapat berjalan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perawat. Dengan demikian, keberhasilan supervisi klinis sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kepemimpinan kepala ruangan dan partisipasi aktif tim keperawatan dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

4. Integrasi Supervisi Klinis dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit

Supervisi klinis harus diintegrasikan secara menyeluruh dengan standar pelayanan rumah sakit agar dapat berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan. Standar pelayanan rumah sakit mencakup berbagai aspek, seperti standar asuhan keperawatan, standar keselamatan pasien, serta standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga terkait (Nela, 2025). Dalam hal ini, supervisi klinis berfungsi sebagai mekanisme bertugas untuk memastikan bahwa seluruh standar tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam praktik keperawatan. Integrasi supervisi klinis dengan standar pelayanan juga mencakup penggunaan indikator mutu sebagai alat evaluasi kinerja. Melalui supervisi, supervisor dapat memantau pencapaian indikator mutu, seperti tingkat kepatuhan terhadap prosedur, kejadian insiden keselamatan pasien, serta kualitas dokumentasi keperawatan. Hasil supervisi kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan pelayanan keperawatan. Selain itu, integrasi ini juga berkaitan dengan upaya pemenuhan standar akreditasi rumah

sakit yang menekankan pada pentingnya mutu dan keselamatan pasien. Supervisi klinis menjadi salah satu strategi dalam memastikan bahwa praktik keperawatan telah sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku. Dengan demikian, supervisi klinis tidak hanya berfungsi dalam konteks internal unit keperawatan, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam mendukung pencapaian standar mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

C. Pelaksanaan Supervisi Klinis di Ruang Rawat Inap

Pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap merupakan suatu proses manajerial dan profesional yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien berlangsung sesuai dengan standar praktik, prinsip etik, serta kebutuhan pasien yang bersifat individual dan komprehensif. Dalam lingkungan ruang rawat inap yang memiliki kompleksitas tinggi, supervisi klinis menjadi instrumen penting untuk menjamin konsistensi mutu pelayanan, meningkatkan kompetensi perawat, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam tindakan keperawatan. Pelaksanaan supervisi klinis tidak bersifat insidental, melainkan harus dirancang secara terstruktur melalui tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang berkesinambungan. Supervisi klinis yang dilaksanakan secara efektif akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif, terbuka terhadap pembelajaran, serta berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Dalam praktiknya, supervisi klinis melibatkan interaksi profesional antara supervisor dan perawat pelaksana, yang tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan, tetapi juga pada pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan kapasitas individu maupun tim keperawatan.

1. Perencanaan Kegiatan Supervisi Klinis

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap. Perencanaan yang baik harus disusun secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan keperawatan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan supervisi klinis mencakup beberapa komponen penting, yaitu penetapan tujuan supervisi, identifikasi sasaran supervisi, penentuan jadwal pelaksanaan, serta pemilihan metode dan teknik supervisi yang akan digunakan. Perumusan tujuan supervisi klinis harus dilakukan secara jelas, spesifik, dan terukur agar pelaksanaan supervisi memiliki arah yang pasti. Tujuan tersebut dapat berupa peningkatan kepatuhan perawat terhadap standar operasional prosedur, perbaikan kualitas dokumentasi keperawatan maupun peningkatan keterampilan klinis perawat

dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Kejelasan tujuan supervisi akan memudahkan supervisor dalam menentukan langkah-langkah pelaksanaan serta melakukan evaluasi terhadap hasil supervisi yang telah dilakukan.

Selain itu, proses perencanaan supervisi klinis juga harus mempertimbangkan kondisi sumber daya yang tersedia di ruang rawat inap, meliputi jumlah tenaga perawat, beban kerja, serta tingkat kompleksitas kasus pasien di ruang rawat inap. Kepala ruangan sebagai supervisor memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun rencana supervisi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang disusun secara matang akan memudahkan proses pelaksanaan supervisi serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan sumber daya. Dengan demikian, pelaksanaan supervisi klinis dapat berjalan secara terarah dan memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Supervisi

Pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap dapat dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu supervisi langsung dan supervisi tidak langsung. Supervisi langsung merupakan bentuk supervisi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat pelaksana. Dalam supervisi langsung, supervisor hadir di lokasi pelayanan dan melakukan pengamatan terhadap tindakan keperawatan, interaksi dengan pasien, serta penerapan prosedur klinis. Mekanisme ini memungkinkan supervisor untuk memperoleh gambaran yang nyata dan akurat mengenai kinerja perawat, sehingga umpan balik yang diberikan dapat lebih spesifik dan kontekstual. Sementara itu, supervisi tidak langsung dilakukan melalui penelaahan dokumen, laporan, atau hasil kerja perawat tanpa kehadiran langsung di tempat pelayanan. Contoh supervisi tidak langsung antara lain adalah audit dokumentasi keperawatan, evaluasi laporan harian, serta peninjauan rekam medis pasien. Meskipun tidak melibatkan observasi langsung, supervisi tidak langsung tetap memiliki peran penting dalam menilai kualitas asuhan keperawatan, terutama dalam aspek administrasi dan dokumentasi. Kedua mekanisme tersebut sebaiknya digunakan secara komplementer untuk memperoleh hasil supervisi yang lebih komprehensif. Supervisi langsung memberikan informasi terkait praktik nyata di lapangan, sedangkan supervisi tidak langsung memberikan gambaran mengenai konsistensi pencatatan dan pelaporan. Dengan mengombinasikan kedua pendekatan tersebut, supervisor

dapat melakukan penilaian yang lebih objektif dan menyeluruh terhadap kinerja perawat.

3. Teknik Supervisi Klinis (Observasi, Diskusi dan Umpan Balik)

Pelaksanaan supervisi klinis memerlukan penerapan teknik yang tepat dan terstruktur agar tujuan pembinaan dapat dicapai secara optimal. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah observasi, yaitu kegiatan pengamatan secara sistematis terhadap praktik keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat pelaksana. Observasi dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup dengan tetap menjunjung tinggi prinsip etika, privasi, serta kenyamanan perawat dan pasien. Melalui kegiatan ini, supervisor mampu mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam praktik keperawatan, sekaligus menilai kesesuaian tindakan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Selain observasi, diskusi juga merupakan teknik penting dalam supervisi klinis. dilaksanakan dalam bentuk interaksi individual maupun kelompok dengan tujuan membahas temuan hasil supervisi, melakukan klarifikasi terhadap permasalahan yang muncul, serta merumuskan solusi secara kolaboratif. Pelaksanaan diskusi yang efektif harus didasarkan pada suasana yang terbuka, saling menghargai, serta berorientasi pada proses pembelajaran. Dengan demikian, perawat memiliki ruang yang aman untuk mengemukakan pendapat, berbagi pengalaman, dan mengembangkan pemahaman profesionalnya.

Teknik berikutnya adalah pemberian umpan balik. Umpan balik merupakan proses penyampaian informasi kepada perawat terkait kinerja yang telah dilakukan, baik yang bersifat penguatan maupun perbaikan. Umpan balik yang efektif harus disampaikan secara konstruktif, spesifik, objektif, dan komunikatif, sehingga mudah dipahami dan dapat diterima dengan baik. Pemberian umpan balik yang tepat akan mendorong terjadinya refleksi diri serta peningkatan kualitas praktik keperawatan secara berkelanjutan.

Dalam konteks pendidikan klinik, supervisi klinis yang dilaksanakan secara intensif oleh *clinical nurse instructor* terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas praktik klinik mahasiswa. Hal ini ditunjukkan melalui penguatan interaksi pembelajaran, peningkatan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan, serta berkembangnya kemampuan berpikir kritis dan kolaborasi tim. Selain itu, peningkatan frekuensi supervisi juga berbanding lurus dengan tingkat kepuasan dan kualitas pengalaman belajar klinik yang dirasakan oleh mahasiswa (Miho et al., 2025)

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Supervisi

Evaluasi merupakan tahap penting dalam pelaksanaan supervisi klinis yang bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan supervisi serta mengidentifikasi sejauh mana tujuan supervisi telah tercapai. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil supervisi dengan standar atau indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ruang rawat inap, evaluasi dapat mencakup aspek kepatuhan terhadap prosedur, kualitas dokumentasi, keterampilan klinis, serta sikap profesional perawat. Hasil evaluasi supervisi klinis harus didokumentasikan secara sistematis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial. Dokumentasi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan supervisi selanjutnya serta sebagai bukti akuntabilitas dalam pelaksanaan manajemen keperawatan. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan akan memberikan gambaran mengenai perkembangan kinerja perawat serta efektivitas sistem supervisi yang diterapkan. Tindak lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses evaluasi. Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah diperoleh, dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan kelebihan yang telah dicapai. Bentuk tindak lanjut dapat berupa pelatihan, pembinaan individu, revisi prosedur, atau perbaikan sistem kerja. Dengan adanya tindak lanjut yang tepat, supervisi klinis tidak hanya berhenti pada tahap penilaian, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di ruang rawat inap secara berkelanjutan.

D. Hambatan dalam Pelaksanaan Supervisi Klinis

Pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor individu, organisasi, maupun lingkungan kerja yang saling berinteraksi dan secara simultan memengaruhi efektivitas pelaksanaan supervisi (Nela, 2025). Dalam praktiknya, supervisi klinis belum terlaksana secara optimal akibat keterbatasan sumber daya, kelemahan dalam sistem manajerial, serta kurangnya dukungan lingkungan kerja yang kondusif. Lebih lanjut temuan White .,et.,al (2023) memperkuat bahwa hambatan dalam supervisi klinis, seperti keterbatasan waktu dan tingginya beban kerja, berpotensi menurunkan mutu pelayanan keperawatan serta meningkatkan risiko terhadap keselamatan pasien. Kondisi ini berdampak pada belum tercapainya tujuan supervisi secara maksimal, baik dalam upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan maupun dalam pengembangan kompetensi perawat.

Menurut Suryanti.,et.,al (2020) hambatan dalam pelaksanaan supervisi meliputi berbagai faktor yang berasal dari lingkungan kerja maupun individu pelaksana supervisi. Faktor lingkungan yang sering menjadi kendala antara lain keterbatasan privasi ruangan, munculnya konflik politik dan profesional, kurangnya pemahaman mengenai supervisi, keterbatasan waktu perawat, serta terbatasnya sumber daya pelayanan kesehatan. Selain itu, hambatan yang berasal dari perawat dapat berupa ketakutan terhadap perubahan, rendahnya rasa percaya diri, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, serta kurangnya pemahaman terhadap proses supervisi. Pelaksanaan supervisi juga sering mengalami kendala akibat rendahnya partisipasi staf, terutama apabila kegiatan supervisi dianggap memerlukan biaya tambahan, seperti kebutuhan penitipan anak. Faktor lain yang turut memengaruhi pelaksanaan supervisi meliputi tingginya beban kerja, keterbatasan jumlah tenaga keperawatan, kurangnya pemahaman mengenai konsep dan tujuan supervisi, serta kesulitan dalam mendorong staf untuk melakukan refleksi diri secara objektif. Di samping itu, masalah pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, konflik antarindividu, maupun konflik antara staf dan manajemen dapat menghambat efektivitas pelaksanaan supervisi dalam pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, identifikasi dan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai hambatan tersebut menjadi langkah yang esensial dalam mendukung upaya perbaikan sistem supervisi klinis secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menempati posisi sentral sebagai penentu efektivitas pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap. Keterbatasan jumlah tenaga sumber daya manusia seperti perawat masih kerap menjadi hambatan mendasar dalam upaya mewujudkan supervisi yang optimal. Ketidakseimbangan antara jumlah perawat dan pasien berdampak pada meningkatnya beban kerja, yang pada akhirnya mempersempit alokasi waktu untuk kegiatan supervisi. Dalam situasi tersebut, perhatian perawat lebih banyak terserap pada pemenuhan kebutuhan asuhan keperawatan langsung, sementara aktivitas supervisi cenderung terpinggirkan atau tidak terlaksana secara efektif. Di samping persoalan kuantitas, perbedaan tingkat kompetensi antara perawat pelaksana dan supervisor juga menghadirkan tantangan tersendiri. Tidak seluruh supervisor memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalankan fungsi supervisi klinis, baik ditinjau dari penguasaan substansi, kecakapan komunikasi, maupun kemampuan memberikan umpan balik yang bersifat membangun. Sementara itu, keberagaman latar belakang pendidikan

dan pengalaman perawat pelaksana menuntut adanya pendekatan supervisi yang fleksibel dan kontekstual. Ketidaksesuaian antara kebutuhan pembinaan dengan kapasitas supervisor berpotensi menghambat proses pembelajaran serta mengurangi efektivitas pengembangan profesional perawat.

Disisi lain beban kerja yang tinggi juga semakin memperkuat kompleksitas permasalahan tersebut. Beban kerja yang berlebihan tidak hanya berimplikasi pada penurunan kinerja, tetapi juga memengaruhi kualitas interaksi profesional antara supervisor dan perawat pelaksana. Akibatnya, pelaksanaan supervisi sering berlangsung secara singkat, kurang mendalam, dan tidak berkesinambungan. Selain itu, faktor motivasi dan kesiapan individu juga turut menentukan keberhasilan proses supervisi. Perawat yang belum memiliki kesiapan atau menunjukkan motivasi yang rendah cenderung kurang responsif terhadap upaya pembinaan, sehingga tujuan supervisi klinis baik dalam peningkatan mutu pelayanan maupun penguatan kompetensi professional tidak sepenuhnya dapat dicapai.

2. Aspek Manajerial dan Organisasi

Ditinjau dari perspektif manajerial, hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis erat kaitannya dengan fungsi perencanaan yang belum berjalan secara optimal. Perencanaan supervisi yang belum disusun secara sistematis, tidak didukung jadwal yang jelas, serta tidak didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan mengakibatkan pelaksanaan supervisi berlangsung tanpa arah yang tegas. Ketiadaan perencanaan yang matang menyebabkan kegiatan supervisi cenderung bersifat situasional dan tidak memberikan kontribusi yang bermakna terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Di samping itu, keterbatasan kebijakan dan dukungan manajemen merupakan faktor penghambat yang tidak dapat diabaikan. Pelaksanaan supervisi klinis memerlukan dukungan organisasi dalam bentuk regulasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, serta komitmen terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan. Namun demikian, dalam beberapa kondisi, supervisi klinis belum ditempatkan sebagai prioritas dalam kebijakan organisasi, sehingga implementasinya belum memperoleh dukungan yang memadai. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya penyediaan fasilitas, alokasi waktu, dan sumber daya yang mendukung kegiatan supervisi. Lebih lanjut, sistem monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana secara efektif turut memengaruhi keberhasilan supervisi klinis. Ketiadaan mekanisme evaluasi yang terstruktur menyulitkan proses penilaian terhadap pelaksanaan supervisi serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja perawat. Selain itu, keterbatasan pelatihan supervisi klinis

bagi kepala ruangan dan supervisor menjadi kendala yang signifikan. Minimnya kesempatan pelatihan menyebabkan supervisor belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan, komunikasi profesional, dan evaluasi kinerja secara sistematis.

3. Aspek Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja di ruang rawat inap yang bersifat dinamis dan berintensitas tinggi merupakan konteks yang tidak terpisahkan dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis. Tingginya jumlah pasien, keragaman kondisi klinis, serta tuntutan pelayanan yang cepat dan tepat menempatkan perawat dalam situasi kerja yang sarat tekanan. Dalam kondisi demikian, perhatian tenaga keperawatan cenderung terfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien secara langsung, sehingga pelaksanaan supervisi klinis belum sepenuhnya menempati posisi sebagai prioritas utama. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh keterbatasan fasilitas pendukung yang tersedia di unit pelayanan. Keberadaan ruang diskusi yang representatif, sarana dokumentasi yang memadai, serta akses terhadap sumber informasi ilmiah merupakan elemen penting dalam menunjang efektivitas supervisi klinis. Namun demikian, keterbatasan pada aspek-aspek tersebut menyebabkan proses pembinaan, refleksi, dan evaluasi tidak dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, kompleksitas situasi klinis seperti kondisi kegawatdaruratan dan perubahan status pasien yang cepat semakin membatasi ruang pelaksanaan supervisi, baik dari segi waktu maupun kedalaman prosesnya. Lingkungan kerja yang kurang kondusif pada akhirnya turut memengaruhi kualitas interaksi profesional antara supervisor dan perawat pelaksana, sehingga esensi supervisi sebagai proses pembelajaran berkelanjutan menjadi kurang tercapai.

Dalam perspektif yang lebih luas, lingkungan kerja tersebut berkaitan erat dengan konsep lingkungan pembelajaran klinis (*clinical learning environment*), yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku profesional, khususnya perilaku *caring* dan kemampuan advokasi pada mahasiswa keperawatan. Dalam konteks ini, supervisi klinis tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme pengawasan, melainkan sebagai komponen integral yang membentuk kualitas pengalaman belajar di lingkungan klinik. Hasil kajian menunjukkan bahwa lingkungan klinis yang kondusif, yang didukung oleh pelaksanaan supervisi yang efektif, berkontribusi positif terhadap perkembangan sikap *caring* pada mahasiswa. Lingkungan yang suportif mendorong mahasiswa untuk mengembangkan empati, meningkatkan kemampuan komunikasi terapeutik, serta memperkuat kepekaan terhadap

kebutuhan pasien. Dengan demikian, supervisi klinis berfungsi sebagai medium internalisasi nilai-nilai profesional yang esensial dalam praktik keperawatan.

Lebih lanjut, kualitas supervisi klinis juga berperan dalam meningkatkan kemampuan advokasi mahasiswa. Mahasiswa yang memperoleh bimbingan secara aktif dan terarah dari supervisor cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak pasien, menunjukkan keberanian dalam menyampaikan pendapat secara profesional, serta mampu bertindak sebagai representasi kepentingan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa supervisi klinis tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi teknis, tetapi juga pada pembentukan integritas etis dan tanggung jawab profesional. Keberhasilan proses tersebut sangat ditentukan oleh kualitas interaksi yang terbangun antara mahasiswa, supervisor, dan tim kesehatan. Interaksi yang positif dan harmonis memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang reflektif, terbuka, dan berkesinambungan. Dalam hal ini, supervisor memegang peran strategis sebagai fasilitator, mentor, sekaligus *role model* dalam membimbing mahasiswa menuju praktik keperawatan yang profesional.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa kualitas lingkungan pembelajaran klinis tidak hanya ditentukan oleh supervisi semata. Faktor organisasi dan budaya kerja di unit pelayanan kesehatan turut memberikan kontribusi yang signifikan. Dukungan institusi, beban kerja tenaga kesehatan, serta ketersediaan sumber daya menjadi determinan penting dalam menentukan efektivitas proses pembelajaran klinik. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas supervisi klinis perlu disertai dengan perbaikan sistem organisasi dan lingkungan kerja secara komprehensif. Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa lingkungan pembelajaran klinis yang kondusif, dengan dukungan supervisi yang efektif, memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku *caring* dan kemampuan advokasi mahasiswa keperawatan. Melalui interaksi yang konstruktif, proses pembelajaran yang reflektif, serta penguatan nilai-nilai profesional, supervisi klinis menjadi bagian integral dalam upaya peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan keselamatan pasien (Valdez et al., 2026).

4. Komunikasi dan Hubungan Kerja dalam Supervisi Klinis

Dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap, keberhasilan proses pembinaan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan sistem yang mendukung, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi yang terjalin antara supervisor dan perawat pelaksana. Interaksi tersebut pada hakikatnya dibangun melalui proses komunikasi interpersonal yang efektif, yang

memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, klarifikasi pemahaman, serta pemberian umpan balik secara konstruktif. Namun demikian, dalam praktiknya, aspek komunikasi ini masih sering menjadi titik lemah yang menghambat optimalisasi supervisi klinis.

Komunikasi interpersonal yang kurang efektif merupakan salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap. Proses komunikasi yang tidak berlangsung secara jelas, terbuka, dan dua arah berpotensi menimbulkan kesalahpahaman antara supervisor dan perawat pelaksana. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat kelancaran proses pembinaan, tetapi juga menurunkan efektivitas supervisi secara keseluruhan, karena pesan yang disampaikan tidak diterima dan dimaknai secara tepat.

Permasalahan komunikasi tersebut berkaitan erat dengan kualitas umpan balik yang diberikan dalam proses supervisi. Umpan balik yang tidak spesifik, tidak diberikan secara tepat waktu, atau disampaikan dengan cara yang kurang tepat cenderung tidak memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kinerja perawat. Dalam situasi demikian, perawat pelaksana mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, umpan balik yang konstruktif, jelas, dan komunikatif menjadi instrumen penting dalam mendorong refleksi serta peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.

Selain faktor komunikasi individual, struktur organisasi juga turut memengaruhi dinamika interaksi dalam supervisi klinis. Hierarki organisasi yang kaku dan terlalu formal dapat membatasi terjadinya komunikasi yang terbuka antara supervisor dan perawat pelaksana. Dalam kondisi tersebut, perawat cenderung merasa enggan untuk mengemukakan pendapat, menyampaikan kendala, atau mengungkapkan kesulitan yang dihadapi dalam praktik. Akibatnya, berbagai permasalahan yang muncul di lapangan tidak teridentifikasi secara dini dan tidak terselesaikan secara optimal.

Lebih lanjut, budaya kerja di lingkungan pelayanan kesehatan menjadi faktor yang memperkuat atau justru menghambat efektivitas supervisi klinis. Budaya kerja yang kurang terbuka terhadap kritik, masukan, dan proses pembelajaran akan membatasi ruang bagi refleksi profesional. Lingkungan yang tidak mendukung diskusi secara terbuka cenderung menghambat pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sehingga proses pengembangan profesional tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun budaya kerja yang mendorong komunikasi terbuka, menjunjung tinggi sikap saling menghargai, serta berorientasi pada perbaikan mutu secara berkelanjutan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan supervisi klinis yang efektif

5. Implementasi Standar dan Prosedur

Dalam sistem manajemen keperawatan, standar dan prosedur berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan praktik profesional sekaligus menjamin konsistensi mutu pelayanan. Standar Prosedur Operasional (SPO) tidak hanya menjadi pedoman dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa supervisi klinis berlangsung secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Namun demikian, pada tataran implementasi, penerapan standar dan prosedur tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas supervisi klinis di ruang rawat inap. Permasalahan pertama yang menonjol adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan SPO di lapangan. Ketidakkonsistenan ini berimplikasi pada munculnya variasi dalam praktik keperawatan, sehingga mutu pelayanan yang dihasilkan menjadi tidak seragam. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman tenaga keperawatan terhadap standar yang berlaku, belum optimalnya fungsi pengawasan, serta adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi riil pelayanan.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan aspek sosialisasi standar supervisi klinis yang belum dilaksanakan secara optimal. Kurangnya pemahaman yang komprehensif, baik pada perawat pelaksana maupun supervisor, menyebabkan standar dan prosedur supervisi tidak dapat diimplementasikan secara tepat. Dalam kondisi tersebut, standar yang telah disusun cenderung hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik keperawatan. Selanjutnya, aspek dokumentasi dan evaluasi juga menjadi bagian yang belum terlaksana secara memadai. Dokumentasi supervisi yang tidak lengkap dan tidak tersusun secara sistematis menyulitkan proses pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan supervisi klinis. Keterbatasan data yang tersedia berdampak pada lemahnya proses evaluasi, sehingga tindak lanjut yang seharusnya dilakukan tidak dapat direncanakan secara terarah dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hambatan dalam implementasi standar dan prosedur menunjukkan adanya kelemahan pada aspek sistem pengelolaan supervisi klinis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen keperawatan yang mencakup peningkatan pemahaman terhadap standar, optimalisasi fungsi pengawasan, serta pengembangan sistem dokumentasi dan evaluasi yang terintegrasi. Dengan demikian, pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap diharapkan dapat berlangsung secara lebih sistematis, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

E. Dampak Hambatan terhadap Pelayanan Keperawatan

Supervisi klinis menempati posisi strategis dalam sistem pelayanan keperawatan karena berperan langsung dalam menjamin mutu asuhan, meningkatkan keselamatan pasien, serta mendorong pengembangan profesional perawat. Keberhasilan pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai determinan, antara lain beban kerja, ketersediaan sumber daya manusia, kualitas lingkungan kerja, serta efektivitas komunikasi interpersonal. Ketika faktor-faktor tersebut tidak dikelola secara optimal, pelaksanaan supervisi klinis cenderung mengalami dampak hambatan yang pada akhirnya menurunkan kualitas proses pembinaan dan pengawasan praktik keperawatan.

Dampak hambatan dalam supervisi klinis tersebut berimplikasi langsung terhadap mutu pelayanan keperawatan. Supervisi yang tidak terlaksana secara optimal akan melemahkan fungsi pembinaan, pengendalian, dan evaluasi, sehingga penerapan standar pelayanan menjadi tidak konsisten. Dalam kondisi demikian, variasi praktik keperawatan sulit dihindari dan berpotensi menurunkan kualitas asuhan yang diberikan kepada pasien.

Lebih jauh, dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis pelayanan, tetapi juga meluas pada dimensi keselamatan pasien. Ketiadaan supervisi yang efektif dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam praktik keperawatan, baik yang berkaitan dengan prosedur klinis, komunikasi, maupun pengambilan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa supervisi klinis memiliki keterkaitan yang erat dengan upaya pencegahan insiden keselamatan pasien.

Selain itu, dampak hambatan dalam supervisi klinis turut memengaruhi perkembangan profesional perawat. Proses supervisi yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran, refleksi, dan peningkatan kompetensi tidak dapat berlangsung secara optimal. Akibatnya, kesempatan perawat untuk mengembangkan kemampuan klinis, keterampilan komunikasi, serta penalaran profesional menjadi terbatas. Dengan demikian, dampak hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis bersifat multidimensional dan memengaruhi berbagai aspek pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang terencana dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas supervisor, optimalisasi fungsi manajemen keperawatan, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas supervisi klinis sehingga berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

1. Penurunan Mutu Asuhan Keperawatan

Salah satu dampak utama dari hambatan dalam supervisi klinis adalah terjadinya penurunan mutu asuhan keperawatan. Mutu asuhan keperawatan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar praktik, ketepatan dalam pelaksanaan intervensi, serta kualitas dokumentasi yang dilakukan oleh perawat. Ketika supervisi klinis tidak berjalan secara efektif, proses pemantauan dan evaluasi terhadap praktik keperawatan menjadi tidak optimal, sehingga potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dengan standar tidak dapat teridentifikasi secara dini. Penurunan mutu juga dapat terlihat dari ketidakkonsistenan dalam penerapan proses keperawatan, mulai dari tahap pengkajian hingga evaluasi. Perawat mungkin tidak melakukan pengkajian secara komprehensif, menetapkan diagnosis keperawatan yang kurang tepat, atau melaksanakan intervensi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. Selain itu, kualitas dokumentasi keperawatan juga cenderung menurun, baik dari segi kelengkapan, akurasi, maupun ketepatan waktu. Secara aplikatif, kondisi penurunan mutu asuhan keperawatan akibat hambatan supervisi klinis dapat ditemukan dalam berbagai situasi pelayanan. Misalnya, perawat yang tidak mendapatkan supervisi rutin cenderung kurang disiplin dalam melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian obat, kurang teliti dalam memantau tanda-tanda vital pasien kritis, atau tidak konsisten dalam menerapkan prinsip pencegahan infeksi. Pada pelayanan rawat inap, kurangnya supervisi dapat menyebabkan keterlambatan deteksi perubahan kondisi pasien, sedangkan pada pelayanan komunitas dapat mengakibatkan edukasi kesehatan yang diberikan kepada pasien menjadi kurang efektif dan tidak terstandar. Kondisi ini menunjukkan bahwa supervisi klinis memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga standar mutu pelayanan keperawatan.

2. Peningkatan Risiko Keselamatan Pasien

Hambatan dalam supervisi klinis juga berdampak langsung terhadap peningkatan risiko keselamatan pasien (Fazrinnor.,et.,al, 2019). Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan yang harus dijaga melalui penerapan standar dan prosedur yang ketat. Supervisi klinis berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan secara aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun, ketika supervisi tidak berjalan efektif, potensi terjadinya kesalahan dalam praktik keperawatan menjadi lebih tinggi. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan dalam pemberian obat, kesalahan identifikasi pasien, atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Selain itu,

kurangnya pengawasan juga dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penanganan kondisi pasien yang memburuk. Dalam situasi tertentu, hal ini dapat berdampak serius terhadap keselamatan pasien, bahkan dapat menyebabkan kejadian yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, supervisi klinis yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan pasien tetap terjaga.

3. Penurunan Kinerja Perawat

Hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis memberikan dampak yang besar terhadap penurunan kinerja perawat di ruang rawat inap. Kinerja perawat merupakan gambaran kemampuan perawat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesional secara efektif, tepat, aman, serta sesuai dengan standar pelayanan keperawatan. Kinerja yang optimal tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi individu, tetapi juga sangat bergantung pada proses pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui supervisi klinis. Oleh karena itu, ketika supervisi klinis tidak berjalan secara efektif, kualitas kinerja perawat cenderung mengalami penurunan.

Penurunan kinerja perawat terjadi karena hambatan supervisi menyebabkan proses pembinaan profesional tidak terlaksana secara optimal. Dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan, supervisi klinis berfungsi memberikan arahan, koreksi, serta bimbingan kepada perawat agar praktik keperawatan tetap sesuai dengan standar operasional prosedur dan prinsip keselamatan pasien. Namun, apabila supervisi jarang dilakukan, berlangsung tidak terstruktur, atau hanya bersifat administratif, perawat akan mengalami keterbatasan dalam memperoleh masukan terkait kualitas praktik yang dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan perawat tidak memiliki pedoman yang jelas dalam memperbaiki kesalahan maupun meningkatkan kemampuan klinis yang dimiliki.

Selain menghambat proses pembinaan, kurang optimalnya supervisi klinis juga berdampak pada menurunnya disiplin dan kepatuhan perawat terhadap standar pelayanan. Supervisi yang efektif seharusnya mampu memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi, ketika pengawasan tidak berjalan secara konsisten, risiko terjadinya kelalaian dalam praktik keperawatan menjadi lebih tinggi. Perawat dapat mengalami penurunan ketelitian dalam pendokumentasian, ketidaktepatan pelaksanaan tindakan keperawatan, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat

membentuk pola kerja yang kurang profesional dan menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Hambatan supervisi klinis juga memengaruhi kemampuan perawat dalam mengembangkan kompetensi profesional. Supervisi klinis pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pengembangan kemampuan klinis. Melalui supervisi, perawat memperoleh kesempatan untuk berdiskusi, melakukan refleksi terhadap praktik yang dilakukan, serta menerima umpan balik yang konstruktif dari supervisor. Namun, ketika supervisi tidak berjalan secara efektif, proses pembelajaran tersebut menjadi terhambat. Akibatnya, kemampuan berpikir kritis, keterampilan klinis, dan ketepatan pengambilan keputusan perawat tidak berkembang secara optimal. Kondisi ini menyebabkan kualitas kinerja perawat cenderung stagnan, bahkan dapat mengalami penurunan seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan di ruang rawat inap.

Di samping itu, hambatan supervisi klinis turut berdampak terhadap motivasi kerja perawat. Perawat yang tidak memperoleh dukungan, perhatian, dan pembinaan secara memadai dari supervisor cenderung merasa kurang dihargai dalam lingkungan kerja. Kondisi tersebut dapat menurunkan semangat kerja, rasa tanggung jawab, serta komitmen profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan. Penurunan motivasi kerja akan berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kualitas pelaksanaan tugas perawat sehari-hari. Perawat menjadi kurang proaktif, kurang berinisiatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan, serta cenderung bekerja hanya untuk memenuhi tugas rutin tanpa adanya dorongan untuk mengembangkan kualitas praktik keperawatan.

Lebih lanjut, penurunan kinerja perawat akibat hambatan supervisi klinis dapat memberikan dampak yang luas terhadap pelayanan keperawatan secara keseluruhan. Kinerja yang tidak optimal menyebabkan kualitas asuhan keperawatan menjadi menurun, efektivitas pelayanan berkurang, serta kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan ikut mengalami penurunan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memengaruhi kerja sama tim keperawatan karena kurangnya koordinasi, komunikasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan. Oleh sebab itu, pelaksanaan supervisi klinis yang efektif, terarah, dan berkesinambungan menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu.

4. Belum Optimalnya Pengembangan Profesional

Dampak lain dari hambatan supervisi klinis adalah belum optimalnya pengembangan profesional perawat. Supervisi klinis seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi perawat melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan. Namun, ketika supervisi tidak berjalan dengan baik, kesempatan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas menjadi terbatas. Perawat yang tidak mendapatkan supervisi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan komunikasi profesional. Selain itu, kurangnya umpan balik juga menghambat proses refleksi diri yang penting dalam pengembangan profesional. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi dalam perkembangan karier perawat serta menurunkan kualitas sumber daya manusia keperawatan secara keseluruhan. Dengan demikian, supervisi klinis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan profesional perawat. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam supervisi klinis perlu dilakukan secara sistematis agar perawat dapat terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas tinggi serta berorientasi pada keselamatan pasien.

F. Strategi Mengatasi Hambatan Supervisi Klinis

Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Strategi yang dikembangkan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang bersumber dari aspek sumber daya manusia, manajerial, lingkungan kerja, maupun sistem organisasi. Dalam konteks manajemen keperawatan modern, supervisi klinis tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peningkatan mutu yang berorientasi pada keselamatan pasien dan pengembangan profesional perawat. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan harus bersifat integratif, melibatkan seluruh komponen organisasi, serta didukung oleh kebijakan yang kuat dan implementasi yang konsisten.

1. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Supervisor

Penguatan kapasitas dan kompetensi supervisor merupakan langkah fundamental dalam meningkatkan efektivitas supervisi klinis di lingkungan pelayanan keperawatan. Supervisor memiliki peran sentral sebagai pengarah, pembina, pengawas, sekaligus fasilitator dalam proses peningkatan mutu

praktik keperawatan. Dalam tatanan pelayanan kesehatan, posisi supervisor umumnya diemban oleh kepala ruangan, ketua tim, clinical instructor, atau perawat senior yang memiliki pengalaman dan tanggung jawab dalam mengoordinasikan pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, seorang supervisor dituntut tidak hanya memiliki pengalaman kerja yang memadai, tetapi juga harus memiliki kompetensi profesional yang komprehensif agar mampu menjalankan fungsi supervisi secara optimal.

Kompetensi supervisor mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, meliputi kompetensi klinis, manajerial, edukatif, komunikasi interpersonal, serta kemampuan kepemimpinan. Kompetensi klinis diperlukan agar supervisor mampu memahami standar praktik keperawatan, mengevaluasi ketepatan tindakan klinis, serta memberikan arahan yang sesuai dengan kondisi pasien dan perkembangan ilmu pengetahuan. Supervisor yang memiliki kompetensi klinis yang baik akan lebih mudah mengidentifikasi kesalahan praktik, memberikan solusi terhadap masalah pelayanan, dan membimbing perawat dalam pengambilan keputusan klinis yang tepat.

Selain kompetensi klinis, kemampuan manajerial juga menjadi komponen penting dalam pelaksanaan supervisi klinis. Supervisor harus mampu merencanakan kegiatan supervisi, mengatur pembagian tugas, mengelola sumber daya, melakukan monitoring pelayanan, serta mengevaluasi kinerja perawat secara sistematis. Kemampuan manajemen yang baik akan membantu supervisor menciptakan lingkungan kerja yang terorganisasi, kondusif, dan mendukung peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Dalam praktiknya, supervisor juga harus mampu menyusun prioritas pelayanan, mengelola waktu secara efektif, dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam situasi pelayanan yang dinamis.

Kemampuan komunikasi interpersonal merupakan aspek lain yang tidak kalah penting dalam menunjang keberhasilan supervisi klinis. Supervisor perlu memiliki keterampilan komunikasi yang efektif agar mampu membangun hubungan profesional yang harmonis dengan staf keperawatan. Komunikasi yang baik memungkinkan supervisor memberikan arahan, motivasi, kritik, maupun umpan balik secara konstruktif tanpa menimbulkan rasa takut atau tekanan pada perawat pelaksana. Umpan balik yang diberikan secara tepat, jelas, dan objektif akan membantu perawat memahami kekurangan serta meningkatkan kemampuan praktiknya secara berkelanjutan. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik kerja, bahkan penurunan motivasi staf dalam menjalankan tugas pelayanan.

Dalam pelaksanaan supervisi klinis, supervisor juga dituntut memiliki kemampuan observasi dan evaluasi yang objektif. Supervisor harus mampu melakukan pengamatan terhadap praktik keperawatan secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis tindakan, penerapan standar prosedur operasional, komunikasi terapeutik, hingga kualitas dokumentasi keperawatan. Hasil observasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam memberikan pembinaan dan tindak lanjut perbaikan pelayanan. Oleh karena itu, supervisor harus memiliki sikap profesional, adil, tidak diskriminatif, serta mampu menjaga etika dalam proses supervisi.

Upaya penguatan kapasitas supervisor dapat dilakukan melalui berbagai strategi pengembangan sumber daya manusia yang terencana dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling penting adalah penyelenggaraan pelatihan supervisi klinis secara terstruktur dan berbasis kebutuhan pelayanan. Pelatihan tersebut dapat mencakup materi tentang teknik supervisi efektif, kepemimpinan keperawatan, komunikasi interpersonal, manajemen konflik, coaching dan mentoring, patient safety, audit keperawatan, serta pengambilan keputusan klinis. Pelatihan yang dilakukan secara berkala akan membantu supervisor memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai perkembangan praktik keperawatan modern.

Selain pelatihan formal, organisasi pelayanan kesehatan juga perlu mendorong pengembangan profesional berkelanjutan melalui seminar, workshop, diskusi ilmiah, studi kasus, maupun program pendidikan lanjutan. Pengembangan kompetensi ini penting untuk meningkatkan kemampuan supervisor dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Organisasi juga dapat menerapkan program mentoring antar supervisor senior dan junior sebagai sarana transfer pengalaman, peningkatan keterampilan kepemimpinan, serta penguatan budaya supervisi yang profesional.

Secara aplikatif, penguatan kapasitas supervisor dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata di lingkungan pelayanan keperawatan. Misalnya, rumah sakit dapat menyusun program orientasi khusus bagi kepala ruangan baru terkait pelaksanaan supervisi klinis, menyediakan jadwal supervisi rutin yang terstandar, mengadakan evaluasi berkala terhadap efektivitas supervisi, serta memberikan pelatihan komunikasi terapeutik dan manajemen konflik bagi supervisor. Selain itu, institusi pelayanan kesehatan juga dapat membentuk sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai kualitas supervisi yang dilakukan oleh setiap kepala ruangan sehingga proses pembinaan staf dapat berlangsung secara lebih optimal.

Penguatan kompetensi supervisor pada akhirnya tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kemampuan individu supervisor, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan keperawatan secara keseluruhan. Supervisor yang kompeten akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang suportif, meningkatkan motivasi staf, memperkuat kepatuhan terhadap standar praktik, serta mendorong budaya keselamatan pasien di unit pelayanan. Dengan demikian, proses supervisi klinis dapat berjalan secara lebih efektif, sistematis, terarah, dan berkesinambungan sehingga mampu mendukung terciptanya pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi, aman, dan professional

2. Optimalisasi Manajemen Keperawatan

Optimalisasi manajemen keperawatan menjadi strategi penting dalam mendukung pelaksanaan supervisi klinis yang efektif. Manajemen keperawatan yang baik harus mampu mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian secara optimal. Dalam konteks supervisi klinis, manajemen keperawatan berperan dalam memastikan bahwa kegiatan supervisi direncanakan secara sistematis, dilaksanakan sesuai dengan standar, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Penyusunan kebijakan yang jelas dan operasional terkait supervisi klinis menjadi bagian penting dalam optimalisasi manajemen. Kebijakan tersebut harus mencakup pedoman pelaksanaan supervisi, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan. Selain itu, dukungan manajemen dalam bentuk penyediaan sumber daya, alokasi waktu, serta fasilitas pendukung juga sangat diperlukan. Dengan manajemen keperawatan yang terstruktur dan terintegrasi, supervisi klinis dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan.

Secara aplikatif, optimalisasi manajemen keperawatan dapat diwujudkan melalui berbagai langkah nyata di lingkungan pelayanan kesehatan. Contohnya adalah penyusunan jadwal supervisi rutin di setiap unit pelayanan, pelaksanaan briefing dan evaluasi harian, pengembangan indikator mutu keperawatan, penerapan audit dokumentasi keperawatan, serta pelaksanaan rapat evaluasi supervisi secara berkala. Selain itu, manajemen juga dapat mengembangkan sistem penghargaan bagi unit yang berhasil melaksanakan supervisi secara efektif sebagai bentuk motivasi peningkatan mutu pelayanan. Dengan demikian, optimalisasi manajemen keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan sistem supervisi klinis yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Manajemen yang baik akan membantu memastikan bahwa supervisi klinis tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar

berfungsi sebagai sarana pembinaan profesional untuk meningkatkan kompetensi perawat, menjaga mutu pelayanan, serta memperkuat keselamatan pasien. Oleh sebab itu, integrasi fungsi manajemen keperawatan dengan pelaksanaan supervisi klinis perlu terus dikembangkan agar pelayanan keperawatan dapat berlangsung secara optimal, profesional, dan berorientasi pada mutu pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan Efektivitas Komunikasi Tim

Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan supervisi klinis. Interaksi antara supervisor dan perawat pelaksana harus berlangsung secara terbuka, jelas, dan saling menghargai. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas komunikasi tim menjadi strategi yang sangat penting dalam mengatasi hambatan supervisi klinis. Upaya peningkatan komunikasi dapat dilakukan melalui pelatihan komunikasi interpersonal, penerapan teknik komunikasi terapeutik, serta penggunaan metode komunikasi yang terstruktur, seperti briefing dan debriefing. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung komunikasi dua arah, di mana perawat merasa aman untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, maupun kesulitan yang dihadapi. Pemberian umpan balik yang konstruktif, spesifik, dan tepat waktu juga merupakan bagian penting dalam komunikasi supervisi yang efektif. Sebagai contoh aplikatif, kepala ruangan dapat melaksanakan briefing singkat setiap pergantian shift selama 10–15 menit. Dalam kegiatan tersebut, supervisor menyampaikan kondisi pasien prioritas, risiko keselamatan pasien, pembagian tanggung jawab, serta target pelayanan yang harus dicapai pada shift tersebut. Perawat pelaksana juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kendala maupun kebutuhan bantuan selama bertugas. Setelah pelayanan selesai, supervisor dapat melakukan debriefing untuk membahas tindakan yang telah dilakukan, mengevaluasi kesalahan yang mungkin terjadi, serta memberikan umpan balik terhadap kinerja staf secara konstruktif.

Contoh aplikatif lainnya dapat ditemukan dalam pelaksanaan supervisi tindakan keperawatan. Misalnya, ketika seorang perawat melakukan pemasangan infus namun masih kurang tepat dalam menjaga prinsip sterilitas, supervisor tidak langsung memberikan kritik secara menyalahkan di depan pasien atau rekan kerja lainnya. Sebaliknya, supervisor dapat memberikan umpan balik secara profesional dengan pendekatan edukatif, seperti menjelaskan kembali prosedur yang benar, menunjukkan teknik yang tepat, serta memberikan motivasi agar perawat lebih teliti dalam pelaksanaan tindakan.

berikutnya. Pendekatan komunikasi seperti ini akan membantu meningkatkan kemampuan staf tanpa menurunkan rasa percaya diri perawat.

Penerapan komunikasi dua arah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan supervisi klinis yang efektif. Lingkungan kerja harus mampu memberikan rasa aman bagi perawat untuk menyampaikan ide, pertanyaan, maupun kesalahan yang terjadi tanpa rasa takut mendapatkan hukuman atau stigma negatif. Budaya komunikasi terbuka akan meningkatkan kepercayaan antar anggota tim serta membantu organisasi mengidentifikasi masalah pelayanan secara lebih cepat. Dalam konteks ini, supervisor memiliki peran penting dalam membangun budaya kerja yang suportif, kolaboratif, dan menghargai setiap anggota tim.

Selain itu, pemberian umpan balik yang konstruktif, spesifik, objektif, dan tepat waktu merupakan bagian integral dari komunikasi supervisi klinis. Umpan balik yang baik tidak hanya berfokus pada kesalahan, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap kinerja positif yang telah dilakukan oleh staf. Misalnya, supervisor dapat memberikan penghargaan verbal kepada perawat yang mampu melakukan edukasi pasien dengan baik atau mendokumentasikan asuhan keperawatan secara lengkap dan tepat waktu. Bentuk apresiasi sederhana seperti ini dapat meningkatkan motivasi kerja dan mendorong perawat untuk mempertahankan kualitas pelayanan. Dengan komunikasi yang baik, proses supervisi klinis dapat berjalan lebih lancar dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perawat.

4. Penyesuaian Beban Kerja dan Distribusi SDM

Penyesuaian beban kerja dan distribusi sumber daya manusia merupakan strategi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan supervisi klinis yang optimal. Beban kerja yang tinggi dan tidak seimbang sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan supervisi, karena perawat dan supervisor memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan pembinaan secara mendalam. Manajemen keperawatan perlu melakukan analisis beban kerja secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tenaga perawat sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Selain itu, distribusi tugas harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman perawat. Penjadwalan kerja yang fleksibel dan efisien juga dapat membantu menyediakan waktu khusus untuk pelaksanaan supervisi klinis. Dengan beban kerja yang terkelola dengan baik, perawat dan supervisor dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, termasuk dalam melakukan supervisi klinis yang berkualitas.

5. Penguatan Budaya Organisasi dan *Patient Safety*

Budaya organisasi yang mendukung merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan supervisi klinis. Organisasi perlu membangun budaya kerja yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, serta pembelajaran berkelanjutan. Budaya tersebut harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, keterbukaan, dan kolaborasi antar anggota tim keperawatan. Penguatan budaya keselamatan pasien (*patient safety*) juga menjadi bagian integral dari strategi ini. Setiap perawat harus memiliki kesadaran dan komitmen untuk menjaga keselamatan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan. Supervisi klinis dapat digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai keselamatan pasien melalui pembinaan, edukasi, dan evaluasi praktik keperawatan. Selain itu, organisasi pelayanan kesehatan juga perlu mendorong terbentuknya budaya pelaporan insiden secara terbuka tanpa rasa takut terhadap sanksi yang bersifat menghukum. Budaya pelaporan yang terbuka memungkinkan setiap kejadian yang tidak diharapkan dapat dilaporkan secara jujur dan segera ditindaklanjuti. Informasi tersebut sangat penting untuk melakukan analisis akar masalah serta perbaikan sistem pelayanan secara menyeluruh. Dengan adanya sistem pelaporan yang tidak menyalahkan individu, organisasi dapat lebih fokus pada perbaikan sistem sehingga risiko kejadian serupa dapat diminimalkan di masa yang akan datang sehingga dapat dilakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan.

6. Pemanfaatan Evaluasi dan Audit Keperawatan

Evaluasi dan audit keperawatan merupakan komponen penting dalam sistem manajemen keperawatan yang berfungsi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan supervisi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dari aspek proses maupun hasil. Sedangkan audit keperawatan merupakan kegiatan penilaian yang lebih terstruktur untuk mengkaji kualitas praktik keperawatan berdasarkan standar prosedur operasional, pedoman klinis, serta prinsip keselamatan pasien yang berlaku. Kedua mekanisme ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilaksanakan secara profesional, aman, dan sesuai standar. Pemanfaatan hasil evaluasi dan audit dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan supervisi klinis. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan perbaikan dan pengembangan sistem supervisi. Selain itu, audit keperawatan juga dapat meningkatkan akuntabilitas profesional perawat

serta mendorong kepatuhan terhadap standar praktik. Agar efektif, evaluasi dan audit harus dilakukan secara berkala, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Hasilnya perlu disampaikan kepada seluruh pihak terkait sebagai bahan refleksi dan pembelajaran bersama. Dengan memanfaatkan evaluasi dan audit secara optimal, supervisi klinis dapat terus ditingkatkan kualitasnya dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan di ruang rawat inap.

G. Simpulan

Permasalahan dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap meliputi keterbatasan jumlah tenaga perawat, variasi kompetensi perawat dan supervisor, serta tingginya beban kerja yang berdampak pada tidak optimalnya proses pembinaan. Pelaksanaan supervisi klinis yang belum terstruktur dan kurangnya dukungan manajemen menyebabkan kegiatan supervisi sering kali tidak berjalan secara konsisten. Hambatan tersebut juga diperburuk oleh kondisi lingkungan kerja yang dinamis, komunikasi interpersonal yang kurang efektif, serta budaya kerja yang belum sepenuhnya terbuka terhadap umpan balik dan pembelajaran. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan standar operasional prosedur serta minimnya dokumentasi dan evaluasi turut memengaruhi kualitas pelaksanaan supervisi klinis.

Kompleksitas hambatan dalam supervisi klinis tersebut berdampak pada penurunan mutu asuhan keperawatan, peningkatan risiko keselamatan pasien, penurunan kinerja perawat, serta tidak optimalnya pengembangan profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa supervisi klinis belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Oleh karena itu, identifikasi dan pemahaman terhadap berbagai hambatan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan strategi perbaikan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Memperkuat kapasitas dan kompetensi supervisor melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan; 2) Mengoptimalkan sistem manajemen keperawatan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi supervisi yang terstruktur; 3) Meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerja sama tim dalam pelaksanaan supervisi klinis; 4) Menyesuaikan beban kerja dan distribusi sumber daya manusia secara proporsional; 5) Mengembangkan budaya organisasi yang mendukung keselamatan pasien dan pembelajaran berkelanjutan; 6)

Memfaatkan evaluasi dan audit keperawatan sebagai dasar dalam peningkatan mutu pelayanan secara efektif.

H. Referensi

- Fazrinnor, F., Pertiwiwati, E., & Rizany, I. (2019). Pelaksanaan supervisi oleh supervisor dengan penerapan *patient safety*. *Nerspedia*, 1(1), 83–92
- Hadi, M., Turyatiningsih, T., Arofiati, F., Efendi, F., & Nursalam. (2020). Nursing supervision model toward patient safety goals on the ward. *Journal of Global Pharma Technology*, 12(1), 287–292
- Miho, T., Yamaguchi, F., Shimamoto, K., Nitta, S., Ohkawa, Y., & Yoshinaga, N. (2025). Association between teaching days of clinical nurse instructors and student-perceived practicum quality in adult nursing at a university hospital: A cross-sectional study. *Journal of International Nursing Research*, 1–7. <https://doi.org/10.53044/jinr.2025-0002>
- Muawanah, M., Purnomo, H., Sofyan, K., Uripno, P. S., & Normawati, A. T. (2021). Penerapan supervisi model klinis terhadap pencapaian budaya keselamatan pasien di rumah sakit. *Jurnal Studi Keperawatan*, 3(1). <https://doi.org/10.31983/j-sikep.v3i1.8362>
- Nela. Ari Sukma Indonesia, L. E. (n.d.). *MEMBANGUN KEPUASAN KERJA PERAWAT MELALUI IMPLEMENTASI METODE TIM YANG EFEKTIF*.
- Nela, A. S. (n.d.). *Konsep dan Praktik Manajemen keperawatan*.
- Nela, A. S. (2025). Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan. In *Lingkar Edukasi Indonesia*.
- Nursalam. (2015). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (Ed. 5). Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2014). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional* (Ed. 4). Jakarta: Salemba Medika
- Valdez, G. F. D., Nashwan, A. J., Inocian, E. P., Cayaban, A. R. R., Turingan, O. M., & Nasiri, Y. Al. (2026). Influence of clinical learning environment on caring and advocacy among Omani undergraduate nursing students: a cross-sectional survey. *Jurnal Ners*, 21(1), 103–112. <https://doi.org/10.20473/jn.v21i1.78493>
- Wati, N. N. M., Prihatiningsih, D., & Haryani, N. N. P. (2018). Hubungan supervisi keperawatan dengan pelaksanaan budaya safety. *Adi Husada Nursing Journal*, 4(2), 56–61

I. Glosarium

SPO = Standar Prosedur Operasional

CHAPTER 5

STRATEGI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KEPATUHAN DOKUMENTASI PERAWAT

Armidayanti, S.Kep., Ners., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kondisi globalisasi dan transformasi digital saat ini melonjat pesat, sehingga menciptakan lingkungan kesehatan yang semakin kompleks dan kompetitif, hal ini mendorong organisasi agar dapat terus beradaptasi, bertahan dan berkembang. Dalam situasi ini, sumber daya manusia menjadi salah satu aset strategis yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kompetensi dan tenaga kesehatan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Sebagaimana dengan survei global yang dilakukan oleh Deloitte pada tahun 2023 bahwa dalam peningkatan kompetensi dipengaruhi oleh karyawan untuk keberlangsungan organisasi (Septiani et al., 2024).

Pencapaian mutu dan layanan yang baik dan berkualitas diperlukan individu atau organisasi kesehatan yang mampu memperoleh tenaga kesehatan profesional sehingga efektifitas manajemen organisasi berkualitas. Metode yang dapat mengembangkan profesionalisme dan kinerja baik dapat melalui pembimbingan, yang juga menjadi bagian dari upaya pemenuhan fungsi manajemen (Rumerung et al., 2022).

Dokumentasi asuhan keperawatan adalah komponen esensial dalam dunia praktik keperawatan yang profesional, mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi sesama profesional kesehatan dan alat bukti legal dari setiap tindakan keperawatan. Dokumentasi keperawatan juga sebagai suatu sistem pusat informasi mengenai riwayat kesehatan, kondisi kesehatan dan rencana asuhan keperawatan pasien atau semua kegiatan asuhan keperawatan yang menggunakan pendekatan proses keperawatan, yaitu mulai dari pengkajian, menentukan diagnosis, intervensi, implemementasi dan evaluasi. Dokumentasi perawat dapat dilihat dalam catatan tindakan asuhan keperawatan (Yuwanto & Prasetyo, 2023).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 pada pasal 16 menyatakan bahwa perawat memegang peranan penting dalam implementasi perawatan pasien. Peran tersebut mencakup berbagai fungsi, seperti

menjadi edukator, administrator layanan, penasihat, pemberi kenyamanan, dan peneliti, serta pelaksana tugas berdasarkan delegasi wewenang yang diberikan. Lebih lanjut, pasal 34 dalam peraturan kesehatan yang sama mewajibkan perawat untuk melakukan dokumentasi dan pelestarian data praktik keperawatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seluruh proses dokumentasi harus dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

B. Strategi Peningkatan Kompetensi

1. Pelatihan

Kualifikasi para profesional di bidang kesehatan menjadi faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan penyediaan layanan kesehatan. Kualifikasi ini meliputi keahlian teknis, pemanfaatan teknologi, serta kapasitas interpersonal, yang kesemuanya berkontribusi terhadap mutu layanan medis. Salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kualifikasi adalah melalui program pengembangan profesional yang teratur, sebab pendidikan berkelanjutan dapat mengasah kapabilitas dan menumbuhkan keyakinan diri para praktisi kesehatan (Madu et al., 2025).

Beragam studi mengindikasikan bahwa peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di sektor kesehatan, melalui program pelatihan yang berfokus pada aplikasi praktis dan supervisi di lapangan, berkontribusi pada peningkatan standar layanan dan tingkat kepuasan pasien (Wulandari & Nuraini, 2023). Metode pelatihan menggunakan simulasi, permainan peran (role-play), dan penilaian langsung di lingkungan kerja terbukti efektif dalam mengembangkan kompetensi praktis serta kemampuan komunikasi antarpribadi bagi para profesional kesehatan (Arifin et al., 2021). Terdapat bukti empiris yang menunjukkan bahwa permainan peran dapat mengoptimalkan keterampilan komunikasi terapeutik antara 22% hingga 50% (Fitriani & Santosa, 2021).

Berdasarkan penelitian oleh (Yasma et al., 2024), alokasi sumber daya untuk peningkatan kapasitas individu melalui program pelatihan yang terencana menunjukkan hubungan yang searah dengan efisiensi operasional perusahaan serta keunggulan kompetitif yang bertahan lama. Kesimpulan menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan perilaku humanistik perawat berkorelasi positif dengan peningkatan kompetensi perawatan mereka. Keterampilan perilaku humanistik perawat memberikan kontribusi sebesar 8,2% terhadap kompetensi perawatan. Faktor-faktor lain seperti usia, jenis kelamin, jam kerja lembur, dan lama masa kerja juga teridentifikasi memiliki pengaruh terhadap kompetensi perawatan

Walaupun signifikansi manajemen pengembangan kompetensi telah diterima secara umum, penerapannya di dalam institusi masih dihadapkan pada bermacam-macam hambatan. Salah satu kendala fundamental adalah kesukaran dalam mengukur keberhasilan rancangan pengembangan kompetensi dan mengaitkannya dengan peningkatan efisiensi kerja yang nyata. Analisis terdahulu cenderung menyoroti penilaian pengembangan kompetensi memakai kerangka Kirkpatrick yang mengevaluasi respons, perolehan pengetahuan, alterasi tingkah laku, dan luaran, tetapi acapkali luput dalam menangkap pengaruh jangka panjang terhadap efektivitas institusi.

Terdapat kesenjangan penelitian yang teridentifikasi berkaitan dengan minimnya penelusuran mendalam mengenai cara menyelaraskan strategi pelatihan dengan tuntutan spesifik organisasi dan atribut individual karyawan. Sebagian besar cenderung menerapkan metode pelatihan yang bersifat umum, dengan mengabaikan karakteristik unik dari setiap organisasi serta variasi dalam atribut dan kebutuhan belajar karyawan yang dapat berdampak pada efektivitas program peningkatan kompetensi. Selanjutnya, masih terdapat celah mengenai bagaimana elemen-elemen organisasi, termasuk budaya yang mendukung pembelajaran, dukungan dari pihak manajemen, serta skema penghargaan, berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi dan hasil kerja karyawan (Fariz et al., 2025).

2. Pembinaan berbasis mentoring

Kompetensi perawat menjadi faktor utama dalam menentukan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit, khususnya bagi perawat yang berinteraksi langsung dengan pasien dalam pemberian asuhan keperawatan sehari-hari. Kualitas pelayanan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berhubungan dengan pasien. Kompleksitas pelayanan kesehatan yang terus berkembang menuntut perawat memiliki kompetensi klinis, pengetahuan, serta sikap profesional yang memadai.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perawat memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien (Mikkonen et al., 2020). Sebaliknya, keterbatasan kompetensi dan rendahnya rasa percaya diri perawat di lingkungan rumah sakit dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan pelayanan serta menurunkan kepuasan pasien. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan kompetensi yang terencana dan berkelanjutan (Tomas & Kamati, 2024). Hasil berbagai penelitian tersebut secara konsisten menegaskan bahwa kurangnya

kompetensi dan kepercayaan diri perawat berpengaruh langsung terhadap meningkatnya risiko insiden keselamatan pasien.

Salah satu pendekatan yang dinilai efektif dalam mendukung pengembangan kompetensi perawat adalah penerapan strategi pembinaan berbasis mentoring. Melalui mentoring, proses pembelajaran berkelanjutan dapat berlangsung secara lebih terarah melalui bimbingan sistematis antara perawat senior dan perawat junior. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai profesional secara kontekstual dalam praktik pelayanan keperawatan (Wahyuningtyas, 2025).

Penerapan mentoring berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi klinis, pengetahuan profesional, dan rasa percaya diri perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Meskipun demikian, bukti empiris terkait efektivitas model mentoring yang terstruktur dan terintegrasi, khususnya pada konteks rumah sakit daerah di Indonesia, masih relatif terbatas. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa pembinaan yang dilakukan secara terstruktur memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi klinis perawat, meskipun penelitian tersebut belum mengkaji hubungan langsung antara model mentoring dengan peningkatan kompetensi pada konteks spesifik rumah sakit (Oka et al., 2023). Penelitian lain melaporkan bahwa efektivitas sistem mentoring mencapai lebih dari 76% dalam meningkatkan kualitas perawat di rumah sakit (Kellett et al., 2024). Selain itu, studi sebelumnya juga menegaskan bahwa mentoring memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas pelayanan perawat yang berdampak pada optimalisasi mutu pelayanan rumah sakit serta percepatan proses kesembuhan pasien (Kielo- Viljamaa et al., 2022).

Program mentoring berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri perawat dalam memahami praktik klinik yang kompleks serta memperkuat budaya pembelajaran klinis yang berkelanjutan (Tomas & Kamati, 2024). Selain itu mentoring juga menjadi salah satu metode pembimbingan yang dapat digunakan untuk membantu individu mencapai keberhasilan dan tujuan melalui proses pengembangan diri.

Mentoring membantu seseorang mengembangkan potensi dan bakat yang dimilikinya sehingga mampu mencapai tujuan pribadi, tim, maupun organisasi. Satu institusi yang berfokus pada pelatihan mentoring mengemukakan bahwa individu yang mengikuti proses mentoring cenderung lebih mampu mengenali potensi, kelebihan, dan kekuatan dirinya. Selain itu, individu tersebut dilaporkan enam kali lebih terikat dengan pekerjaannya dibandingkan mereka yang tidak mengikuti mentoring. Dalam praktiknya,

pembimbingan dengan pendekatan mentoring juga dapat mendukung pencapaian fungsi manajemen, khususnya fungsi pengarahan (actuating) dan pengendalian (controlling).

3. Penerapan standar 3s

Standar asuhan keperawatan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan proses keperawatan yang tepat guna membantu klien mencapai kondisi kesehatan yang optimal. Salah satu standar keperawatan yang digunakan dalam penyusunan dan pendokumentasian asuhan keperawatan adalah konsep 3S yang meliputi SDKI, SIKI, dan SLKI (Wisuda & Suraya, 2024).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di Indonesia, telah ditetapkan standar keperawatan nasional yang mencakup Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) yang dikenal sebagai konsep 3S. Implementasi konsep 3S bertujuan untuk menyelaraskan bahasa keperawatan, meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan klinis, serta menjamin keberlanjutan asuhan keperawatan yang sesuai dengan bukti ilmiah dan standar profesi (Rendana et al., 2023). Penerapan SDKI, SLKI, dan SIKI juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat profesionalisme perawat melalui penggunaan standar yang terintegrasi. Namun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan 3S masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman perawat, kebiasaan menggunakan sistem dokumentasi lama, serta tingginya beban kerja yang dihadapi tenaga keperawatan (Sindi et al., 2024).

Selain itu, masih banyak perawat yang terbiasa menggunakan standar dokumentasi lama seperti NANDA, NOC, dan NIC sehingga mengalami kesulitan maupun resistensi dalam beradaptasi dengan standar baru. Kondisi ini menjadi tantangan dalam penerapan konsep 3S secara efektif. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan berdasarkan standar terbaru dapat menyebabkan kualitas asuhan yang diberikan belum optimal serta menghambat upaya evaluasi dan pengembangan praktik keperawatan berbasis bukti. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar seluruh perawat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan 3S secara tepat dalam praktik keperawatan dengan harapan dengan berjalannya strategi tersebut maka dapat meningkatkan kompetensi dalam pelayanan kesehatan (Wisuda & Suraya, 2024).

C. Strategi Kepatuhan Dokumentasi Perawat

1. Audit dan *Feedback* Berkala

Dokumentasi merupakan bukti tertulis dari kegiatan pencatatan atau pelaporan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dalam proses keperawatan. Dokumentasi ini memiliki manfaat penting bagi klien, perawat, maupun mitra kerja lainnya (Lufianti & Keristiyani, 2023). Proses dokumentasi diawali dengan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung maupun tidak langsung atau menggunakan kuesioner. Selanjutnya, data dicatat dan dikelompokkan sesuai kategori tertentu, kemudian diinput berdasarkan jenisnya. Tahap berikutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dengan memperhatikan temuan yang ada, menarik kesimpulan, serta menyusun rencana tindakan yang akan dilaksanakan. Setelah rencana diterapkan, dilakukan evaluasi dan pemberian umpan balik guna menyempurnakan hasil yang dicapai. Dalam pelaksanaannya, perawat masih memerlukan pelatihan lanjutan agar mampu mendokumentasikan asuhan pasien sesuai dengan proses keperawatan serta menggunakan format pelaporan yang terstandar (Shafiee et al., 2022).

Pada aspek dokumentasi keperawatan, penelitian sistematis yang dilakukan oleh (Bunting, 2022) menunjukkan bahwa berbagai intervensi, seperti pelatihan singkat, audit, dan pemberian umpan balik secara personal, terbukti mampu meningkatkan kepatuhan dokumentasi hingga lebih dari 70%. Selain itu, melalui program ward-based writing coach melaporkan adanya peningkatan yang signifikan pada kualitas isi dokumentasi, kelengkapan, serta kejelasan pencatatan setelah dilakukan pendampingan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, di mana perawat menjadi lebih memahami dan terampil dalam melakukan dokumentasi sesuai standar yang berlaku (Jefferies, 2022).

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu perawat diharapkan mampu mempertahankan serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam praktik sehari-hari sehingga dokumentasi keperawatan dapat dilakukan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Selain itu, pihak manajemen rumah sakit diharapkan dapat menyusun kebijakan internal terkait standar dokumentasi, menyediakan format dokumentasi yang mudah digunakan, serta melaksanakan supervisi dan audit secara berkala (Kusumaningrum et al., 2025).

2. Optimalisasi Sistem Digital

Seiring berkembangnya teknologi informasi di bidang kesehatan, berbagai rumah sakit mulai menerapkan Electronic Documentation (E-Documentation)

atau dokumentasi keperawatan berbasis elektronik sebagai inovasi dalam sistem pencatatan asuhan keperawatan. Penerapan sistem ini sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Rekam medis memiliki fungsi sebagai bukti pelaksanaan tindakan keperawatan melalui proses pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang akurat dan benar, sehingga dapat mendukung terciptanya sistem informasi rumah sakit yang andal. Kebijakan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan, khususnya pada aspek asuhan keperawatan (Sari et al., 2024).

Sistem informasi berbasis elektronik atau electronic documentation memberikan berbagai manfaat, seperti memudahkan proses pengumpulan data, menyajikan informasi yang lebih terstruktur dan lengkap, mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien (Maryati, 2021). Penerapan sistem ini juga memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya mempercepat proses pencatatan, meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan input, serta mempermudah tenaga kesehatan dalam mengakses data pasien secara real-time. Selain itu, E-Documentation memungkinkan proses dokumentasi dilakukan secara digital melalui sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi (Wulandari et al., 2022).

Sistem digital merupakan sarana yang membantu perawat dalam mencatat, mengakses, serta menganalisis data pasien secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini mendukung proses pengambilan keputusan klinis dengan menyediakan data yang relevan, akurat, dan terkini. Selain itu, Electronic Health Record (EHR) juga memfasilitasi komunikasi antarprofesi dalam tim kesehatan sehingga koordinasi pelayanan dapat berjalan lebih optimal. Sistem dokumentasi elektronik adalah metode pencatatan informasi pasien yang dilakukan menggunakan perangkat digital dan disimpan dalam basis data elektronik, seperti SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) atau EHR. Sistem ini menggantikan pencatatan manual dengan platform digital yang terintegrasi sehingga proses dokumentasi menjadi lebih praktis dan sistematis.

Penerapan sistem dokumentasi elektronik memiliki berbagai keunggulan. Sistem ini mampu meningkatkan akurasi data serta mempercepat akses informasi sehingga pencarian data dapat dilakukan dengan mudah dan kesalahan penulisan dapat diminimalkan. Selain itu, dokumentasi elektronik mempermudah proses pelaporan, analisis, dan evaluasi mutu karena data dapat ditarik secara otomatis untuk kebutuhan laporan bulanan maupun akreditasi. Sistem ini juga mendukung kolaborasi antarprofesi, di mana dokter, perawat, farmasis, dan tenaga laboratorium dapat mengakses serta memperbarui data

pasien yang sama secara bersamaan. Di samping itu, keamanan dan keterlacakan data menjadi lebih terjamin karena sistem memiliki fitur log yang dapat mencatat siapa saja yang mengakses maupun mengubah data sehingga mendukung proses audit digital. Terdapat aspek hukum dan etika dalam dokumentasi elektronik, yaitu:

a. Perlindungan data pribadi pasien

Mengacu pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan data pribadi, setiap fasilitas atau institusi kesehatan berkewajiban menjaga kerahasiaan data pasien agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

b. Hak akses terhadap informasi pasien

Pasien berhak memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, namun akses pengguna dalam sistem tetap harus dibatasi sesuai kewenangan masing-masing.

c. Pengaturan hak akses pengguna system

Sistem perlu menerapkan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, misalnya hanya dokter yang memiliki wewenang untuk mengubah data diagnosis pasien.

d. Tanda tangan elektronik dan kekuatan hukum

Penggunaan tanda tangan elektronik harus memakai sistem digital yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar sah dan memiliki kekuatan hukum.

3. Reward

Pemberian reward merupakan salah satu upaya organisasi dalam mempertahankan sumber daya manusia. Reward tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif, efisien, dan inovatif dalam menjalankan pekerjaannya. Pemberian reward oleh organisasi mampu memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Selain itu, ketika karyawan merasa puas terhadap penghargaan yang diterima serta mampu mengidentifikasi dirinya dengan organisasi, maka hal tersebut akan semakin memperkuat kinerja mereka dalam organisasi. (Arika et al., 2021).

Dokumentasi keperawatan merupakan media komunikasi yang efektif karena memuat catatan dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pemberian asuhan keperawatan. Namun, di berbagai rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, kelengkapan dokumentasi keperawatan masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian khusus. Menurut (Wahyuliati & Novita, 2023) terdapat beberapa faktor yang

memengaruhi dokumentasi keperawatan, antara lain sikap, pelatihan, rasio perawat dan pasien, motivasi, pengetahuan perawat, serta ketersediaan standar operasional.

Selain itu, dokumentasi yang belum optimal juga dapat disebabkan oleh tingginya beban tugas non-keperawatan yang harus dilakukan perawat, penggunaan sistem dokumentasi manual, belum adanya standar dalam pendokumentasian catatan perkembangan pasien, serta kurangnya pemberian penghargaan (reward). Meskipun dokumentasi keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, pada kenyataannya masih banyak catatan keperawatan yang belum disusun secara lengkap dan sistematis. Salah satu faktor yang memengaruhi kelengkapan dokumentasi tersebut adalah motivasi perawat dalam melaksanakan (Lufianti & Keristiyani, 2023).

Adanya reward kepada tenaga kesehatan diharapkan proses kelengkapan pendokumentasian dapat berjalan optimal, sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian reward nonfinansial dengan kinerja perawat di Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil Pasuruan. Pemberian reward yang baik dapat memberikan dampak positif bagi rumah sakit. Apabila penghargaan diberikan secara tepat, maka perawat akan bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan sehingga mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik (Arika et al., 2021).

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja meliputi kemampuan, tingkat motivasi, dan penghargaan (reward). Reward sendiri dibagi menjadi tiga jenis, yaitu reward finansial, reward nonfinansial, dan reward sosial. Reward finansial dapat berupa uang maupun barang, sedangkan reward nonfinansial dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, piala, medali, dan bentuk apresiasi lain yang memiliki nilai tersendiri. Adapun reward sosial diberikan dalam bentuk kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, seperti promosi jabatan, mengikuti pendidikan atau pelatihan, menunaikan ibadah haji, dan bentuk pengembangan diri lainnya.

Kinerja perawat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor individu, faktor psikologis, dan faktor organisasi. Faktor psikologis meliputi persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, serta kepuasan kerja, sedangkan faktor organisasi mencakup struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, dan sistem penghargaan (reward system).

Penghargaan terhadap hasil kerja pegawai, seperti piagam penghargaan, piala, medali, maupun bentuk kesejahteraan lainnya, pada umumnya masih rendah dan kurang mendapatkan perhatian dari pimpinan. Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa pemberian reward yang tidak memadai dapat

berdampak pada menurunnya prestasi kerja, produktivitas, motivasi, kepuasan kerja, serta kinerja pegawai. Bahkan, kondisi tersebut dapat menyebabkan pegawai yang memiliki potensi baik memilih keluar dari suatu organisasi.

Untuk menciptakan sistem manajemen kinerja yang efektif, peran manajer sangat penting. Salah satu tanggung jawab manajer adalah memberikan umpan balik terhadap kinerja pegawai melalui pemberian reward atau penghargaan nonfinansial kepada perawat (Pundi et al., 2020). Pemberian penghargaan tersebut dapat meningkatkan rasa senang perawat terhadap pekerjaannya sekaligus mendorong peningkatan performa kerja. Selain itu, adanya reward mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai. Hal ini juga dapat berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dan produktivitas kerja perawat, khususnya dalam pelaksanaan pendokumentasian keperawatan.

4. Penyusunan Pedoman

Melalui dokumentasi, perawat dapat menyampaikan hasil pengkajian, keputusan klinis, tindakan keperawatan, serta hasil dari tindakan yang telah diberikan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama dokumentasi keperawatan adalah membentuk basis data atau rekam medis yang mencatat seluruh pengalaman klien selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Dokumentasi tersebut menggambarkan secara jelas tindakan yang dilakukan perawat kepada klien dan menjadi bagian dari dokumentasi interprofesional dalam penyusunan rekam medis klien secara menyeluruh (Rahmi, 2022).

Beberapa manfaat dokumentasi keperawatan dalam proses keperawatan antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi klien, memperoleh pelayanan keperawatan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Asuhan keperawatan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan klien melalui proses pengkajian data, perumusan masalah yang tepat, penetapan diagnosis keperawatan yang akurat, penyusunan rencana tindakan yang terarah, pelaksanaan tindakan sesuai rencana, serta evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan.
- b. Bagi tenaga kesehatan, proses keperawatan dapat meningkatkan kemandirian tenaga keperawatan dalam melaksanakan asuhan keperawatan sehingga tidak bergantung pada profesi lain. Selain itu, proses ini juga memberikan kepuasan kerja yang optimal bagi perawat yang berhasil melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik.

- c. Bagi institusi, pelayanan kesehatan juga memperoleh berbagai manfaat, seperti meningkatnya kepuasan klien, proses penyembuhan yang lebih cepat, serta terciptanya pelayanan yang bermutu yang sekaligus dapat menjadi sarana promosi bagi institusi tersebut. Dengan demikian, tingkat kesembuhan klien dapat meningkat, keuntungan institusi bertambah, dan citra institusi di mata masyarakat menjadi lebih baik.

Dokumentasi keperawatan memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai bukti kualitas asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien.
- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban etik dan legal dalam praktik keperawatan.
- c. Sebagai sumber informasi untuk perlindungan individu, baik pasien maupun tenaga kesehatan.
- d. Sebagai bukti penerapan standar praktik keperawatan dalam pelayanan kesehatan.
- e. Sebagai sumber informasi statistik, keuangan, pendidikan, serta penelitian keperawatan.
- f. Sebagai sarana komunikasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan antar tenaga kesehatan.
- g. Sebagai sumber data dalam perencanaan pelayanan kesehatan di masa mendatang.

Prinsip-prinsip dokumentasi yang baik meliputi: (Marini & Edelstein, 2020)

- a. Akuntabilitas

Dokumentasi harus menggambarkan tindakan serta keputusan yang dilakukan oleh perawat sehingga setiap catatan dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Kejelasan

Informasi yang ditulis harus jelas, mudah dipahami, menggunakan bahasa yang baku, serta tidak menimbulkan makna ganda.

- c. Kepatuhan terhadap standar

Dokumentasi perlu disusun sesuai dengan standar nasional, seperti ketentuan dari BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, maupun kebijakan yang berlaku di institusi pelayanan kesehatan.

- d. Kerahasiaan

Seluruh informasi pasien wajib dijaga kerahasiaannya dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

e. Informatif

Catatan dokumentasi harus memuat seluruh informasi penting terkait kondisi pasien, tindakan atau intervensi yang diberikan, serta hasil evaluasi. Informasi ini bermanfaat untuk kelanjutan perawatan dan dapat dijadikan bukti dalam aspek hukum.

f. Ketepatan waktu

Dokumentasi harus dibuat dan diperbarui secara tepat waktu agar informasi yang tersedia tetap relevan, lengkap, dan akurat.

Namun, beberapa institusi pelayanan kesehatan masih belum menyediakan format dokumentasi keperawatan yang memadai, salah satunya karena pertimbangan biaya operasional. Padahal, keberadaan format dokumentasi yang standar sangat penting dalam mendukung kelengkapan catatan pelayanan keperawatan

5. Tim Supervisi Dokumentasi

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga terus meningkat. Masyarakat menuntut pelayanan yang berkualitas, aman, dan komprehensif dari seluruh tenaga kesehatan, termasuk perawat. Pelayanan keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional yang diwujudkan melalui pemberian asuhan keperawatan yang bermutu, tindakan pengobatan, serta rasa aman dan nyaman bagi pasien, keluarga, maupun masyarakat (Dahlia et al., 2020).

Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan adalah melalui pelaksanaan supervisi. Supervisi merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam manajemen yang mencakup proses komunikasi, berpikir kritis, pemberian motivasi, arahan, pemahaman, serta pengetahuan mengenai ruang lingkup praktik dan pekerjaan. Pelaksanaan supervisi yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perawat, baik dalam pemberian asuhan keperawatan maupun dalam pelaksanaan dokumentasi asuhan keperawatan (Priskila et al., 2024).

Tindakan keperawatan dapat dicatat maupun elektronik terkait data pasien, keputusan klinis, intervensi keperawatan, serta respons pasien yang tercantum dalam rekam kesehatan. Dokumentasi yang baik harus memenuhi beberapa aspek penting, seperti data yang akurat, benar, ringkas, lengkap, jelas, mudah dibaca, dan tetap menjaga kerahasiaan informasi pasien. Untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam pendokumentasian keperawatan, diperlukan peran first line manager dalam melakukan pengawasan terhadap proses dokumentasi melalui kegiatan supervise (Priskila et al., 2024).

Supervisi merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengarahkan perawat agar dapat bekerja secara efektif, efisien, terukur, serta meminimalkan risiko kerja (Ujjana et al., 2024). Selain itu, supervisi juga merupakan suatu proses untuk menentukan pekerjaan yang telah dilakukan, melakukan penilaian, serta mengoreksi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Talibo & Yahya, 2025). Supervisi bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
- b. Memberikan orientasi kepada staf dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
- c. Melatih staf agar mampu melaksanakan asuhan keperawatan dengan baik dan benar.
- d. Meningkatkan kemampuan perawat pelaksana dalam memberikan asuhan keperawatan.
- e. Meningkatkan kemampuan perawat pelaksana dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan.

Menurut (Umar et al., 2022) tujuan supervisi adalah memberikan bantuan secara langsung kepada bawahan sehingga mereka memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik. Dalam praktik keperawatan, supervisi berperan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja perawat. Perawat juga dituntut untuk segera mendokumentasikan asuhan keperawatan setelah melakukan interaksi dengan pasien. Dokumentasi keperawatan merupakan proses pencatatan mengenai respons pasien terhadap pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan sistematis.

Supervisi yang dilakukan dengan baik memiliki berbagai manfaat (Dahlia et al., 2020), antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi kerja perawat.
- b. Membantu perawat dalam proses transisi peran.
- c. Meningkatkan kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf, serta menciptakan hubungan dan suasana kerja yang lebih harmonis.
- e. Mengurangi stres emosional dan kelelahan kerja.
- f. Meningkatkan kesadaran diri, rasa percaya diri, harga diri, serta tanggung jawab.
- g. Meningkatkan retensi atau keberlangsungan kerja perawat.
- h. Mengurangi pemborosan sumber daya, baik tenaga, barang, maupun fasilitas.

- i. Menekan biaya pengembangan profesional dan biaya administrasi.
- j. Meningkatkan kepuasan kerja perawat.

Supervisi merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen keperawatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mengarahkan, serta membimbing perawat pelaksana agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Seorang manajer perlu memperhatikan beberapa aspek agar kualitas pendokumentasian keperawatan dapat terlaksana dengan baik, antara lain pengetahuan mengenai tugas yang akan dilakukan, keterampilan yang sesuai dengan standar, sikap, empati, kejujuran, serta penghargaan terhadap pekerjaan. Supervisi keperawatan yang dilakukan oleh kepala ruangan mampu meningkatkan kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan (Wahyuliati & Novita, 2023).

Supervisi memiliki peranan penting dalam meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan keperawatan serta kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan (Dahlia et al., 2020). Sebaliknya, supervisi yang tidak dilakukan secara tepat dapat menimbulkan counterproductive work behavior (CWB), kelelahan kerja, kecenderungan menghindari umpan balik, maupun perilaku lain yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan kerja.

D. Referensi

-
- Arifin, R., Kurniawan, D., & Sari, R. (2021). Pengaruh pelatihan berbasis simulasi terhadap kompetensi komunikasi perawat di puskesmas. *Jurnal Kesehatan Prima*, 15(2), 123–130. <https://doi.org/10.31290/jkp.v15i2.2301>
- Arika, R. R., Dr. Windu Santoso, M. K., & Emyk Windartik, S.Kep.Ns., M. K. (2021). *The Relationship of Provision of Non-Financial Rewards with Nurse Performance at Masyithoh Islamic Hospital Bangil Pasuruan*. <https://https://repositori.ubs-ppni.ac.id/>
- Bunting. (2022). Strategies to Improve Compliance with Clinical Nursing Documentation in Acute Hospitals : A Systematic Review. *Journal of Clinical Nursing*.
- Dahlia, A. I., Novieastari, E., Kp, S., Afriani, T., Kp, S., & Kep, M. (2020). Supervisi Klinis Berjenjang Sebagai Upaya Pemberian Asuhan Keperawatan yang Aman Terhadap Pasien. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, July. <https://doi.org/10.20527/dk.v8i2.7757>
- Fariz, M., Setiadi, P. B., & Rahayu, S. (2025). Pengaruh Disiplin, Motivasi Kerja, dan Analisis Beban Kerja (ABK) Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus : KPP Pratama Gresik. *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 6(1), 63-74. <https://doi.org/10.35912/simo.v6i1.3671>
- Fitriani, L., & Santosa, B. (2021). Peningkatan keterampilan komunikasi terapeutik

dengan metode role playing pada siswa asisten keperawatan SMK Muhammadiyah Lumajang. *PeTeKa*.

- Jefferies, D. (2022). A ward-based writing coach program to improve the quality of nursing documentation. *Contemporary Nurse*.
- Kellett, P. L., Franklin, B. D., Pearce, S., & Benn, J. (2024). Resilience in nursing medication administration practice: a systematic review with narrative synthesis. *BMJ Open Quality*, 13(4). e002711
- Kielo- Viljamaa, E., Suhonen, R., & Jalonen, L. Stolt, M. (2022). Areas of nursing competence in acute wound care: A focus group study. *Collegian*, 29(1), 44–53.
- Kusumaningrum, P. R., Agustiningrum, R., & Sulistyowati, A. D. (2025). Strategi Optimalisasi Dokumentasi Keperawatan Melalui Peningkatan Motivasi Perawat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 169–176. <https://jurnal.jomparnd.com/index.php/jpabdi>
- Lufianti, A., & Keristiyani, K. (2023). Correlation between Nurse Motivation and the Quality of Nursing Care Documentation. *Genius Journal*, 4(2), 329–333. <https://doi.org/10.56359/gj.v4i2.302>
- Madu, C. S., Tahir, A., & Sudarsono. (2025). Optimalisasi Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. *Public Health and Safety International Journal*, 5(1), 36–41. <https://doi.org/DOI:10.55642>
- Marini, M., & Edelstein, R. A. (2020). *Legal and Ethical Issues in Nursing*.
- Maryati, Y. (2021). Evaluasi Penggunaan Electronic Medical Record Rawat Jalan Di Rumah Sakit Husada Dengan Technology Acceptance Model. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 9(2), 190. <https://doi.org/10.33560/jmiki.v9i2.374>
- Mikkonen, K., Tomietto, M., Cicolini, G., Kaucic, B. M., Filej, B., Riklikiene, O., & Kääriäinen, M. (2020). Development and testing of an evidence-based model of mentoring nursing students in clinical practice. *Nurse Education Today*, 85.
- Oka, M., Kamayani, A., Oka, P., Nurhesti, Y., & Suardana, I. W. (2023). Correlation between Nurses ' Behavior and Ability to Perform Fluid-and Electrolyte-Related Nursing Diagnoses. *Journal of A Sustainable Global South*, 7(2), 3–5. doi:10.24843/jsgs.2023.v07.i02.p04
- Priskila, I., Wulandari, R. Y., Elasari, Y., & Nugroho, T. A. (2024). HUBUNGAN SUPERVISI KEPALA RUANGAN DAN PENGETAHUAN PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEPERAWATAN BERDASARKAN 3S (SDKI, SIKI, SLKI) DENGAN MUTU ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANGAN RAWAT INAP RSUD JENDRAL AHMAD YANI METRO LAMPUNG. 8(3), 711–719. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jmm.v8i3.15908>

- Pundi, J., Mulyati, S., Rusmiwati, E., & Tasikmalaya, P. T. (2020). *Pemberian Kompensasi , Motivasi dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja*. 04(02). <https://doi.org/10.3%0D1575/jp.v4i2.181>
- Rahmi, U. (2022). *Dokumentasi Keperawatan*. Bumi Medika. <https://books.google.co.id/books?id=JzFaEAAAQBAJ>
- Rendana, Sri, M., & Utari, W. C. (2023). *Pelatihan 3S. Nursing Update*,. 34–45.
- Rumerung, C. L., Rumambi, M. F., Yoche, M. M., & Sara, P. (2022). *PELATIHAN TEKNIK COACHING PADA PERAWAT SUPERVISOR DAN APLIKASINYA DI RS X*. 1–9.
- Sari, Novita., Mediawati, A. S., & Yudianto, K. (2024). Use of the Technology Acceptance Model for Electronic Medical Records in Nursing Documentation: Scooping Review. *Indonesian Journal of Global Health Research*, 6(4), 1953–1962. <https://doi.org/10.37287/ijghr.v6i4.3373>
- Septiani, S., Munir, S., Lestari, D., Ramadhi, R., Chakim, M., Lazuardini, A. D., Sudrajat, Y., Annas, M., B., D., H., Noerhatini, P., Ernawati, E., Sirojudin, H., Wahida, A., Maulidizen, A., Nurzaman, F., & Pustaka, S. (2024). *Manajemen Pelatihan dan Pengembangan Karyawan*.
- Shafiee, M., Shanbehzadeh, M., Nassari, Z., & Kazemi-Arpanahi, H. (2022). Development and evaluation of an electronic nursing documentation system. *Bmc Nursing*, 21, 1–12.
- Sindi, Sri, M., & Utari, W. C. (2024). Kelengkapan Pendokumentasian. *Jurnal Ilmu Kesehatan & Keperawatan*, 2(2), 67–77.
- Talibo, N. A., & Yahya, I. M. (2025). Hubungan Supervisi Kepala Ruangan dengan Kinerja Perawat dalam Pendokumentasian Asuhan Keperawatan di Ruangan IGD RSUD Kota Kotamobagu. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 8(2). <https://doi.org/10.57214/jka.v8i2.669>
- Tomas, N., & Kamati, L. N. (2024). Registered Nurses' Knowledge of Intravenous Fluid Therapy at a Teaching Hospital in Namibia: A Cross- Sectional Survey. *SAGE Open Nursing*, 10. 23779608241272607
- Ujiana, S., Hastuti, L., & Jiu, C. kim. (2024). PENGARUH SUPERVISI KLINIS KEPERAWATAN TERHADAP KINERJA PERAWAT PELAKSANA: A LITERATURE REVIEW. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*, 15(1), 13–19. <https://doi.org/10.54630/jk2.v15i1.323>
- Umar, E., Herawati, T., Widyawati, S., Maryani, L., & Rahmayanti. (2022). *Buku Ajar Manajemen S1 Keperawatan Jilid II*. Jakarta: Mahakarya Cipta Utama.
- Wahyuliati, T., & Novita, R. V. (2023). The Effectiviness of Training and Supervision on Improving the Quality of Nursing Care Documentation : Literatur Review. *The Indonesian Journal of Health Promotion*, 6(7), 1250–1258. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i7.3459>

- Wahyuningtyas, E. S. (2025). Your patients need your patience: A closer look at wound care. *Journal of Holistic Nursing Science*, 12(2), 165–171.
- Wisuda, A. C., & Suraya, C. (2024). *Implementasi 3s (sdki, siki, slki) dalam pelayanan keperawatan di ruang rawat inap*. 45–53. <https://jurnal.stik-sitikhadijah.ac.id/>
- Wulandari, Ardianti, & Pasaribu, J. (2022). Electronic Health Record Dalam Pelaksanaan Handover Keperawatan Di Rumah Sakit Jakarta. *I Care Jurnal Keperawatan STIKes Panti Rapih*. doi: <https://doi.org/10.46668/jurkes.v3i2.215>
- Wulandari, S., & Nuraini, T. (2023). Kompetensi tenaga kesehatan di puskesmas pasca pelatihan manajemen pelayanan primer. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 11(2), 98–106. <https://doi.org/10.35842/jaki.v11i2.699>
- Yasma, N. P., Farma, D., Aufa, A., Sari, V. N., Raya, J., Begalung, L., Begalung, L., Xx, N., Begalung L., K., & Padang, K. (2024). *Strategi Peningkatan Produktivitas Kinerja Karyawan Pada Franchise*. 4.
- Yuwanto, M. A., & Prasetyo, R. E. (2023). Implementation of Nursing Care Documentation Based on Indonesian Nursing Care Standards (SDKI, SLKI, and SIKI) in Hospitals. *Blambangan Journal of Community Services*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.61666/bjcs.v1i1.3>

E. Glosarium

3S (SDKI, SIKI, dan SLKI)

SDKI (Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia)

SIKI (Standar Intervensi Keperawatan Indonesia)

SLKI (Standar Luaran Keperawatan Indonesia)

SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

CHAPTER 6

EVALUASI EFEKTIVITAS SUPERVISI KLINIK TERHADAP MUTU ASUHAN KEPERAWATAN

Ns. Nevi Kusiana Lesmana, M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menentukan mutu pelayanan rumah sakit. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki interaksi paling lama dengan pasien sehingga kualitas pelayanan keperawatan sangat memengaruhi keselamatan pasien, kepuasan pasien, serta keberhasilan proses penyembuhan (Potter et al., 2021). Oleh karena itu, peningkatan mutu asuhan keperawatan menjadi prioritas penting dalam pengelolaan pelayanan kesehatan modern.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, supervisi klinik memiliki peran strategis sebagai bagian dari fungsi manajemen keperawatan. Supervisi klinik merupakan proses pembinaan profesional yang dilakukan secara sistematis oleh kepala ruangan atau supervisor kepada perawat pelaksana untuk memastikan pelayanan keperawatan diberikan sesuai standar profesi, standar operasional prosedur (SOP), evidence-based practice, dan prinsip keselamatan pasien (Marquis & Huston, 2017).

Menurut World Health Organization, mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat pelayanan yang mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil kesehatan yang diharapkan dan sesuai dengan pengetahuan profesional terkini (World Health Organization [WHO], 2021). Dalam konteks pelayanan keperawatan, mutu pelayanan tercermin dari kemampuan perawat dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, tepat waktu, berpusat pada pasien, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Supervisi klinik tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas pengawasan, tetapi juga sebagai sarana edukasi, mentoring, coaching, monitoring, dan evaluasi terhadap praktik pelayanan keperawatan. Supervisi klinik yang efektif membantu meningkatkan kompetensi perawat, kualitas dokumentasi keperawatan, kepatuhan terhadap SOP, serta implementasi patient safety dalam pelayanan kesehatan (American Nurses Association [ANA], 2021).

Penelitian Huslianti (2025) menunjukkan bahwa supervisi klinik yang dilakukan secara terstruktur mampu meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan kinerja perawat secara signifikan. Selain itu, penelitian Rahayu (2025) menjelaskan bahwa penerapan supervisi model Proctor efektif meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, komunikasi terapeutik, dan kepuasan pasien di rumah sakit.

Mutu pelayanan keperawatan juga dipengaruhi oleh efektivitas evaluasi supervisi klinik. Evaluasi supervisi dilakukan untuk menilai sejauh mana supervisi mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui indikator mutu seperti kepatuhan terhadap standar pelayanan, kualitas dokumentasi, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien (Donabedian, 1988). Dengan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, rumah sakit dapat mengidentifikasi kelemahan pelayanan dan melakukan perbaikan mutu secara tepat.

Namun, implementasi supervisi klinik dalam praktik pelayanan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban kerja perawat, kurangnya kompetensi supervisor, dokumentasi yang belum optimal, serta lemahnya sistem monitoring menjadi hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinik (Farid & Irma, 2024). Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas supervisi dan berdampak pada penurunan mutu pelayanan keperawatan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan penerapan evidence-based practice juga mendorong perubahan dalam sistem supervisi klinik. Penggunaan supervisi berbasis digital dan dokumentasi elektronik memungkinkan monitoring pelayanan dilakukan secara lebih objektif, cepat, dan terintegrasi. Penelitian Ernawati (2024) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi supervisi berbasis digital mampu meningkatkan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan dan efektivitas monitoring pelayanan secara signifikan.

Dalam pelayanan kesehatan modern, kepala ruangan sebagai supervisor klinik dituntut memiliki kemampuan leadership, komunikasi interpersonal, manajemen mutu, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi pelayanan kesehatan. Kepemimpinan yang efektif sangat penting dalam menciptakan budaya mutu pelayanan dan budaya keselamatan pasien di rumah sakit (Cummings et al., 2021).

Bab ini akan membahas secara komprehensif mengenai evaluasi efektivitas supervisi klinik terhadap mutu asuhan keperawatan, meliputi indikator mutu pelayanan keperawatan, metode evaluasi supervisi klinik, efektivitas supervisi dalam meningkatkan mutu pelayanan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas supervisi, hambatan dalam evaluasi supervisi klinik, strategi optimalisasi supervisi

klinik, serta implikasi supervisi klinik terhadap peningkatan mutu pelayanan keperawatan. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya supervisi klinik sebagai strategi peningkatan mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit.

B. Indikator Mutu Asuhan Keperawatan

Indikator mutu asuhan keperawatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan keperawatan dalam mencapai standar profesional, keselamatan pasien, efektivitas pelayanan, serta kepuasan pasien. Dalam konteks supervisi klinik, indikator mutu digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana supervisi mampu meningkatkan kualitas praktik keperawatan di ruang rawat.

Menurut World Health Organization, mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat pelayanan yang mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil kesehatan yang diinginkan sesuai standar profesional berbasis bukti ilmiah (World Health Organization [WHO], 2021). Model evaluasi mutu pelayanan kesehatan yang paling banyak digunakan adalah model Donabedian yang membagi indikator mutu menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur (*structure*), proses (*process*), dan hasil (*outcome*) (Donabedian, 1988).

1. Indikator Struktur (*Structure Indicators*)

Indikator struktur merupakan indikator yang menggambarkan kesiapan organisasi dalam menyediakan pelayanan keperawatan. Struktur mencakup sumber daya manusia, fasilitas, kebijakan, sistem organisasi, dan sarana pendukung pelayanan kesehatan (Donabedian, 1988).

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Keperawatan

Ketersediaan tenaga keperawatan yang sesuai standar menjadi indikator penting mutu pelayanan. Rasio perawat terhadap pasien sangat memengaruhi kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan pasien. Beban kerja yang tinggi akibat kekurangan tenaga perawat dapat meningkatkan risiko kesalahan tindakan, burnout, dan penurunan kualitas pelayanan (Marquis & Huston, 2017).

Penelitian oleh Aiken et al. (2018) menunjukkan bahwa jumlah tenaga keperawatan yang adekuat berhubungan signifikan dengan penurunan mortalitas pasien dan peningkatan keselamatan pasien.

b. Kompetensi Perawat

Kompetensi perawat meliputi kemampuan pengetahuan, keterampilan klinis, komunikasi, berpikir kritis, dan profesionalisme. Kompetensi menjadi indikator utama mutu pelayanan karena menentukan kemampuan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman dan efektif (Potter et al., 2021).

Supervisi klinik berperan penting dalam meningkatkan kompetensi melalui coaching, mentoring, dan evaluasi praktik klinik.

c. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP menjadi pedoman praktik pelayanan yang memastikan tindakan keperawatan dilakukan secara konsisten dan sesuai standar profesional. Supervisi klinik membantu memastikan implementasi SOP berjalan dengan baik di ruang rawat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

d. Fasilitas dan Sarana Pelayanan

Ketersediaan fasilitas yang memadai seperti alat kesehatan, sistem dokumentasi elektronik, ruang tindakan, dan teknologi informasi turut menentukan kualitas pelayanan keperawatan. Rumah sakit dengan fasilitas yang baik cenderung memiliki mutu pelayanan lebih tinggi karena mendukung efektivitas pelayanan klinik (WHO, 2021).

2. Indikator Proses (*Process Indicators*)

Indikator proses menggambarkan bagaimana pelayanan keperawatan diberikan kepada pasien. Fokus utama indikator proses adalah kepatuhan terhadap standar praktik keperawatan dan kualitas pelaksanaan asuhan keperawatan.

a. Pelaksanaan Proses Keperawatan

Proses keperawatan terdiri dari:

- 1) Pengkajian
- 2) Diagnosis keperawatan
- 3) Perencanaan
- 4) Implementasi
- 5) Evaluasi

Kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan proses keperawatan menjadi indikator penting mutu pelayanan (Potter et al., 2021).

Supervisi klinik membantu memastikan setiap tahap proses keperawatan dilakukan sesuai standar profesi dan evidence-based practice.

b. Kepatuhan terhadap SOP dan Clinical Pathway

Kepatuhan terhadap SOP mencerminkan disiplin profesional dan kualitas pelayanan klinik. Supervisi yang efektif mampu meningkatkan kepatuhan

perawat terhadap SOP tindakan keperawatan, pencegahan infeksi, keselamatan pasien, dan prosedur pemberian obat (Farid & Irma, 2024).

Penelitian Wahyuliati dan Novita (2023) menunjukkan bahwa supervisi rutin meningkatkan kepatuhan perawat terhadap standar pelayanan keperawatan secara signifikan.

c. Komunikasi Terapeutik

Komunikasi terapeutik merupakan indikator mutu penting karena memengaruhi kepuasan pasien dan keberhasilan pelayanan kesehatan. Perawat yang memiliki komunikasi efektif mampu meningkatkan kenyamanan pasien, mengurangi kecemasan pasien, dan meningkatkan kepatuhan terapi (Potter et al., 2021). Kepala ruangan melalui supervisi klinik dapat mengevaluasi kemampuan komunikasi interpersonal perawat selama pelayanan.

d. Dokumentasi Asuhan Keperawatan

Dokumentasi merupakan bukti legal dan profesional pelayanan keperawatan. Dokumentasi yang baik harus lengkap, akurat, sistematis, tepat waktu, dan mudah dipahami (American Nurses Association, 2021). Audit dokumentasi menjadi bagian penting evaluasi supervisi klinik karena kualitas dokumentasi mencerminkan mutu pelayanan keperawatan. Menurut penelitian Ernawati (2024), supervisi klinik berbasis digital mampu meningkatkan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan secara signifikan melalui monitoring real-time dan audit elektronik.

e. Penerapan Patient Safety

Keselamatan pasien merupakan indikator utama mutu pelayanan kesehatan. Supervisi klinik membantu memastikan implementasi sasaran keselamatan pasien, meliputi:

- 1) Identifikasi pasien
- 2) Komunikasi efektif
- 3) Keamanan obat
- 4) Pencegahan infeksi
- 5) Pencegahan risiko jatuh pasien

Kepatuhan terhadap patient safety menunjukkan kualitas pelayanan keperawatan yang profesional dan aman (WHO, 2021).

3. Indikator Hasil (*Outcome Indicators*)

Indikator hasil menggambarkan dampak pelayanan keperawatan terhadap kondisi pasien dan organisasi pelayanan kesehatan.

a. Kepuasan Pasien

Kepuasan pasien merupakan indikator outcome yang paling sering digunakan dalam evaluasi mutu pelayanan kesehatan. Faktor yang memengaruhi kepuasan pasien meliputi sikap perawat, kecepatan pelayanan, komunikasi terapeutik, dan empati perawat (Rahayu, 2025). Supervisi klinik yang efektif mampu meningkatkan perilaku caring dan profesionalisme perawat sehingga meningkatkan kepuasan pasien.

b. Penurunan Angka Insiden Keselamatan Pasien

Indikator outcome patient safety meliputi:

- 1) Penurunan medication error
- 2) Penurunan patient fall
- 3) Penurunan infeksi nosokomial
- 4) Penurunan pressure injury

Supervisi klinik berperan penting dalam monitoring kepatuhan terhadap protokol keselamatan pasien sehingga mampu menurunkan angka insiden (WHO, 2021).

c. Lama Hari Rawat (*Length of Stay*)

Mutu pelayanan yang baik dapat mempercepat proses penyembuhan pasien sehingga menurunkan lama rawat inap. Pelayanan keperawatan yang efektif membantu meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit (Donabedian, 1988).

d. Angka Kepatuhan Dokumentasi

Kelengkapan dokumentasi menjadi indikator outcome penting karena menunjukkan konsistensi penerapan standar pelayanan keperawatan.

e. Kepuasan Perawat

Supervisi yang suportif dapat meningkatkan:

- 1) Motivasi kerja
- 2) Kepuasan kerja
- 3) Loyalitas organisasi
- 4) Retensi tenaga keperawatan

Hal tersebut berdampak positif terhadap kualitas pelayanan keperawatan (Cummings et al., 2021).

4. Indikator Nasional Mutu Keperawatan di Rumah Sakit

Di Indonesia, indikator mutu pelayanan rumah sakit mengacu pada standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan standar akreditasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Beberapa indikator mutu keperawatan yang umum digunakan di rumah sakit meliputi:

- a. Kepatuhan identifikasi pasien
- b. Kepatuhan hand hygiene
- c. Kepatuhan penggunaan APD
- d. Angka kejadian pasien jatuh
- e. Kepatuhan dokumentasi keperawatan
- f. Response time pelayanan
- g. Kepuasan pasien
- h. Insiden keselamatan pasien

Indikator tersebut menjadi dasar evaluasi supervisi klinik dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan (KARS, 2022).

5. Peran Supervisi Klinik dalam Peningkatan Indikator Mutu

Supervisi klinik memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian indikator mutu pelayanan keperawatan melalui:

- a. Monitoring praktik klinik
- b. Pembinaan kompetensi perawat
- c. Audit mutu pelayanan
- d. Evaluasi dokumentasi
- e. Pemberian feedback
- f. Penguatan budaya patient safety

Kepala ruangan sebagai supervisor klinik memiliki tanggung jawab memastikan indikator mutu tercapai secara konsisten dan berkelanjutan (Marquis & Huston, 2017).

C. Metode Evaluasi Supervisi Klinik

Evaluasi supervisi klinik merupakan proses sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan supervisi dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan, kompetensi perawat, keselamatan pasien, dan kualitas pelayanan kesehatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan supervisi klinik tercapai serta mengidentifikasi hambatan dan strategi perbaikan dalam praktik keperawatan.

Menurut American Nurses Association, evaluasi dalam supervisi keperawatan bertujuan memastikan pelayanan keperawatan dilaksanakan sesuai standar profesi, evidence-based practice, serta prinsip keselamatan pasien (American Nurses Association [ANA], 2021). Evaluasi supervisi klinik juga menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan.

Dalam praktik manajemen keperawatan, metode evaluasi supervisi klinik harus dilakukan secara objektif, terukur, sistematis, dan berkesinambungan.

Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir pelayanan, tetapi juga pada proses pelaksanaan supervisi, kompetensi perawat, dan kualitas interaksi profesional antara supervisor dengan perawat pelaksana.

1. Observasi Langsung (*Direct Observation*)

Observasi langsung merupakan metode evaluasi supervisi klinik yang paling sering digunakan dalam pelayanan keperawatan. Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik pelayanan yang dilakukan oleh perawat saat memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.

Melalui observasi langsung, kepala ruangan atau supervisor dapat menilai:

- a. Keterampilan klinik perawat
- b. Kepatuhan terhadap SOP
- c. Komunikasi terapeutik
- d. Penerapan patient safety
- e. Ketepatan tindakan keperawatan
- f. Penggunaan alat kesehatan

Observasi langsung memberikan gambaran nyata mengenai kualitas praktik keperawatan sehingga memungkinkan supervisor memberikan umpan balik secara cepat dan tepat. Menurut Marquis dan Huston (2017), observasi klinik efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan meningkatkan kualitas pelayanan melalui pembinaan langsung di area praktik.

- a. Keunggulan Observasi Langsung
 - 1) Menilai praktik nyata di lapangan
 - 2) Memberikan data objektif
 - 3) Memungkinkan feedback langsung
 - 4) Mengidentifikasi kesalahan secara cepat
- b. Kelemahan Observasi Langsung
 - 1) Membutuhkan waktu yang cukup lama
 - 2) Potensi bias penilaian supervisor
 - 3) Perawat dapat berubah perilaku saat diamati (*Hawthorne effect*)

Untuk meningkatkan objektivitas observasi, supervisor perlu menggunakan instrumen observasi yang terstandar dan berbasis indikator mutu pelayanan.

2. Audit Dokumentasi Keperawatan

Audit dokumentasi merupakan metode evaluasi yang dilakukan dengan meninjau kelengkapan, ketepatan, dan kualitas pencatatan asuhan keperawatan dalam rekam medis pasien. Dokumentasi keperawatan menjadi indikator penting mutu pelayanan karena:

- a. Merupakan bukti legal pelayanan
- b. Menunjukkan kualitas proses keperawatan
- c. Menjadi media komunikasi antar tenaga kesehatan
- d. Mendukung keselamatan pasien

Dalam audit dokumentasi, supervisor mengevaluasi:

- a. Kelengkapan pengkajian
- b. Ketepatan diagnosis keperawatan
- c. Kesesuaian intervensi
- d. Evaluasi tindakan
- e. Ketepatan waktu pencatatan
- f. Kepatuhan terhadap standar dokumentasi

Menurut penelitian Ernawati (2024), supervisi klinik berbasis digital mampu meningkatkan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan melalui monitoring elektronik dan audit real-time.

a. Jenis Audit Dokumentasi

1) Audit Retrospektif

Audit dilakukan setelah pasien pulang dengan meninjau dokumen rekam medis yang telah selesai.

2) Audit Konkuren

Audit dilakukan saat pasien masih dirawat sehingga supervisor dapat langsung memberikan koreksi dan pembinaan kepada perawat. Audit konkuren dinilai lebih efektif karena memungkinkan perbaikan pelayanan secara langsung.

3. Wawancara dan Feedback (*Interview and Feedback*)

Wawancara merupakan metode evaluasi yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara supervisor dengan perawat pelaksana untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, hambatan, dan kebutuhan dalam praktik klinik. Metode ini membantu supervisor memahami:

- a. Persepsi perawat terhadap supervisi
- b. Hambatan pelayanan
- c. Tingkat pemahaman SOP
- d. Kebutuhan pelatihan
- e. Tingkat motivasi kerja

Wawancara dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui pendekatan suportif dan reflektif. Feedback merupakan komponen penting dalam evaluasi supervisi klinik. Feedback yang efektif harus:

- a. Objektif

- b. Spesifik
- c. Konstruktif
- d. Tepat waktu
- e. Berorientasi solusi

Menurut Proctor (2010), feedback dalam supervisi klinik memiliki fungsi formatif dan restoratif yang membantu meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan dukungan emosional kepada perawat. Manfaat Feedback dalam Supervisi Klinik :

- a. Meningkatkan motivasi kerja
- b. Memperbaiki kesalahan praktik
- c. Mengembangkan kompetensi klinik
- d. Memperkuat komunikasi profesional
- e. Meningkatkan kepercayaan diri perawat

4. Penilaian Kinerja Perawat (*Performance Appraisal*)

Penilaian kinerja merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan pencapaian kerja perawat berdasarkan indikator tertentu. Penilaian kinerja dalam supervisi klinik biasanya meliputi:

- a. Kompetensi klinik
- b. Kepatuhan terhadap SOP
- c. Kualitas dokumentasi
- d. Komunikasi interpersonal
- e. Disiplin kerja
- f. Profesionalisme
- g. Penerapan patient safety

Penilaian kinerja dapat dilakukan menggunakan:

- a. Checklist kompetensi
- b. Skala penilaian (*rating scale*)
- c. Key Performance Indicators (KPI)
- d. Clinical performance evaluation

Menurut Potter et al. (2021), evaluasi kinerja penting untuk memastikan pelayanan keperawatan diberikan secara profesional dan sesuai standar praktik. Tujuan Penilaian Kinerja :

- a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan
- b. Menentukan pengembangan kompetensi
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan
- d. Memberikan penghargaan dan motivasi
- e. Mendukung pengembangan karier perawat

5. Peer Review dalam Supervisi Klinik

Peer review merupakan metode evaluasi yang dilakukan oleh sesama perawat profesional untuk menilai kualitas praktik keperawatan berdasarkan standar profesi. Metode ini bertujuan:

- a. Meningkatkan akuntabilitas profesional
- b. Mendorong budaya belajar
- c. Mengembangkan refleksi klinik
- d. Meningkatkan kualitas praktik profesional

Peer review efektif meningkatkan budaya kolaboratif dan pembelajaran bersama dalam pelayanan keperawatan. Namun demikian, metode ini membutuhkan budaya organisasi yang terbuka dan komunikasi profesional yang baik agar tidak menimbulkan konflik interpersonal.

6. Evaluasi Berbasis Indikator Mutu

Metode evaluasi supervisi klinik juga dapat dilakukan melalui pemantauan indikator mutu pelayanan keperawatan. Beberapa indikator yang sering digunakan meliputi:

- a. Kepatuhan hand hygiene
- b. Angka patient fall
- c. Angka infeksi nosokomial
- d. Kepatuhan identifikasi pasien
- e. Kepatuhan dokumentasi
- f. Medication error
- g. Kepuasan pasien

Evaluasi berbasis indikator mutu membantu rumah sakit mengukur efektivitas supervisi klinik secara kuantitatif dan berorientasi outcome. Menurut World Health Organization, indikator mutu pelayanan merupakan alat penting dalam monitoring keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

7. Refleksi Klinis (*Reflective Practice*)

Refleksi klinis merupakan metode evaluasi yang membantu perawat mengevaluasi pengalaman praktik klinik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Melalui refleksi, perawat dapat:

- a. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktik
- b. Mengevaluasi tindakan klinik
- c. Mengembangkan critical thinking
- d. Meningkatkan clinical reasoning

Supervisor berperan sebagai fasilitator dalam proses refleksi untuk membantu perawat menemukan solusi terhadap masalah klinik yang dihadapi. Pendekatan reflektif sangat penting dalam pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development*).

8. Evaluasi Supervisi Berbasis Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi kesehatan mendorong penggunaan sistem digital dalam evaluasi supervisi klinik. Beberapa bentuk supervisi digital meliputi:

- a. Electronic nursing documentation
- b. Dashboard mutu pelayanan
- c. Audit elektronik
- d. Monitoring real-time
- e. Aplikasi supervisi klinik

Pemanfaatan teknologi membantu meningkatkan:

- a. Efisiensi evaluasi
- b. Akurasi data
- c. Kecepatan monitoring
- d. Integrasi laporan mutu

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi supervisi klinik meningkatkan efektivitas monitoring pelayanan dan kualitas dokumentasi keperawatan (Ernawati, 2024).

9. Tantangan dalam Evaluasi Supervisi Klinik

Pelaksanaan evaluasi supervisi klinik sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

- a. Keterbatasan waktu supervisi
- b. Beban kerja tinggi
- c. Kurangnya jumlah supervisor
- d. Dokumentasi tidak lengkap
- e. Kurangnya pelatihan supervisor
- f. Resistensi staf terhadap evaluasi
- g. Keterbatasan teknologi informasi

Hambatan tersebut dapat memengaruhi objektivitas dan efektivitas evaluasi supervisi klinik.

10. Strategi Peningkatan Efektivitas Evaluasi Supervisi Klinik

Untuk meningkatkan efektivitas evaluasi supervisi klinik diperlukan beberapa strategi, yaitu:

- a. Pengembangan instrumen evaluasi terstandar
- b. Pelatihan supervisor klinik
- c. Penerapan evidence-based supervision
- d. Penguatan budaya mutu dan patient safety
- e. Integrasi teknologi digital
- f. Monitoring dan audit berkala
- g. Pemberian feedback konstruktif

Kepala ruangan sebagai supervisor memiliki peran penting dalam memastikan evaluasi dilakukan secara konsisten dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan. Metode evaluasi supervisi klinik merupakan komponen penting dalam peningkatan mutu asuhan keperawatan. Evaluasi dapat dilakukan melalui observasi langsung, audit dokumentasi, wawancara, penilaian kinerja, peer review, refleksi klinis, serta pemantauan indikator mutu pelayanan. Penggunaan metode evaluasi yang sistematis, objektif, dan berbasis evidence-based practice membantu meningkatkan kompetensi perawat, keselamatan pasien, kualitas dokumentasi, dan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

D. Efektivitas Supervisi Klinik dalam Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan

Supervisi klinik merupakan salah satu fungsi manajemen keperawatan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Supervisi klinik tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas pengawasan, tetapi juga sebagai proses pembinaan profesional yang bertujuan meningkatkan kompetensi perawat, kualitas pelayanan, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien. Dalam pelayanan kesehatan modern, mutu asuhan keperawatan menjadi indikator utama kualitas rumah sakit karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling lama berinteraksi dengan pasien. Oleh karena itu, efektivitas supervisi klinik sangat menentukan keberhasilan pelayanan keperawatan secara keseluruhan. Menurut World Health Organization, pelayanan kesehatan yang bermutu harus memenuhi prinsip aman, efektif, berpusat pada pasien, tepat waktu, efisien, dan adil (World Health Organization [WHO], 2021). Supervisi klinik menjadi mekanisme penting untuk memastikan seluruh prinsip tersebut diterapkan dalam praktik keperawatan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa supervisi klinik yang dilakukan secara sistematis, suportif, dan berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas asuhan

keperawatan secara signifikan melalui peningkatan kompetensi, kepatuhan terhadap standar pelayanan, dan budaya patient safety (Huslianti, 2025).

1. Efektivitas Supervisi Klinik terhadap Kompetensi Perawat

Kompetensi perawat merupakan faktor utama yang menentukan kualitas asuhan keperawatan. Kompetensi meliputi kemampuan pengetahuan, keterampilan klinik, komunikasi, critical thinking, clinical reasoning, dan profesionalisme. Supervisi klinik berfungsi sebagai sarana pembelajaran klinik yang membantu perawat meningkatkan kompetensi melalui:

- a. Coaching
- b. Mentoring
- c. Clinical teaching
- d. Evaluasi praktik klinik
- e. Refleksi profesional

Menurut Marquis dan Huston (2017), supervisi klinik yang efektif membantu perawat mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan klinis dan meningkatkan akuntabilitas profesional.

a. Peningkatan Pengetahuan Klinis

Melalui supervisi, kepala ruangan dapat memberikan pembinaan terkait:

- 1) Standar praktik terbaru
- 2) Evidence-based practice
- 3) Clinical pathway
- 4) Prosedur tindakan keperawatan

Perawat yang memperoleh supervisi rutin cenderung memiliki pemahaman klinik yang lebih baik dibandingkan perawat tanpa supervisi terstruktur.

b. Peningkatan Keterampilan Klinis

Supervisi memungkinkan supervisor mengidentifikasi kesalahan tindakan dan memberikan koreksi langsung terhadap keterampilan teknis perawat. Keterampilan yang sering dievaluasi meliputi:

- 1) Pemberian obat
- 2) Perawatan luka
- 3) Pemasangan infus
- 4) Tindakan aseptik
- 5) Monitoring pasien kritis

Penelitian Rahayu (2025) menunjukkan bahwa supervisi model Proctor efektif meningkatkan kemampuan klinik dan kepatuhan praktik profesional perawat.

c. Pengembangan Critical Thinking

Supervisi reflektif membantu perawat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi masalah klinik. Kemampuan critical thinking sangat penting untuk meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan dan keselamatan pasien.

2. Efektivitas Supervisi Klinik terhadap Kepatuhan Standar Pelayanan

Kepatuhan terhadap standar pelayanan merupakan indikator penting mutu asuhan keperawatan. Standar pelayanan mencakup:

- a. SOP keperawatan
- b. Clinical pathway
- c. Standar patient safety
- d. Kode etik profesi
- e. Standar dokumentasi

Supervisi klinik membantu memastikan bahwa seluruh tindakan keperawatan dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

a. Kepatuhan terhadap SOP Keperawatan

Supervisi rutin meningkatkan disiplin perawat dalam menerapkan SOP pelayanan klinik. Kepatuhan SOP sangat penting untuk:

- 1) Mencegah kesalahan tindakan
- 2) Menjamin keselamatan pasien
- 3) Menjaga konsistensi pelayanan
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan

Menurut Farid dan Irma (2024), ruang rawat dengan supervisi aktif memiliki tingkat kepatuhan SOP yang lebih tinggi dibandingkan ruang rawat dengan supervisi minimal.

b. Kepatuhan terhadap Sasaran Keselamatan Pasien

Supervisi klinik terbukti meningkatkan implementasi sasaran keselamatan pasien, seperti:

- 1) Ketepatan identifikasi pasien
- 2) Kepatuhan hand hygiene
- 3) Pencegahan risiko jatuh
- 4) Komunikasi efektif
- 5) Keamanan pemberian obat

Hal tersebut menunjukkan bahwa supervisi klinik memiliki kontribusi besar dalam menurunkan insiden keselamatan pasien.

3. Efektivitas Supervisi Klinik terhadap Kualitas Dokumentasi Keperawatan

Dokumentasi keperawatan merupakan bagian penting dari mutu pelayanan kesehatan karena berfungsi sebagai:

- a. Bukti legal pelayanan
- b. Media komunikasi profesional
- c. Sumber evaluasi mutu
- d. Dasar continuity of care

Dokumentasi yang tidak lengkap dapat meningkatkan risiko kesalahan pelayanan dan masalah hukum.

a. Peningkatan Kelengkapan Dokumentasi

Supervisi klinik membantu meningkatkan kualitas dokumentasi melalui:

- 1) Audit dokumentasi rutin
- 2) Monitoring kelengkapan pencatatan
- 3) Evaluasi proses keperawatan
- 4) Feedback terhadap kesalahan dokumentasi

Penelitian Ernawati (2024) menunjukkan bahwa supervisi berbasis digital mampu meningkatkan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan secara signifikan.

b. Peningkatan Ketepatan Dokumentasi

Melalui supervisi, kepala ruangan memastikan dokumentasi dilakukan secara:

- 1) Tepat waktu
- 2) Sistematis
- 3) Akurat
- 4) Sesuai standar profesi

Kualitas dokumentasi yang baik mencerminkan mutu pelayanan keperawatan yang profesional.

4. Efektivitas Supervisi Klinik terhadap Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Keselamatan pasien merupakan indikator utama mutu pelayanan rumah sakit. Supervisi klinik memiliki peran besar dalam membangun budaya keselamatan pasien melalui monitoring praktik pelayanan. Menurut World Health Organization, keselamatan pasien adalah kerangka kerja terorganisasi untuk mencegah kesalahan dan mengurangi risiko cedera dalam pelayanan kesehatan (WHO, 2021).

a. Penurunan Medical Error

Supervisi klinik membantu mengurangi:

- 1) Medication error
- 2) Kesalahan identifikasi pasien

- 3) Kesalahan tindakan keperawatan
- 4) Infeksi nosokomial
- 5) Patient fall

Monitoring langsung oleh supervisor memungkinkan kesalahan diidentifikasi dan dikoreksi secara cepat.

b. Penguatan Budaya Patient Safety

Supervisi yang suportif menciptakan budaya keselamatan melalui:

- 1) Komunikasi terbuka
- 2) Pelaporan insiden tanpa menyalahkan
- 3) Pembelajaran dari kesalahan
- 4) Evaluasi berkelanjutan

Budaya patient safety yang baik meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan pasien terhadap rumah sakit.

5. Efektivitas Supervisi Klinik terhadap Kepuasan Pasien

Kepuasan pasien merupakan indikator outcome mutu pelayanan keperawatan. Pasien yang puas cenderung:

- a. Memiliki kepercayaan tinggi terhadap pelayanan
- b. Lebih patuh terhadap terapi
- c. Memiliki pengalaman pelayanan yang positif

Supervisi klinik membantu meningkatkan kepuasan pasien melalui peningkatan kualitas pelayanan perawat.

a. Faktor yang Memengaruhi Kepuasan Pasien

- 1) Responsivitas pelayanan
- 2) Komunikasi terapeutik
- 3) Empati perawat
- 4) Ketepatan tindakan
- 5) Kecepatan pelayanan

Penelitian menunjukkan bahwa supervisi klinik yang efektif meningkatkan perilaku caring dan komunikasi terapeutik perawat sehingga meningkatkan kepuasan pasien (Rahayu, 2025).

6. Efektivitas Supervisi Klinik terhadap Motivasi dan Kepuasan Kerja Perawat

Supervisi klinik yang suportif tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan psikologis perawat. Menurut model Proctor, supervisi memiliki fungsi restoratif yang membantu mengurangi stres kerja dan burnout perawat (Proctor, 2010). Dampak Supervisi terhadap Perawat:

- a. Meningkatkan motivasi kerja

- b. Mengurangi burnout
- c. Meningkatkan kepuasan kerja
- d. Meningkatkan loyalitas organisasi
- e. Menurunkan turnover perawat

Cummings et al. (2021) menjelaskan bahwa kepemimpinan suportif dalam supervisi berhubungan positif dengan lingkungan kerja yang sehat dan peningkatan kualitas pelayanan.

7. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Supervisi Klinik

Efektivitas supervisi klinik dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Kompetensi Kepala Ruangan
Supervisor yang kompeten lebih mampu melakukan pembinaan dan evaluasi secara efektif.
- b. Beban Kerja Perawat
Beban kerja tinggi dapat menghambat pelaksanaan supervisi karena keterbatasan waktu.
- c. Dukungan Organisasi
Rumah sakit perlu menyediakan:
 - 1) Pelatihan supervisi
 - 2) SOP supervisi
 - 3) Sistem evaluasi
 - 4) Teknologi pendukung
- d. Budaya Organisasi
Budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka dan pembelajaran akan meningkatkan efektivitas supervisi klinik.

8. Tantangan Pelaksanaan Supervisi Klinik

Beberapa hambatan supervisi klinik meliputi:

- a. Keterbatasan SDM
- b. Kurangnya pelatihan supervisor
- c. Beban administrasi tinggi
- d. Resistensi staf
- e. Keterbatasan teknologi informasi

Hambatan tersebut dapat menurunkan efektivitas supervisi dan kualitas evaluasi pelayanan.

9. Strategi Peningkatan Efektivitas Supervisi Klinik

Untuk meningkatkan efektivitas supervisi klinik diperlukan:

- a. Pelatihan kepala ruangan
- b. Supervisi berbasis evidence-based practice
- c. Digitalisasi sistem supervisi
- d. Monitoring berkala
- e. Penguatan budaya patient safety
- f. Pemberian feedback konstruktif

Implementasi strategi tersebut membantu meningkatkan mutu pelayanan keperawatan secara berkelanjutan. Supervisi klinik terbukti efektif dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan melalui peningkatan kompetensi perawat, kepatuhan terhadap standar pelayanan, kualitas dokumentasi, keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan motivasi kerja perawat. Keberhasilan supervisi klinik sangat dipengaruhi oleh kompetensi kepala ruangan, dukungan organisasi, budaya kerja, dan sistem evaluasi yang efektif. Oleh karena itu, supervisi klinik harus dilaksanakan secara sistematis, suportif, dan berkelanjutan sebagai bagian penting dari strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

E. Referensi

-
- Aiken, L. H., Sloane, D., Griffiths, P., Rafferty, A. M., Bruyneel, L., McHugh, M., & Sermeus, W. (2018). Nursing skill mix in European hospitals: Cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. *BMJ Quality & Safety*, 26(7), 559–568. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005567>
- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Publishing.
- Cummings, G. G., Tate, K., Lee, S., Wong, C. A., Paananen, T., Micaroni, S. P. M., & Chatterjee, G. E. (2021). Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*, 85, 19–60. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2018.04.016>
- Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *Journal of the American Medical Association*, 260(12), 1743–1748. <https://doi.org/10.1001/jama.260.12.1743>
- Ernawati, E. (2024). Efektivitas aplikasi INSPECSI terhadap kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di rumah sakit. Jambi: Penerbit Akademik.
- Farid, M., & Irma, R. (2024). Analisis pelaksanaan supervisi di instalasi keperawatan rumah sakit. *Jurnal Prepotif*, 8(2), 112–120.
- Huslianti, R. L. (2025). Efektifitas penerapan program supervisi klinis terhadap peningkatan kualitas asuhan keperawatan dan kinerja perawat. *Journal of*

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar indikator mutu nasional rumah sakit. Jakarta: Kemenkes RI.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (2022). Standar nasional akreditasi rumah sakit edisi 1.1. Jakarta: KARS.
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2017). Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application (9th ed.). Wolters Kluwer.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). Fundamentals of nursing (11th ed.). Elsevier.
- Proctor, B. (2010). Training for the supervision alliance: Attitude, skills and intention. In J. Cutcliffe, K. Hyrkäs, & J. Fowler (Eds.), Routledge handbook of clinical supervision. Routledge.
- Rahayu, C. S. (2025). Efektivitas supervisi keperawatan model Proctor dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien di Rumah Sakit Sari Asih (Tesis). Universitas Islam Sultan Agung.
- Wahyuliati, T., & Novita, R. V. (2023). Efektivitas pelatihan dan supervisi terhadap peningkatan kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan: Literature review. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, 6(7), 1250–1258.
- Wahyuliati, T., & Novita, R. V. (2023). Efektivitas pelatihan dan supervisi terhadap peningkatan kualitas pendokumentasian asuhan keperawatan: Literature review. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, 6(7), 1250–1258
- World Health Organization. (2021). Global patient safety action plan 2021–2030. Geneva: World Health Organization.

F. Glosarium

A

Akreditasi Rumah Sakit: Proses penilaian terhadap mutu pelayanan rumah sakit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi untuk menjamin keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan.

Asuhan Keperawatan: Rangkaian pelayanan yang diberikan perawat kepada pasien melalui proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Audit Dokumentasi: Proses pemeriksaan dan penilaian terhadap kelengkapan, ketepatan, dan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan.

B

Burnout: Kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat tekanan kerja yang berkepanjangan.

C

Checklist Supervisi: Instrumen penilaian yang digunakan supervisor untuk mengevaluasi pelaksanaan tindakan dan mutu pelayanan keperawatan.

Clinical Pathway: Pedoman pelayanan klinik terintegrasi yang digunakan untuk mengatur tata laksana pasien berdasarkan standar evidence-based practice.

Clinical Reasoning: Kemampuan berpikir klinis dalam menganalisis kondisi pasien dan menentukan keputusan tindakan keperawatan secara tepat.

Clinical Teaching: Metode pembelajaran klinik yang dilakukan supervisor untuk meningkatkan kompetensi perawat melalui praktik langsung.

Coaching: Proses pembinaan yang dilakukan supervisor untuk membantu perawat meningkatkan kemampuan dan kinerja profesional.

Continuous Quality Improvement (CQI): Pendekatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan perbaikan sistem pelayanan.

D

Dokumentasi Keperawatan: Pencatatan seluruh tindakan dan proses asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien secara sistematis dan akurat.

E

Effectiveness (Efektivitas): Tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Electronic Nursing Documentation: Sistem dokumentasi keperawatan berbasis elektronik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan pelayanan.

Evidence-Based Practice (EBP): Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien.

Evaluasi Supervisi Klinik: Proses penilaian terhadap pelaksanaan supervisi klinik untuk mengetahui efektivitasnya dalam meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.

F

Feedback: Umpan balik yang diberikan supervisor kepada perawat terkait hasil evaluasi pelayanan atau praktik klinik.

H

Hand Hygiene: Prosedur kebersihan tangan untuk mencegah penyebaran infeksi dalam pelayanan kesehatan.

I

Indikator Mutu: Ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan.

Infeksi Nosokomial: Infeksi yang diperoleh pasien selama menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

K

Kepala Ruangan: Perawat manajer tingkat pertama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelayanan dan supervisi di ruang perawatan.

Keselamatan Pasien (*Patient Safety*): Sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan mencegah kesalahan dan cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan.

Kompetensi Perawat: Kemampuan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan profesionalisme yang dimiliki perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan.

Komunikasi Terapeutik: Komunikasi profesional antara perawat dan pasien yang bertujuan membantu proses penyembuhan pasien.

M

Medication Error: Kesalahan dalam proses pemberian obat yang dapat membahayakan pasien.

Mentoring: Proses pembimbingan profesional oleh supervisor kepada perawat untuk meningkatkan kemampuan klinik dan pengembangan karier.

Monitoring: Kegiatan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Mutu Pelayanan Keperawatan: Tingkat kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai standar profesi, keselamatan pasien, dan kebutuhan pasien.

O

Observasi Langsung: Metode evaluasi supervisi klinik dengan mengamati secara langsung praktik pelayanan keperawatan.

P

Patient-Centered Care: Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien.

Patient Fall: Kejadian pasien jatuh selama menjalani perawatan di rumah sakit.

Peer Review: Metode evaluasi profesional yang dilakukan oleh sesama tenaga keperawatan untuk menilai kualitas praktik klinik.

Performance Appraisal: Penilaian kinerja perawat berdasarkan indikator kompetensi dan mutu pelayanan.

Proses Keperawatan: Metode sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Proctor Model: Model supervisi klinik yang terdiri dari fungsi normatif, formatif, dan restoratif dalam pembinaan profesional perawat.

R

Reflective Practice: Pendekatan evaluasi melalui refleksi pengalaman klinik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan profesionalisme.

S

Standar Operasional Prosedur (SOP): Pedoman kerja yang digunakan sebagai standar pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Supervisi Klinik: Proses pembinaan profesional oleh supervisor kepada perawat pelaksana untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kompetensi klinik.

Supervisor Klinik: Perawat atau kepala ruangan yang bertanggung jawab melakukan supervisi, pembinaan, dan evaluasi pelayanan keperawatan.

T

Transformational Leadership: Gaya kepemimpinan yang mampu memotivasi, menginspirasi, dan meningkatkan kinerja staf melalui pendekatan suportif dan visioner.

PROFIL PENULIS



Ana Fadilah, S. Kep., Ns., M.Kep lahir di Surabaya pada 15 Mei 1976 merupakan seorang akademisi dan praktisi keperawatan yang memiliki pengalaman luas dalam bidang manajemen keperawatan dan pelayanan klinis. Pendidikan keperawatan ditempuh secara berjenjang dimulai dari Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Surabaya (1999), kemudian melanjutkan Sarjana Keperawatan dan profesi Ners di Universitas Airlangga Surabaya (2002), serta Magister Keperawatan di Universitas Diponegoro Semarang (2016). Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan doktoral (Ph.D) Keperawatan di National Taipei University of Nursing and Health Sciences (NTUNHS), Taiwan. Dalam perjalanan karier profesionalnya, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (2002–2010) serta memiliki pengalaman sebagai tenaga pendidik di berbagai institusi pendidikan keperawatan, antara lain STIKES Muhammadiyah Lamongan dan AKPER Pemda Lamongan. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen di ITEKES Cendekia Utama Kudus pada Program Studi Ners, serta terlibat dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah. Fokus keilmuan penulis meliputi manajemen keperawatan, supervisi klinis, keselamatan pasien, serta pelayanan paliatif sebagai bagian integral dari manajemen keperawatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis dan terminal melalui pendekatan holistik. Penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan berbasis evidence-based practice serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Penulis dapat dihubungi melalui email: ana.fadilah15@gmail.com

Motto: "Excellence in nursing through compassionate leadership and evidence-based care."

PROFIL PENULIS



Asih Purwandari Wahyoe Puspita, S.Kep., Ners., M.Kep.

adalah seorang dosen di Program Studi S1 Keperawatan dan profesi Ners, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. lahir di Bandung pada tanggal 23 Mei 1990. Riwayat pendidikan dimulai dari jenjang Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran, yang masing-masing diselesaikan pada tahun 2012 dan 2013. pendidikan

Magister Keperawatan Manajemen di institusi yang sama dan lulus pada tahun 2017. Sejak tahun 2014 hingga sekarang, aktif mengajar sebagai dosen di program studi DIII, S1 Keperawatan, dan prodi Profesi Ners di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan UPI pada tahun 2014 hingga sekarang. Selain ini penulis menjabat sebagai tim pengembangan akademik dan kurikulum program studi Keperawatan dan ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi Keperawatan FPOK UPI.

Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran, beliau mengampu berbagai mata kuliah, seperti Keperawatan Dasar, Praktik Klinik Keperawatan Dasar, Manajemen Keperawatan, Manajemen Keselamatan Pasien, Konsep Dasar Keperawatan, Metodologi Keperawatan, Kewirausahaan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis, serta Keterampilan Dasar Keperawatan. Penulis telah membuat buku ajar keperawatan dasar, manajemen keperawatan, metodologi keperawatan. buku referensi kesehatan terpadu berbasis Interprofesional.

Penulis dapat dihubungi melalui email: asihpurwandari@upi.edu atau asihpwp@upi.edu.

Motto: Man jadda wajada" (Barangsiapa bersungguh-sungguh, ia akan menemukannya).

Sesulit apapun jalannya, seruit apapun masalahnya, seberat apapun ujiannya.

Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah dekat..

PROFIL PENULIS



Ns. Novin Yetiani, S.Kep., M.Kep. Lahir di Sintang, 11 November 1986. Pendidikan tinggi telah ditempuh oleh penulis, yaitu jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners pada Program Studi Keperawatan STIKES BINAWAN Jakarta tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Penulis memiliki pengalaman sebagai Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Mitra Menteng Afia. Saat ini penulis bekerja di STIKes Kapuas Rya Sintang dengan homebase Program Studi Profesi Ners. Dan mengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai penulis buku, peneliti, pengabdian, dan publikasi ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail; novin.yetiani@gmail.com.

Motto: "Living your life well"



Ns. Ari Sukma Nela, S.Kep., M.Kep Lahir di Lolo, 07 Juli 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Akbid dan STIKes Alifah Padang Tahun 2010, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Pada Program Studi Magister Keperawatan Universitas Andalas dan lulus tahun 2020.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018, dimulai dengan karier profesionalnya sebagai perawat klinisi di RSUP Dr. M. Djamil Padang. Dan pada tahun 2023 hingga saat ini, penulis

bekerja sebagai Dosen di Prodi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia dan mengampu mata kuliah manajemen keperawatan, keperawatan bencana, dan keterampilan dasar dalam keperawatan. Di sela aktivitasnya mengajar, penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arisukmanela@umitra.ac.id

Motto: "Keberadaan manusia menemukan nilainya ketika mampu memberi manfaat bagi sesama"

PROFIL PENULIS



Armidayanti, S.Kep., Ners., M.Kep., Lahir di Binanga, 28 Desember 1996. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat tahun 2014 dan lulus pada tahun 2018. Lanjut pendidikan tahap Profesi pada Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat dan lulus tahun 2020. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Universitas Hasanuddin pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan dan lulus pada tahun 2023.

Saat ini penulis bekerja di Universitas Sulbar Manarang sebagai Dosen tetap pada Program Studi DIII Keperawatan, mengampu mata kuliah keperawatan medikal bedah dan keperawatan maternitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan pada Jurnal Keperawatan Nasional terakreditasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: armidayanti123@gmail.com
Motto: "Success is the fruit of patience and prayer"



Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep. Lahir di Cimahi, 06 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 di Universitas Pajajaran dan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 - 2000 sebagai perawat di UGD RS Dustira Cimahi. Saat ini penulis bekerja di Akademi Keperawatan Buntet Pesantren Cirebon mengampu

mata kuliah Manajemen Keperawatan, Etika dan Hukum Keperawatan, Pendidikan Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nevilesmana@gmail.com

Motto: "Allah Yang Maha Segalanya"

Sinopsis

Bunga Rampai "Peran Kepala Ruangan dalam Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan" membahas secara komprehensif pentingnya supervisi klinis dan manajemen keperawatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar manajemen keperawatan dan supervisi klinis, meliputi strategi penguatan manajemen, implementasi supervisi, program pelaksanaan, hambatan, serta evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana supervisi klinis menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas asuhan keperawatan, meningkatkan kompetensi perawat, dan mendukung keselamatan pasien di ruang pelayanan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan peran kepala ruangan dalam perencanaan pelayanan keperawatan, termasuk penyusunan visi dan misi ruangan, perencanaan strategis, manajemen risiko, budaya keselamatan pasien, pengembangan program mutu, hingga kolaborasi interprofesional. Buku ini juga membahas standar mutu asuhan keperawatan dan indikator kinerja perawat sebagai landasan dalam menilai efektivitas pelayanan. Berbagai upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan dan kinerja perawat dijelaskan untuk membantu kepala ruangan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan, dan pembinaan secara profesional.

Pada bagian berikutnya, buku ini mengupas hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap beserta dampaknya terhadap pelayanan keperawatan dan strategi untuk mengatasinya. Pembahasan dilanjutkan dengan strategi peningkatan kompetensi dan kepatuhan dokumentasi perawat sebagai bagian penting dalam mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit. Di bagian akhir, buku ini membahas evaluasi efektivitas supervisi klinik terhadap mutu asuhan keperawatan melalui indikator mutu dan metode evaluasi yang relevan. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, kepala ruangan, manajer keperawatan, dosen, perawat klinis, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memperkuat praktik supervisi klinis dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan secara berkelanjutan.

Bunga Rampai “Peran Kepala Ruangan dalam Supervisi Klinis untuk Meningkatkan Mutu Asuhan Keperawatan” membahas secara komprehensif pentingnya supervisi klinis dan manajemen keperawatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar manajemen keperawatan dan supervisi klinis, meliputi strategi penguatan manajemen, implementasi supervisi, program pelaksanaan, hambatan, serta evaluasi dan tindak lanjut berkelanjutan. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana supervisi klinis menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas asuhan keperawatan, meningkatkan kompetensi perawat, dan mendukung keselamatan pasien di ruang pelayanan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan peran kepala ruangan dalam perencanaan pelayanan keperawatan, termasuk penyusunan visi dan misi ruangan, perencanaan strategis, manajemen risiko, budaya keselamatan pasien, pengembangan program mutu, hingga kolaborasi interprofesional. Buku ini juga membahas standar mutu asuhan keperawatan dan indikator kinerja perawat sebagai landasan dalam menilai efektivitas pelayanan. Berbagai upaya peningkatan mutu asuhan keperawatan dan kinerja perawat dijelaskan untuk membantu kepala ruangan dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, pengawasan, dan pembinaan secara profesional.

Pada bagian berikutnya, buku ini mengupas hambatan dalam pelaksanaan supervisi klinis di ruang rawat inap beserta dampaknya terhadap pelayanan keperawatan dan strategi untuk mengatasinya. Pembahasan dilanjutkan dengan strategi peningkatan kompetensi dan kepatuhan dokumentasi perawat sebagai bagian penting dalam mutu pelayanan dan akreditasi rumah sakit. Di bagian akhir, buku ini membahas evaluasi efektivitas supervisi klinik terhadap mutu asuhan keperawatan melalui indikator mutu dan metode evaluasi yang relevan. Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa keperawatan, kepala ruangan, manajer keperawatan, dosen, perawat klinis, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memperkuat praktik supervisi klinis dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan secara berkelanjutan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-15-2 (PDF)



9

786347

756152